RESULTATS

Les résultats obtenus sont présentés selon les différents axes d'analyse définis dans la méthodologie. Ils permettent d'examiner l'évolution récente du cadre de régulation pharmaceutique marocain, puis de situer celui-ci au regard des référentiels internationaux retenus pour le benchmarking. Les résultats sont présentés ci-après de manière descriptive et analytique, leur interprétation critique étant développée dans la partie Discussion.

AXE 1 — Évolution récente du cadre de régulation pharmaceutique au Maroc

Partie 1 — La réforme de la libération officielle des lots de vaccins et de sérums à usage humain

1. Une réforme spécifique, antérieure à la loi n° 27-26

La réforme vaccinale ne procède pas de la loi n° 27-26 : elle résulte d'abord du décret-loi n° 2-24-728 du 27 septembre 2024, qui complète le code du médicament et de la pharmacie n° 17-04 par une section I bis et un nouvel article répressif. Le décret n° 2-24-729 du 30 septembre 2024 organise ensuite la procédure administrative. Les deux textes sont réunis dans le Bulletin officiel de traduction officielle n° 7340 du 3 octobre 2024, pp. 2329–2331 [1].

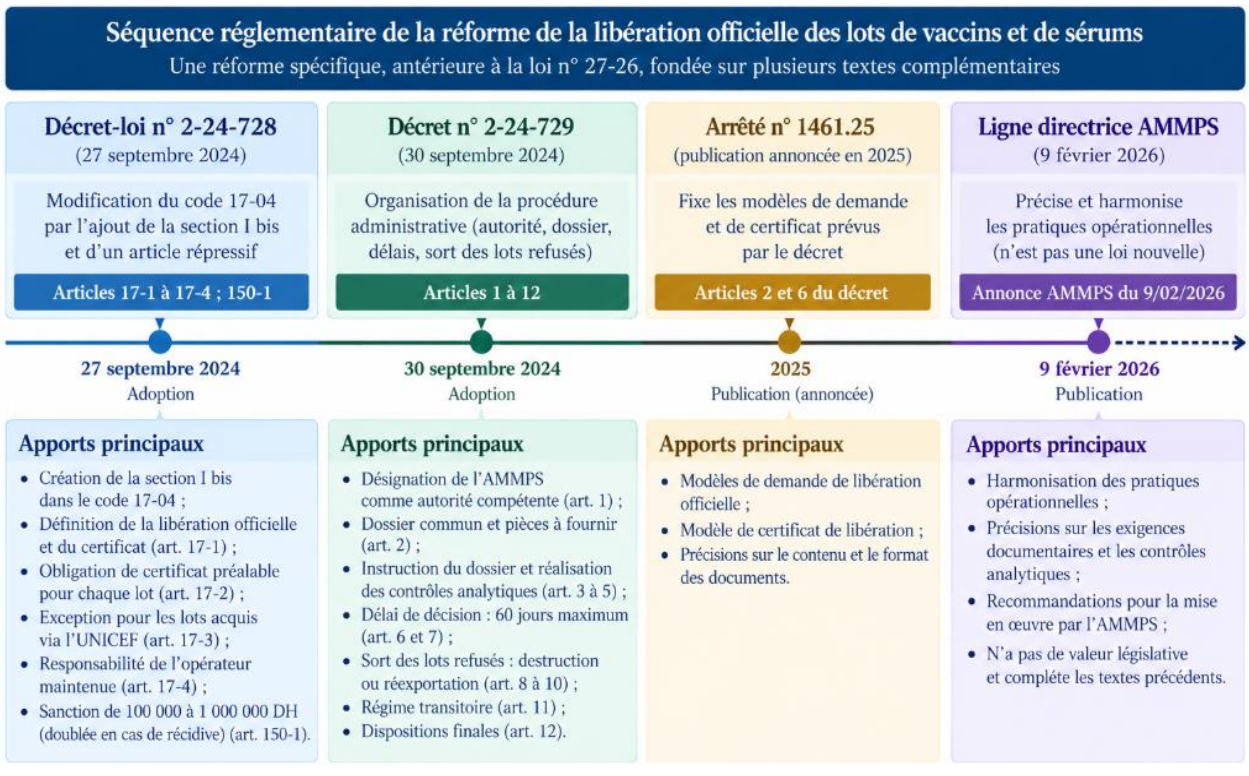


Figure 1 Chronologie des textes encadrant la libération officielle des lots de vaccins et de sérums

Cette séquence doit être distinguée des changements ultérieurs relatifs à la pharmacovigilance, aux AMM et au contrôle du marché issus de la loi n° 27-26.

L'enjeu réglementaire est précis : l'autorisation de mise sur le marché (AMM) concerne le médicament en tant que produit, tandis que la libération officielle vérifie, lot par lot, si un vaccin ou un sérum déjà couvert par une AMM peut être mis sur le marché. L'une ne remplace donc pas l'autre. Le dispositif crée une décision supplémentaire de l'autorité compétente avant commercialisation, fondée sur la revue des données de production et des résultats du contrôle de qualité [1, art. 17-1 et 17-2].

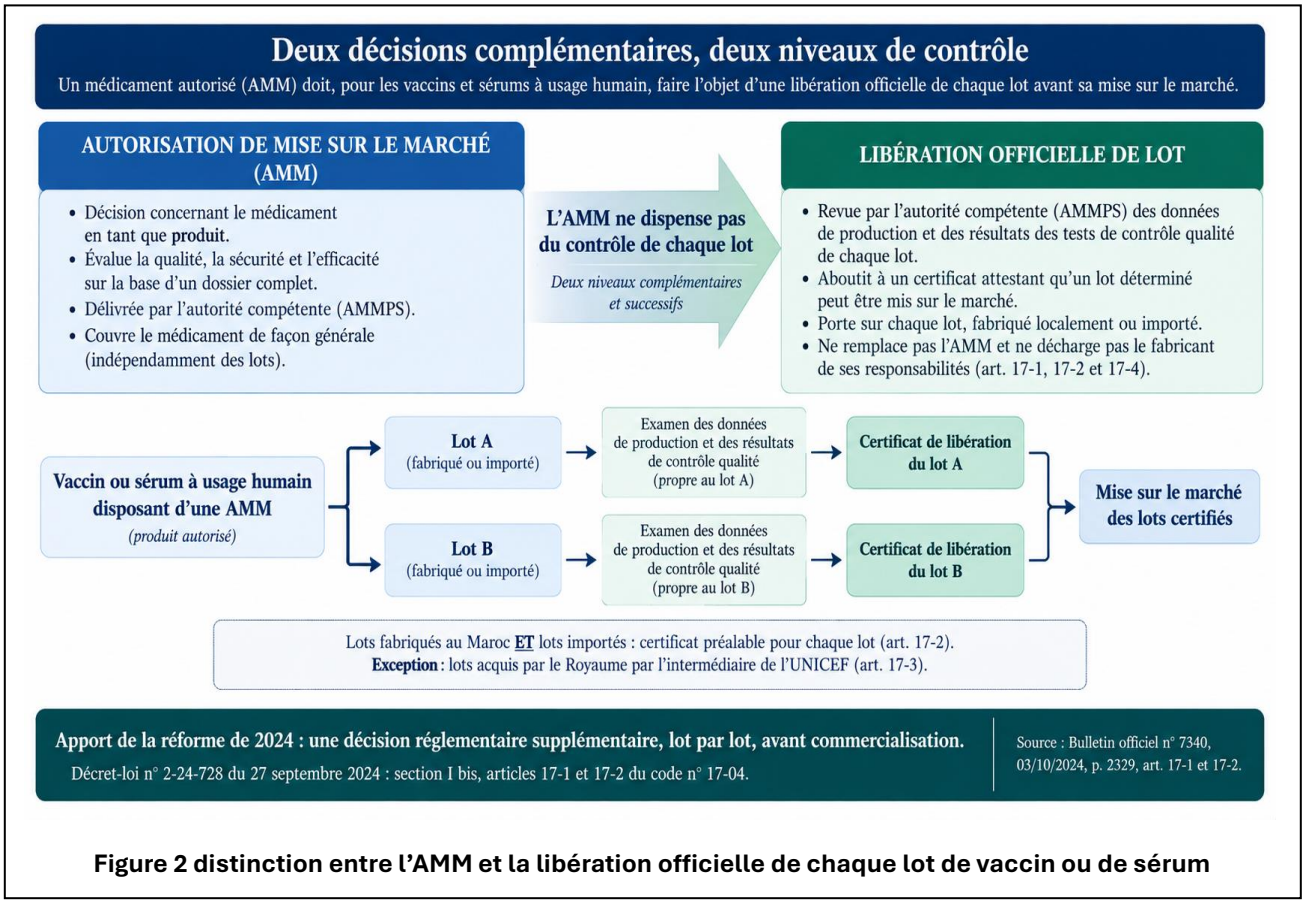


Figure 2 distinction entre l'AMM et la libération officielle de chaque lot de vaccin ou de sérum

2. Ce que le décret-loi n° 2-24-728 introduit réellement dans le code

- ***Article 17-1*** — deux définitions complémentaires. La libération officielle est la revue par l'autorité nationale compétente des données de production et des résultats des tests de contrôle de la qualité de chaque lot d'un vaccin ou sérum à usage humain ayant une AMM. Le certificat est l'acte qui atteste qu'un lot déterminé peut être mis sur le marché. Il ne faut pas confondre l'examen scientifique et documentaire (activité de contrôle) avec l'acte final de libération (décision administrative) [1, p. 2329]. 1 Axe 1 ·

- ***Article 17-2*** — obligation préalable et champ d'application. Tout lot de vaccin ou de sérum à usage humain, fabriqué localement ou importé, doit obtenir son certificat avant sa mise sur le marché par l'établissement pharmaceutique industriel concerné. Le caractère systématique porte sur chaque lot, non sur une seule autorisation globale accordée une fois pour toutes au fabricant. La loi renvoie au règlement pour la composition du dossier et les modalités de décision [1, p. 2329].
- ***Article 17-3*** — exception circonscrite. Sont dispensés du certificat les lots acquis par le Royaume du Maroc par l'intermédiaire de l'UNICEF. La dérogation est formulée en fonction du canal d'acquisition ; elle ne constitue ni une dispense générale pour les vaccins importés, ni une suppression de l'ensemble des obligations de qualité et de sécurité [1, p. 2329].
- ***Article 17-4*** — responsabilité conservée. La délivrance du certificat ne décharge pas l'établissement pharmaceutique industriel et/ou son pharmacien responsable de leurs obligations et responsabilités découlant du code et de ses textes d'application. Le contrôle public complète la responsabilité de l'opérateur ; il ne la transfère pas à l'AMMPS [1, p. 2329].
- ***Article 150-1*** — sanction ciblée. La mise sur le marché en violation du premier alinéa de l'article 17-2 est punie d'une amende de 100 000 à 1 000 000 DH, doublée en cas de récidive. Il s'agit de la sanction attachée à l'absence de certificat préalable ; il serait juridiquement incorrect de l'appliquer indistinctement à toute erreur documentaire ou à toute non-conformité de fabrication sans rechercher le fondement répressif correspondant [1, p. 2329].

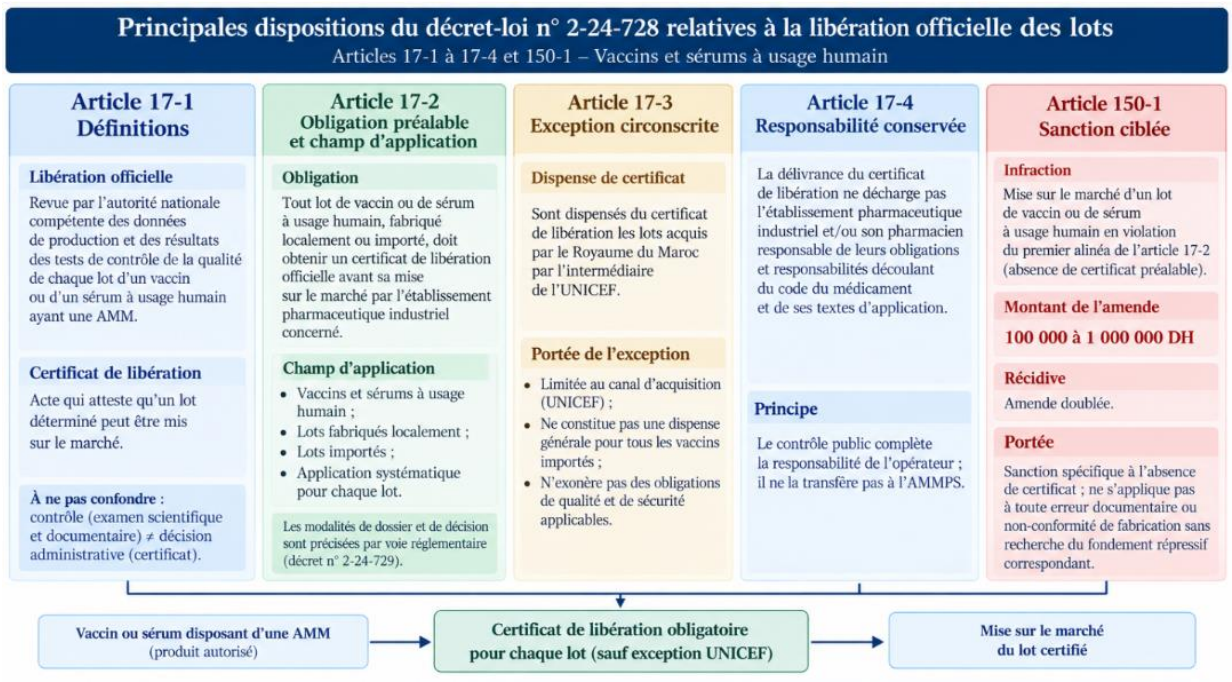


Figure 3 Les cinq dispositions du décret-loi n° 2-24-728 relatives à la libération officielle des lots

3. Le décret n° 2-24-729 : une procédure réglementaire complète

Autorité compétente (art. 1). Le décret désigne expressément l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS). Son article 11 avait prévu un régime transitoire confiant l'instruction à la direction du médicament et de la pharmacie et la délivrance au ministère chargé de la santé dans l'attente de l'entrée en vigueur de la loi n° 10-22. Ce passage transitoire ne doit pas être décrit comme l'organisation permanente du dispositif [1, pp. 2329–2330].

Dossier commun (art. 2). La demande, établie sur le modèle réglementaire, est signée par le pharmacien responsable. Elle s'accompagne du protocole récapitulatif de fabrication et de contrôle, des résultats des tests correspondants (ces deux ensembles étant signés et cachetés), des preuves relatives au transport et à la conservation, des références de l'AMM et de tout document complémentaire utile à l'instruction. Les échantillons du lot et les réactifs nécessaires accompagnent le dossier pour les besoins du contrôle analytique [1, pp. 2329–2330].

Pièces propres aux lots importés (art. 2). Le dossier comprend en plus le certificat de libération de l'autorité compétente du pays d'origine, les références du visa sanitaire prévu à l'article 22 du code, ainsi que, le cas échéant, les rapports d'inspection révélant des problèmes susceptibles d'affecter la qualité et les rapports de réclamations recensant des effets indésirables. Le certificat étranger fait donc partie des pièces demandées ; sa présence n'emporte pas automatiquement libération marocaine [1, p. 2330].

Instruction (art. 3 et 5). Le dépôt auprès de l'Agence donne lieu à récépissé. Après vérification de la complétude, l'Agence examine le dossier et réalise des contrôles analytiques des échantillons chaque fois que nécessaire. Elle peut demander des informations supplémentaires ; l'établissement dispose alors de 30 jours maximum pour répondre. Cette demande suspend le délai de décision, qui recommence à courir à réception des informations demandées [1, p. 2330].

Décision et refus (art. 4, 6 et 7). Le délai ordinaire de décision ne dépasse pas 60 jours à compter du dépôt du dossier complet. Une décision défavorable doit être motivée et notifiée. Si l'examen documentaire et, le cas échéant, les essais analytiques sont conformes, le certificat est délivré. Si la libération est refusée, l'établissement doit détruire le lot selon les règles applicables et adresser à l'Agence le procès-verbal de destruction [1, p. 2330].

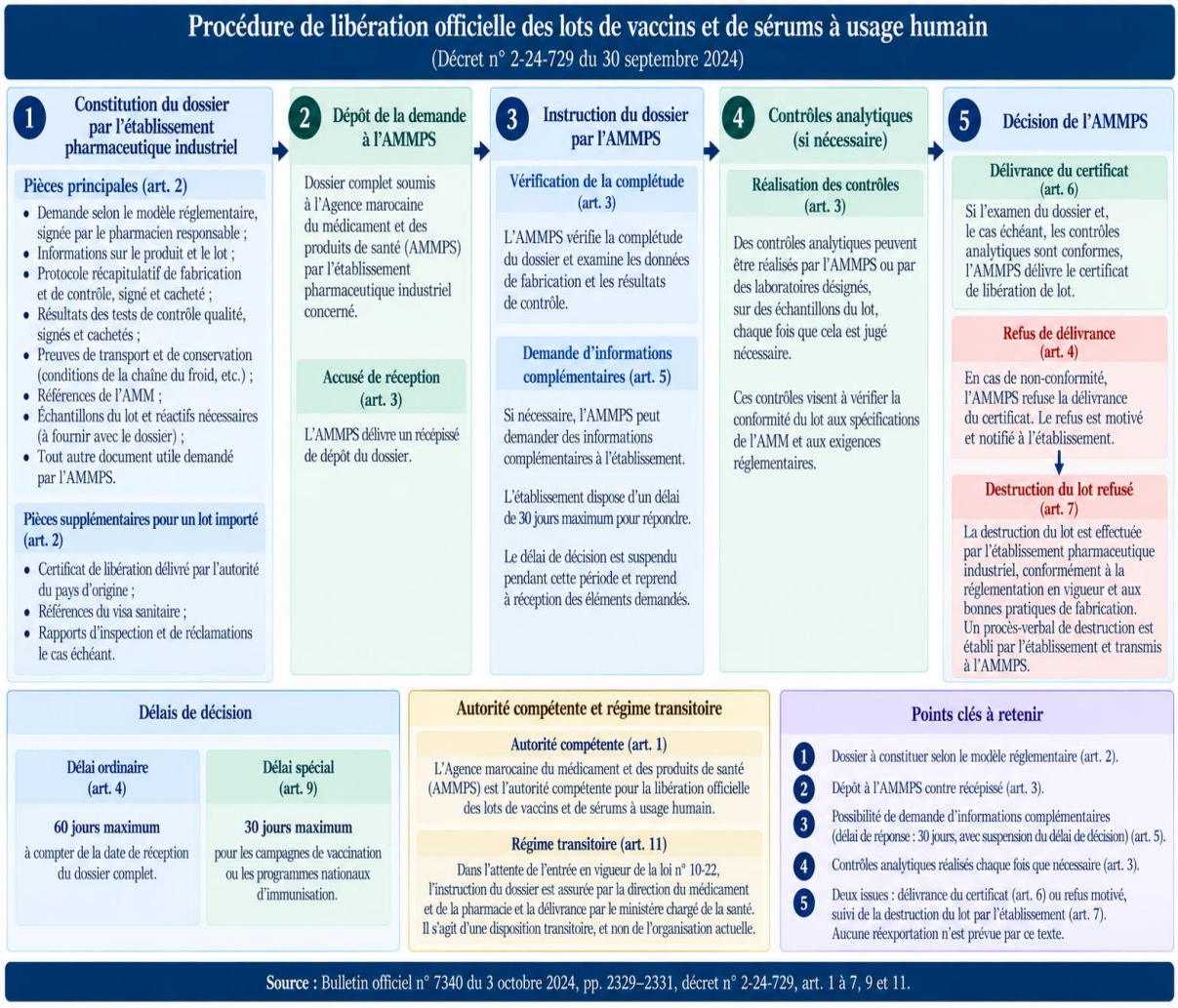


Figure 4 Procédure administrative de libération officielle des lots de vaccins et de sérums

4. Les trois mécanismes de traitement accéléré : conditions distinctes

Ces régimes en-dessous (figure 5) répondent à des situations différentes. Le délai de 30 jours dépend de la destination du lot ; celui de 7 jours dépend de l'origine importée et de la reconnaissance de l'autorité étrangère ; le contrôle parallèle dépend d'une situation exceptionnelle et concerne le lot fabriqué localement. Le texte ne donne pas une règle générale permettant de cumuler librement ces avantages [1, art. 8 à 10].

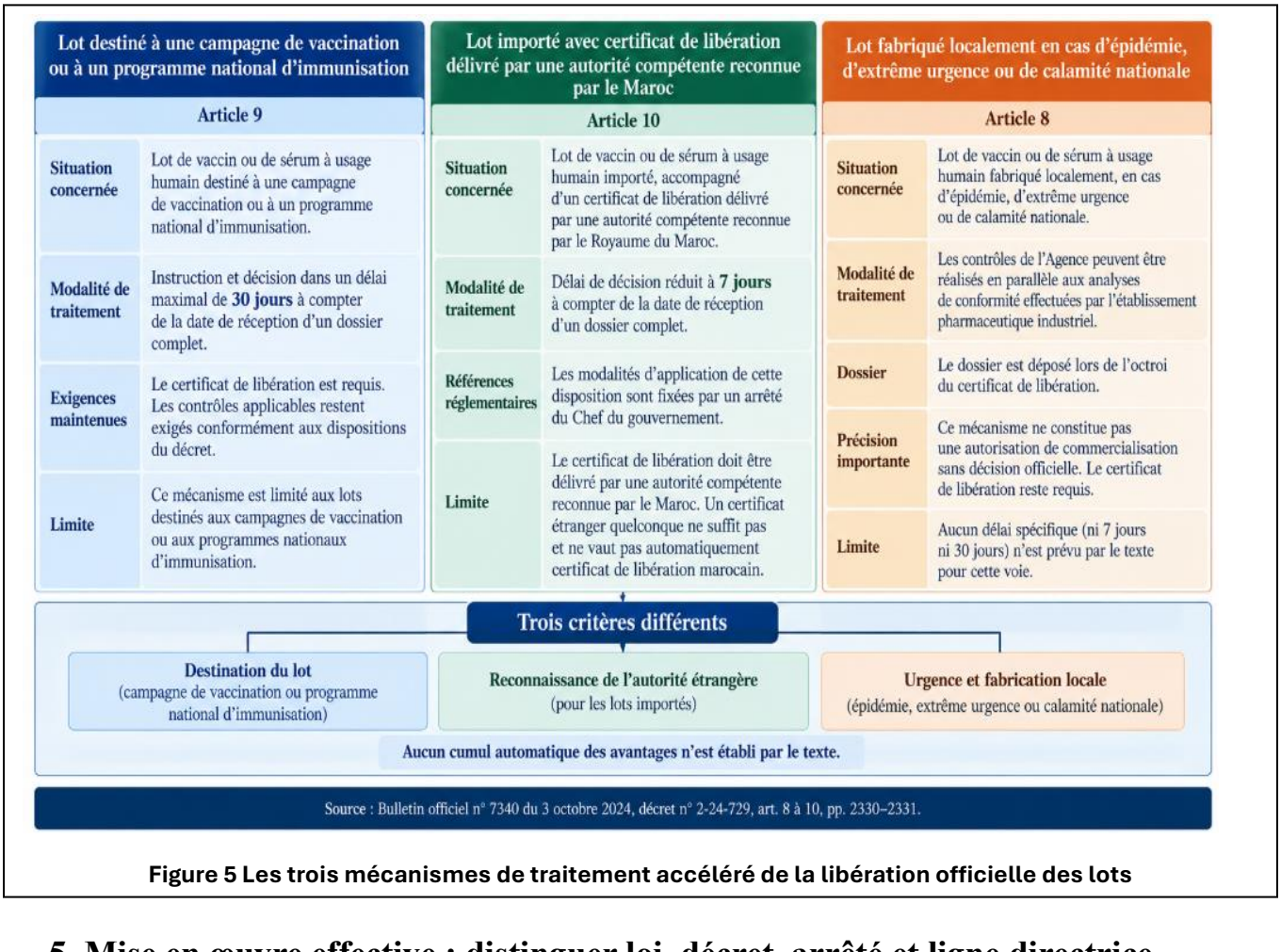


Figure 5 Les trois mécanismes de traitement accéléré de la libération officielle des lots

5. Mise en œuvre effective : distinguer loi, décret, arrêté et ligne directrice

La publication du décret-loi en 2024 a introduit l'obligation dans le code. Toutefois, l'article 12 du décret n° 2-24-729 subordonne expressément la prise d'effet de ce décret à la publication au Bulletin officiel des arrêtés prévus à ses articles 2 et 6 (modèles de demande et de certificat). Il est donc inexact de considérer que toutes les modalités du décret étaient opérationnelles dès sa seule publication d'octobre 2024 [1, p. 2331].

L'AMMPS a annoncé en 2025 la publication de l'arrêté ministériel n° 1461.25, au Bulletin officiel n° 7457 du 17 novembre 2025, pour l'application des articles 2 et 6 du décret [3].

Le 9 février 2026, l'Agence a annoncé sa ligne directrice sur la libération des lots, indiquant qu'elle s'applique dès sa publication aux vaccins et sérums concernés [4].

Ces jalons documentent le passage d'un cadre légal à une procédure standardisée ; la ligne directrice doit être lue avec le texte réglementaire et ne saurait créer à elle seule une nouvelle infraction.

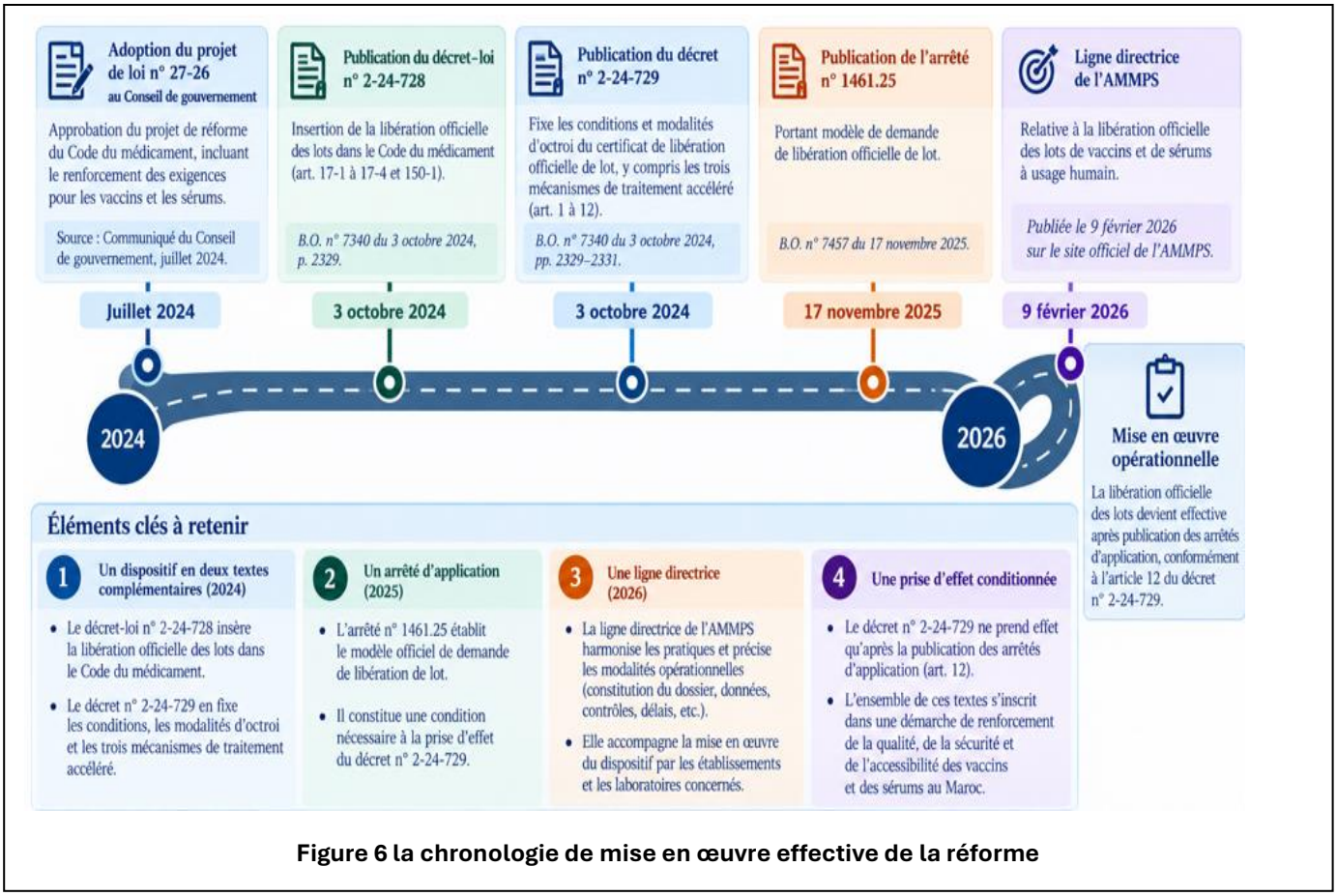


Figure 6 la chronologie de mise en œuvre effective de la réforme

6. Comparaison ciblée : cadre antérieur et réforme de 2024–2026

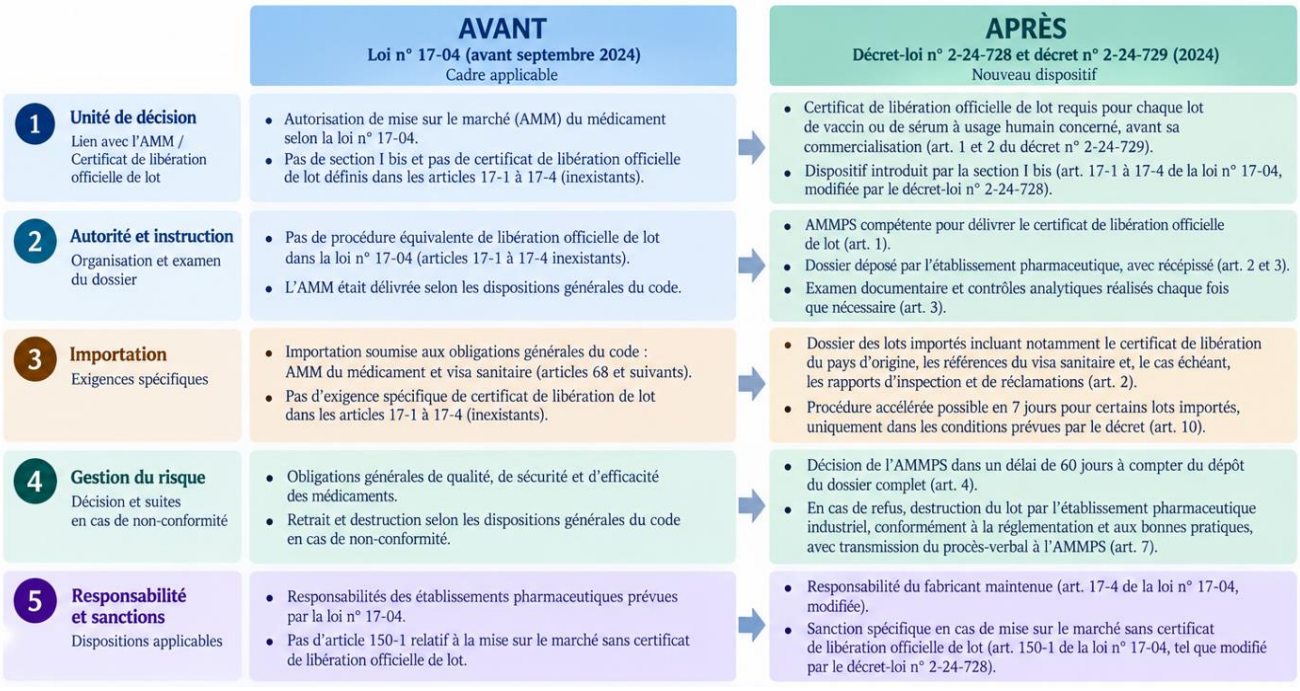


Figure 7 Comparaison entre cadre antérieur et réforme de 2024–2026

La réforme ajoute un verrou réglementaire entre l'AMM et la commercialisation effective des produits immunologiques concernés. Elle rend visibles des exigences de traçabilité documentaire, de contrôle indépendant et de décision par lot. Elle ne permet toutefois pas, à elle seule, de conclure que chaque lot est systématiquement retesté en laboratoire : l'article 3 prévoit un contrôle analytique « chaque fois que nécessaire » [1].

Elle ne prouve pas non plus un niveau de maturité OMS déterminé ; celui-ci relève d'une évaluation distincte.

7. Points de vigilance juridiques

- Ne pas confondre les certificats : le certificat de libération officielle du lot atteste la possibilité de commercialiser un lot précis ; le certificat du produit pharmaceutique (CPP), visé par la réforme de 2026, relève d'un autre instrument documentaire.
- Ne pas confondre les périmètres : la section I bis concerne les vaccins et sérums à usage humain, non tous les médicaments biologiques.
- Ne pas confondre les dates : le décret-loi de 2024, les modèles annoncés en 2025 et la ligne directrice de 2026 forment trois étapes différentes.
- Ne pas confondre contrôle public et responsabilité industrielle : l'article 17-4 conserve explicitement cette dernière [1, 3, 4]

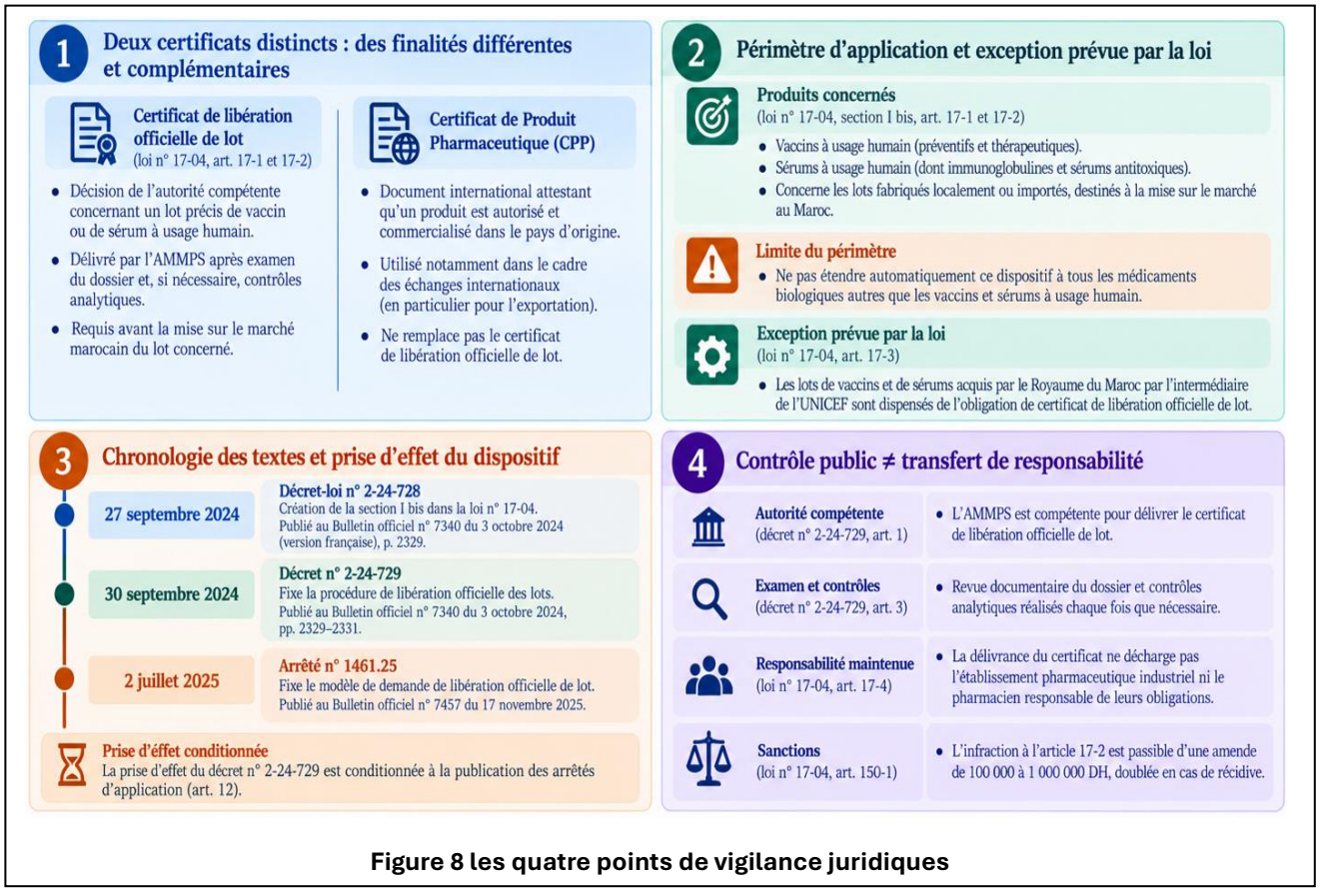


Figure 8 les quatre points de vigilance juridiques

8. Articulation entre la réforme spécifique de 2024 et la réforme générale introduite par la loi n° 27-26.

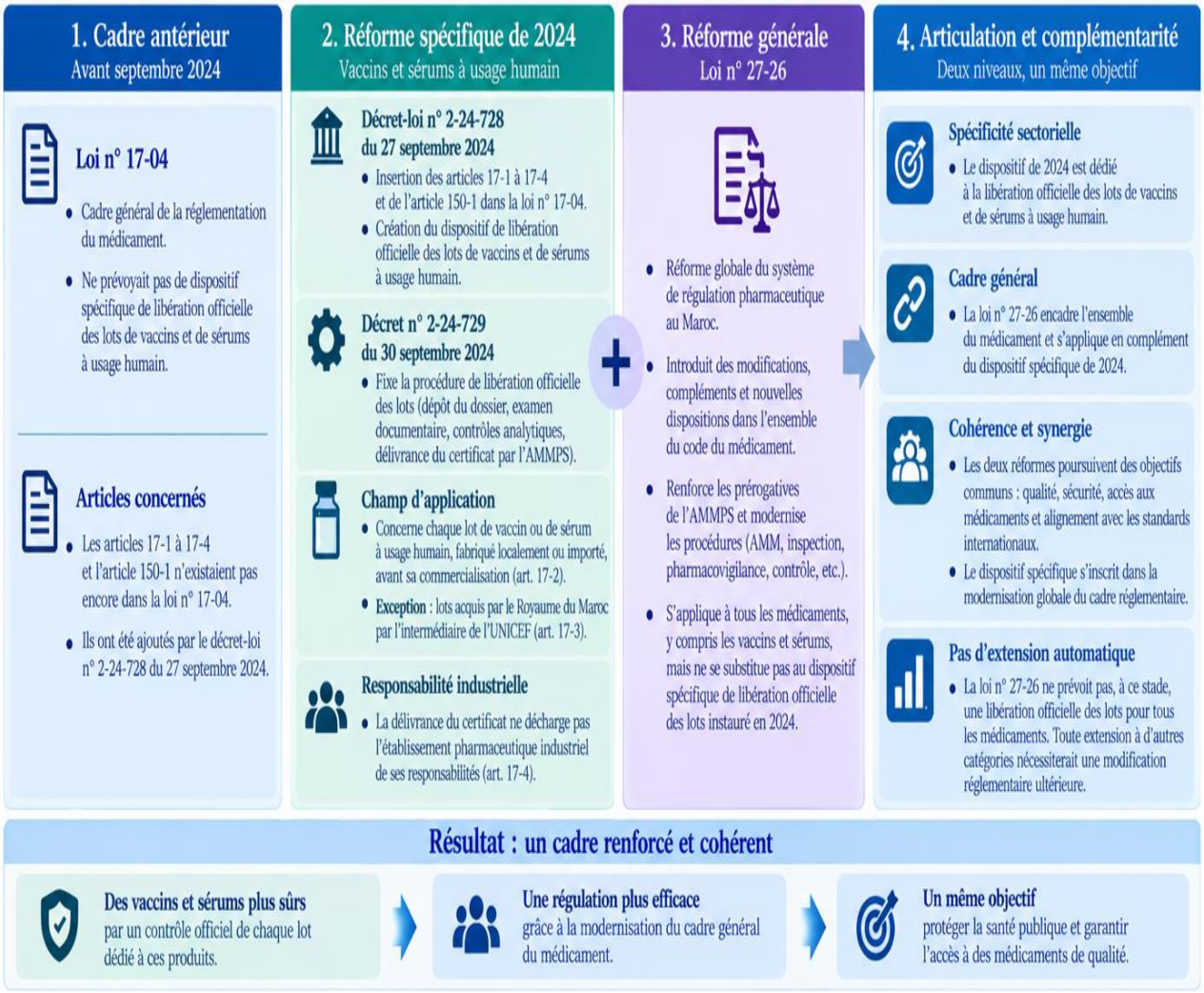


Figure 9 Articulation entre la réforme spécifique de 2024 et la réforme générale introduite par la loi n° 27-26.

Cette réforme constitue une première séquence de modernisation ciblée du code 17-04 : contrôle officiel préalable de chaque lot de vaccin ou sérum. La séquence suivante, consacrées à la loi n° 27-26, élargit l'analyse à la pharmacovigilance, aux régimes d'autorisation, à l'inspection et au contrôle du marché.

Partie 2 — Réforme du Code du médicament et de la pharmacie : apports de la loi n° 27-26 modifiant et complétant la loi n° 17-04

Cette partie expose les dispositions introduites, remplacées ou complétées par la loi n° 27-26, en les confrontant au dispositif de la loi n° 17-04. Elle décrit leur portée juridique, les acteurs concernés, les conditions d'application et les articulations entre articles. Lorsqu'une figure simplifie ou extrapole une règle, le texte précise la formulation juridique retenue.

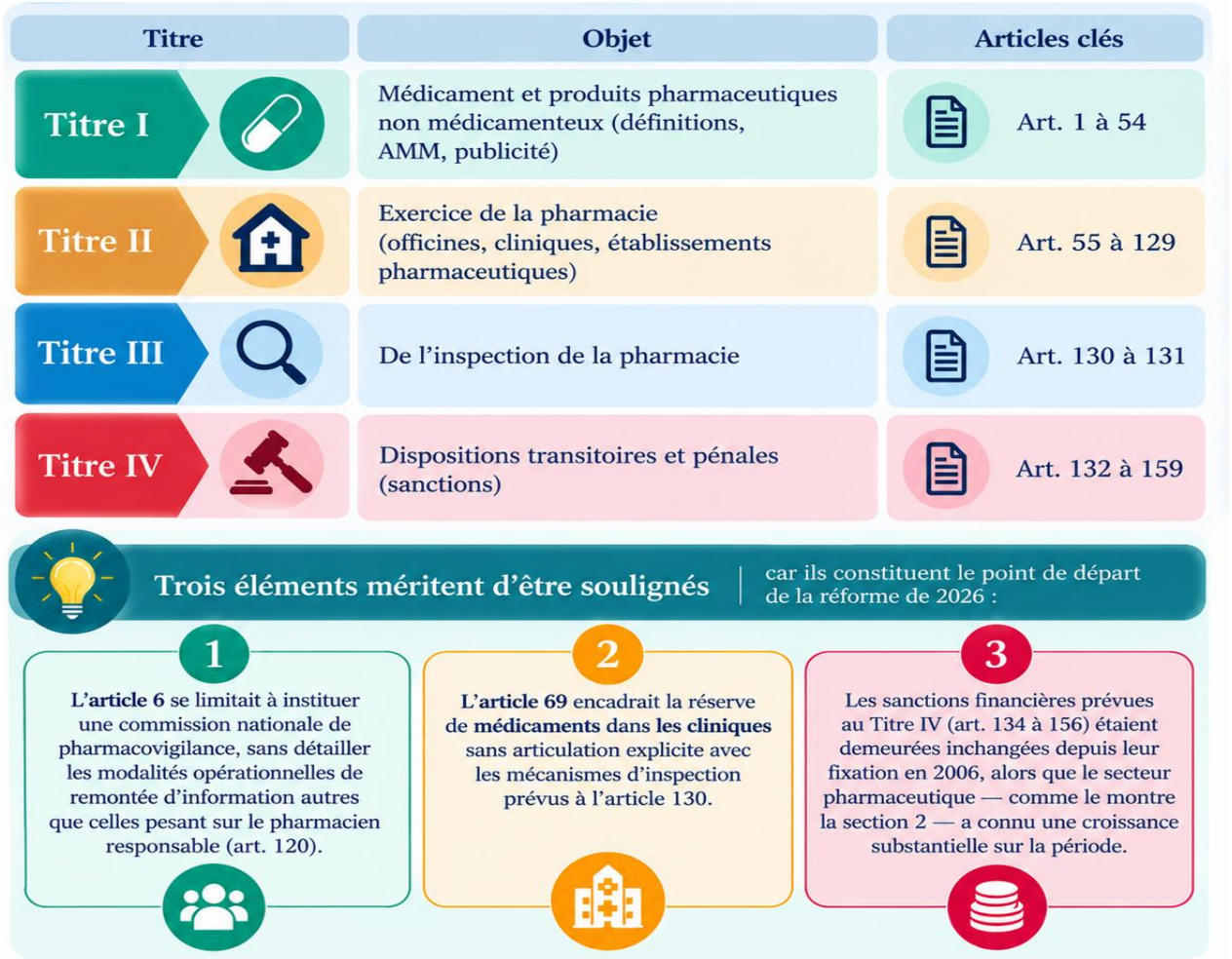


Figure 10 Architecture de la loi n° 17-04 : repérage des titres et des domaines réglementaires.

Le Code de 2006 comporte quatre titres : le médicament et les produits pharmaceutiques non médicamenteux (titre I), l'exercice de la pharmacie (titre II), l'inspection de la pharmacie (titre III), et les dispositions transitoires et pénales (titre IV).

Cette architecture explique que la réforme de 2026 intervienne simultanément sur l'accès au marché, les responsabilités des établissements, le contrôle et les sanctions. L'article 3 de la loi n°

27-26 renomme précisément le titre III « Inspection de la pharmacie et contrôle du marché des médicaments ». [1, art. 1–159 ; 2, art. 3]

La technique législative est circonscrite : l'article premier de la loi n° 27-26 modifie ou complète les articles 7, 15, 30, 69, 120, 130, le premier alinéa de l'article 131 et l'article 156 ; l'article 2 remplace intégralement l'article 6 ; l'article 4 ajoute les articles 8 bis et 131 bis ; les articles 5 à 7 portent respectivement sur la terminologie du certificat, la continuité d'un décret d'application et les dates d'effet. Les passages en points de suspension du texte modificatif correspondent à des fragments non reproduits : ils ne constituent pas des abrogations. [2, art. 1–7]

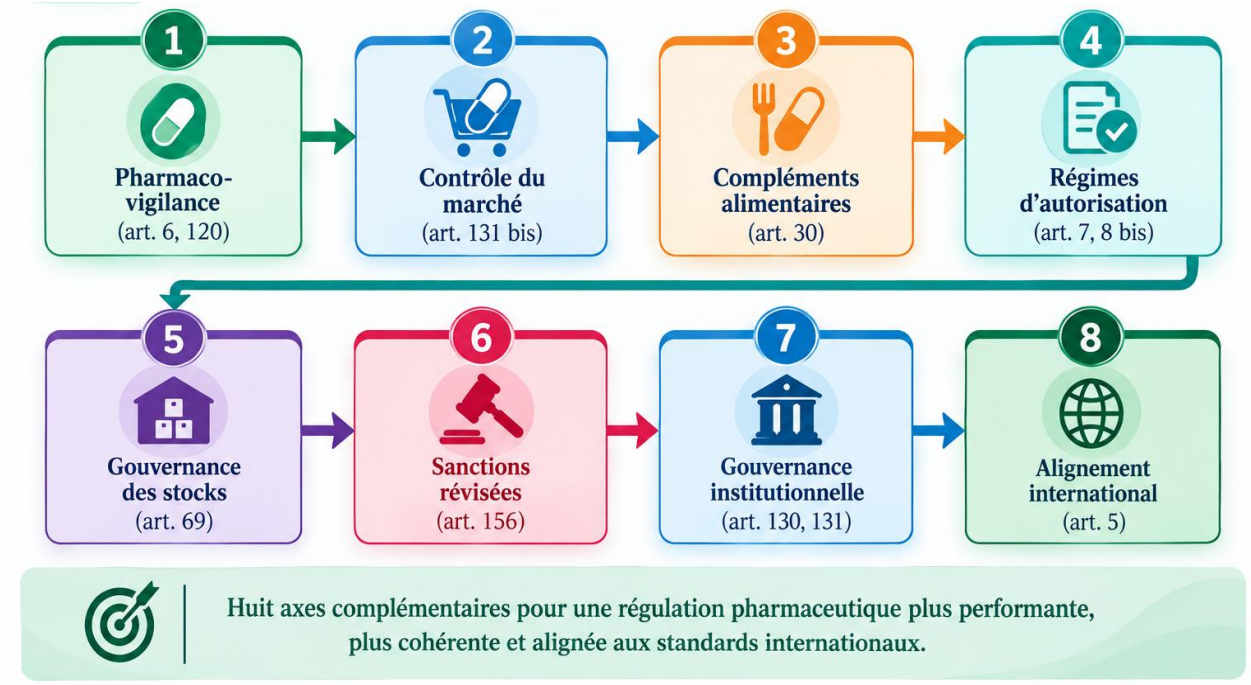


Figure 11 les huit axes de transformation introduits par la loi 27-26

Les huit ensembles de la figure sont un outil de présentation, et non huit chapitres législatifs autonomes. Les articles 15 et 30 doivent notamment être lus pour eux-mêmes : le premier ajuste les références aux catégories d'autorisation et le second ajoute une catégorie particulière de compléments alimentaires.

Le changement de dénomination du certificat, prévu à l'article 5 de la loi modificative, n'est pas à confondre avec les certificats de libération de lots de vaccins. [2, art. 1 et 5]

2. Pharmacovigilance : d'une commission à un système national

2.1. Substitution intégrale de l'article 6

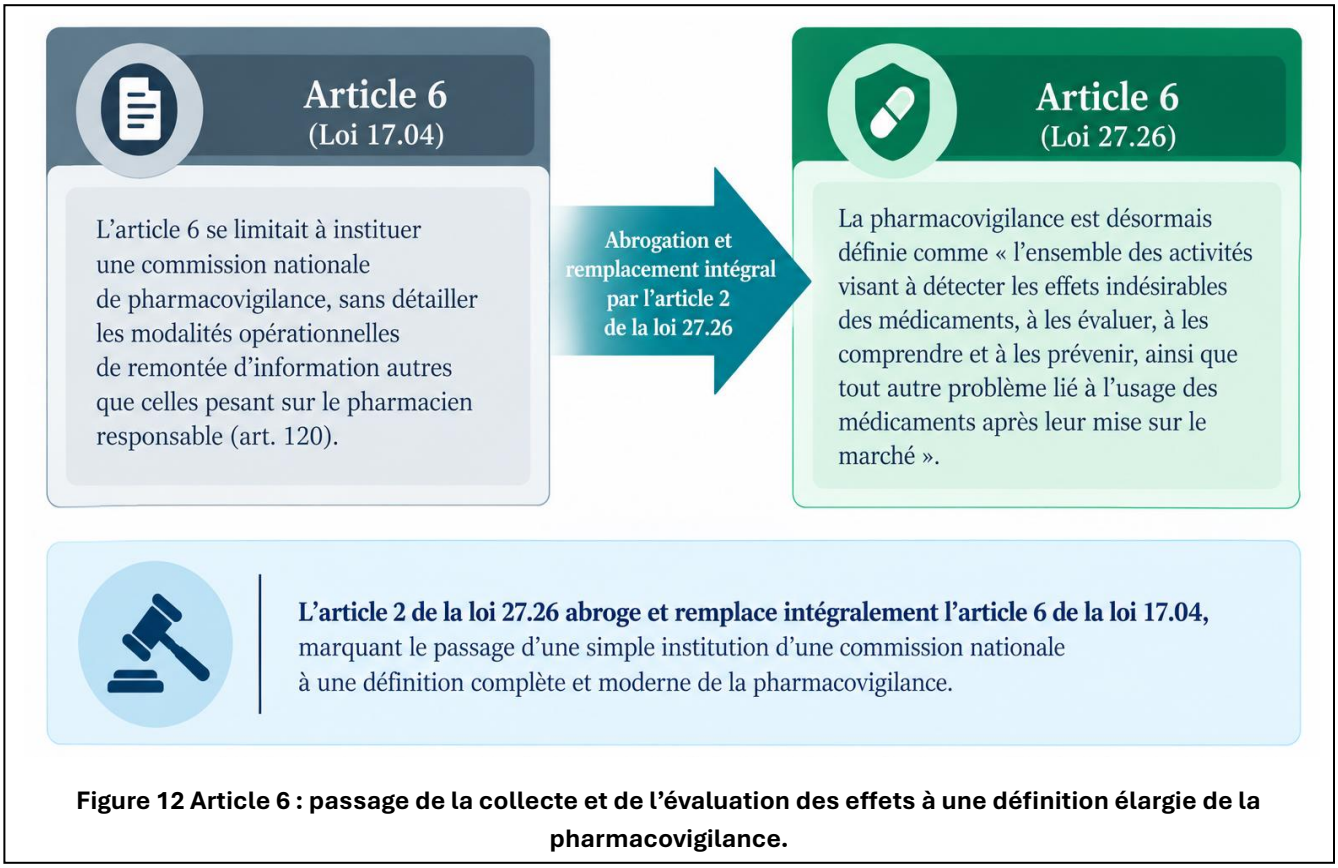


Figure 12 Article 6 : passage de la collecte et de l'évaluation des effets à une définition élargie de la pharmacovigilance.

Dans sa rédaction initiale, l'article 6 assignait à la pharmacovigilance le recueil et l'évaluation des informations sur les effets inattendus ou toxiques après délivrance de l'AMM et instituait une commission nationale dont les attributions et modalités relevaient du règlement. La loi n° 27-26 abroge et remplace l'ensemble de cet article : la pharmacovigilance couvre désormais la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des effets indésirables ainsi que de tout autre problème lié à l'utilisation des médicaments après leur mise sur le marché. La nouvelle définition ne se limite donc pas à la réception d'un signalement ni aux seuls effets « inattendus ou toxiques ». [1, art. 6 ; 2, art. 2]

Le même article institue un système national regroupant l'ensemble des intervenants dans les activités de pharmacovigilance. Il renvoie aux règles de bonnes pratiques fixées par l'administration après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, tandis que l'organisation et le fonctionnement du système doivent être précisés par voie réglementaire. Le texte crée ainsi un cadre national et renvoie les modalités opérationnelles à des instruments distincts ; il ne détaille pas, à lui seul, les formulaires, délais de notification ou circuits de transmission. [2, art. 2]



Figure 13 Les trois composantes explicites de l'article 6 : intervenants, bonnes pratiques et organisation réglementaire.

La figure évoque à titre illustratif pharmaciens, médecins, établissements et autorités : l'article 6 emploie la formule générale « ensemble des intervenants » et ne dresse pas dans cet article une liste fermée. De même, le texte nouveau ne maintient pas expressément dans son article 6 la commission nationale de l'ancienne rédaction ; il prévoit un système national dont la gouvernance détaillée dépend du texte d'application. Il faut donc distinguer ce qui est institué par la loi et ce qui reste à préciser réglementairement. [1, art. 6 ; 2, art. 2 et 7]

2.2. Responsabilité dédiée au sein des établissements industriels : article 120

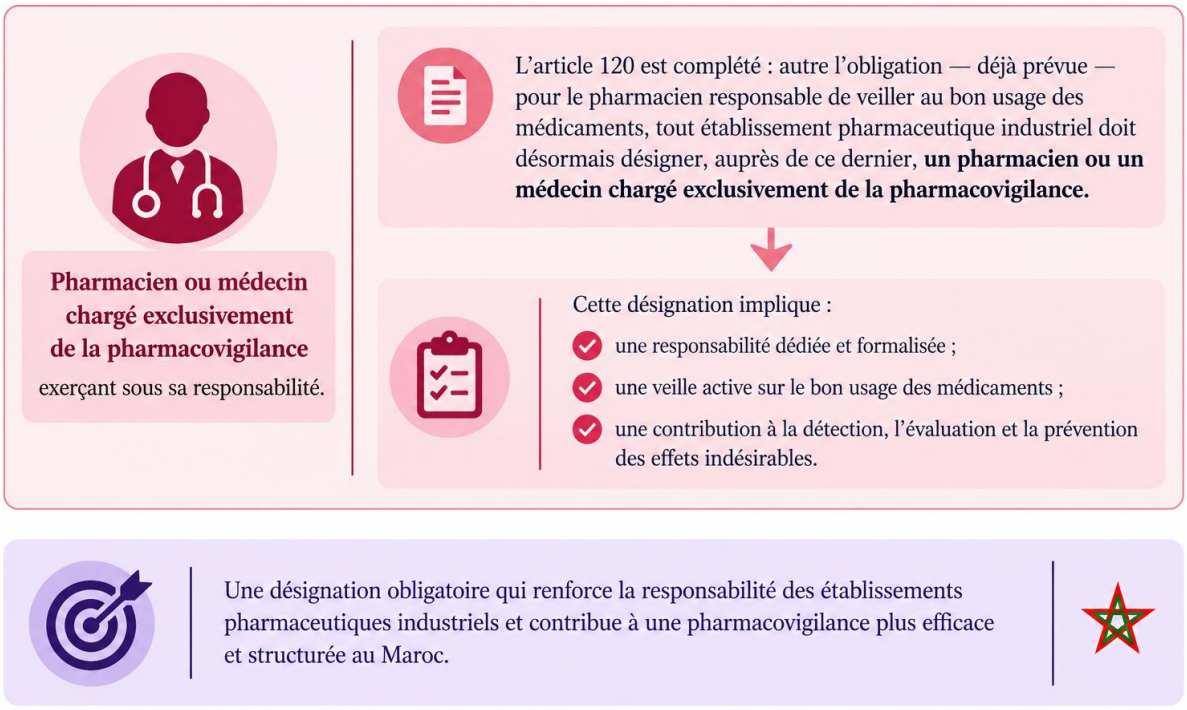


Figure 14 Désignation obligatoire d'un pharmacien ou d'un médecin exclusivement chargé de pharmacovigilance.

L'article 120 conserve le rôle du pharmacien responsable et complète le dispositif par une obligation de désignation : chaque établissement pharmaceutique industriel doit désigner auprès de celui-ci un pharmacien ou un médecin chargé à titre exclusif de la pharmacovigilance. Ce professionnel exerce sous la responsabilité du pharmacien responsable. La loi distingue donc la fonction dédiée de pharmacovigilance et la responsabilité générale du pharmacien responsable, sans transférer intégralement cette dernière au professionnel désigné. [1, art. 120 ; 2, art. 1, modification de l'art. 120]

L'exclusivité qualifie la mission de pharmacovigilance confiée au professionnel désigné ; elle ne signifie pas que l'établissement peut se dispenser des autres obligations du Code. La loi n° 27-26 accorde aux établissements industriels un délai maximal de trois mois à compter de son entrée en vigueur pour se conformer au deuxième alinéa de l'article 120. La date résultant de la publication du 16 juillet 2026 est le 16 octobre 2026. [2, art. 7]

2.3. Articulation avec l'inspection et le régime répressif

Le nouvel article 130 inclut explicitement le contrôle des bonnes pratiques de pharmacovigilance dans les établissements pharmaceutiques industriels parmi les missions de l'inspection. L'article 156 vise également les manquements à ces bonnes pratiques dans la même disposition que les manquements aux bonnes pratiques de fabrication. Il convient cependant de distinguer

l'existence de la clause de sanction et la détermination de son montant : le texte modificatif reproduit cette dernière sous forme de points de suspension ; le montant doit être vérifié dans le Code applicable consolidé. [2, art. 1, art. 130 et 156]

3. Régimes d'autorisation : différenciation des voies d'accès au médicament

3.1. Trois formes prévues à l'article 7

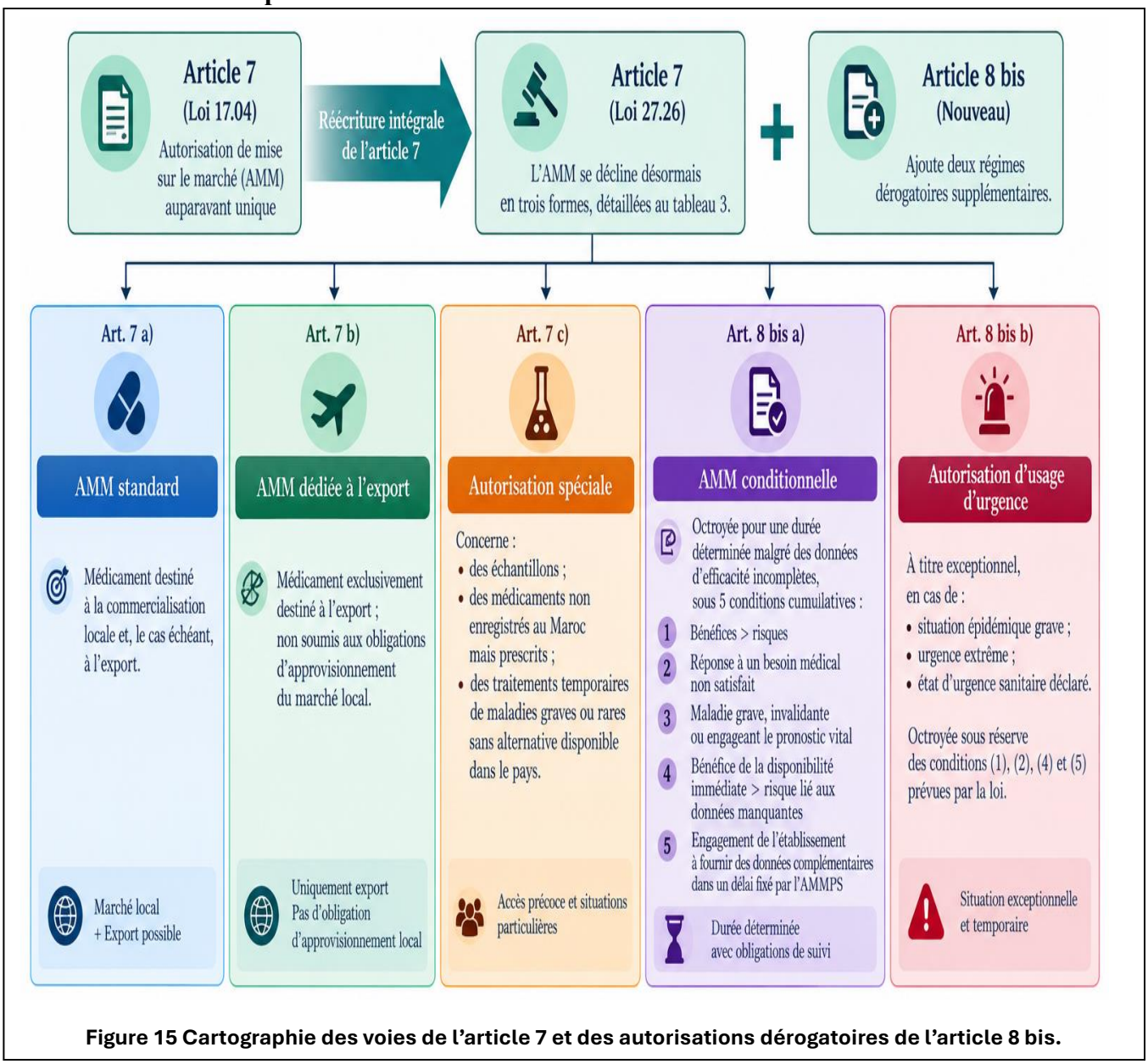


Figure 15 Cartographie des voies de l'article 7 et des autorisations dérogatoires de l'article 8 bis.

L'article 7 de 2006 distinguait l'AMM et l'autorisation spécifique applicable notamment à certains échantillons, essais cliniques, médicaments prescrits non enregistrés et usages temporaires dans des situations particulières.

En 2026, l'article 7 distingue expressément :

- a) l'AMM pour le médicament destiné à la commercialisation locale et, le cas échéant, à l'exportation ;
- b) l'AMM exclusivement destinée à l'exportation ;
- c) l'autorisation spéciale. Cette dernière n'est pas créée ex nihilo : elle reprend, dans une rédaction actualisée, un mécanisme particulier déjà présent dans l'ancien article 7. [1, art. 7 ; 2, art. 1, art. 7]

La distinction entre AMM locale et AMM exclusivement export répond à deux finalités juridiques différentes : l'une autorise la mise sur le marché marocain, éventuellement accompagnée d'exportation ; l'autre vise un produit destiné uniquement à l'export. Le texte de l'article 7 ne permet pas de déduire, sans dispositions d'application, que les exigences de qualité ou la procédure documentaire seraient identiques dans les deux voies. Il faut également éviter de présenter les cinq cases de la figure comme cinq AMM ordinaires : l'autorisation spéciale et l'autorisation d'utilisation d'urgence ont des qualifications propres. [2, art. 1 et 4]

3.2. AMM conditionnelle : cinq conditions cumulatives, article 8 bis a)

L'article 8 bis introduit, par dérogation à l'article 8, une AMM conditionnelle de durée déterminée lorsque les données complémentaires d'efficacité et de sécurité ne sont pas encore toutes disponibles. Son octroi suppose cumulativement :

- 1/ Un rapport bénéfices/risques favorable ;
- 2/ La réponse à un besoin médical non satisfait ;
- 3/ Une indication de traitement, de prévention ou de diagnostic de maladies graves entraînant une incapacité ou mettant la vie en danger ;
- 4/ Un bénéfice de santé publique lié à la disponibilité immédiate supérieur au risque associé aux données encore manquantes ;
- 5/ L'engagement de l'établissement industriel de fournir les données complémentaires dans le délai fixé par l'AMMPS. [2, art. 4, art. 8 bis a)]

Les conditions 1 et 4 sont distinctes : la première concerne le rapport bénéfices/risques du médicament, la seconde la justification de sa disponibilité immédiate malgré l'incomplétude des données. La cinquième condition organise une obligation post-autorisation. Le texte légal ne fixe pas lui-même la durée uniforme de toutes les AMM conditionnelles : il prévoit une durée déterminée et renvoie les modalités d'octroi au règlement. [2, art. 4]

3.3. Autorisation d'utilisation d'urgence : conditions spécifiques

L'article 8 bis b) permet, à titre exceptionnel et pour des raisons de santé publique, une autorisation d'utilisation d'urgence en présence d'une situation épidémique grave, d'une extrême urgence ou d'un état d'urgence sanitaire déclaré. Le renvoi légal vise expressément les conditions 1, 2, 4 et 5 de l'AMM conditionnelle, et non la condition 3.

L'urgence ne supprime donc ni l'appréciation bénéfices/risques ni l'engagement de fournir les données complémentaires. [2, art. 4, art. 8 bis b)]

Les autorisations conditionnelles et d'urgence peuvent, le cas échéant, être converties en AMM si le médicament satisfait aux conditions de l'article 8. La conversion n'est ni automatique ni assimilable à une dispense définitive des exigences ordinaires.

Les conditions et modalités d'octroi des autorisations de l'article 8 bis sont fixées par voie réglementaire ; leur entrée en vigueur est elle-même différée jusqu'à publication des textes correspondants au Bulletin officiel. [1, art. 8 ; 2, art. 4 et 7]

3.4. Coordination avec l'article 15

L'article 15 est ajusté afin de viser, dans certaines hypothèses de retrait ou de suspension, le titulaire de l'AMM prévue à l'article 7 a), notamment pour l'approvisionnement du marché et la commercialisation du produit dans le délai légal. Les portions inchangées de l'article 15 ne sont pas reproduites intégralement dans la loi modificative : pour identifier chaque motif, sa durée et les possibilités de prorogation, il faut lire l'article 15 consolidé avec le texte de 2006. Cette précision évite d'étendre automatiquement aux autorisations exclusivement export des obligations formulées pour l'AMM locale. [1, art. 15 ; 2, art. 1, art. 15]

4. Compléments alimentaires : insertion ciblée dans l'article 30

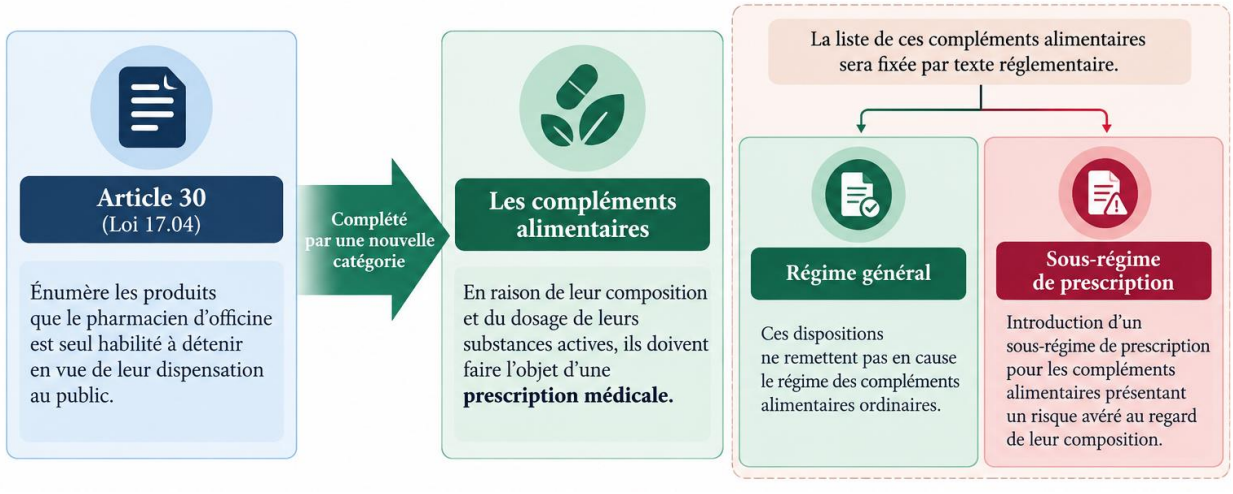


Figure 16 Article 30 : catégorie de compléments alimentaires soumis à prescription et liste réglementaire.

L'article 30 définit les actes réservés au pharmacien d'officine. La loi n° 27-26 y ajoute les compléments alimentaires qui, en raison de leur composition, du dosage de leurs substances actives et de l'effet qu'ils produisent, doivent faire l'objet d'une prescription médicale. La liste de ces compléments doit être fixée par voie réglementaire. Il s'agit d'une catégorie déterminée selon des caractéristiques du produit, non d'un reclassement général de tous les compléments alimentaires en médicaments ou de tous les compléments sous ordonnance. [1, art. 30 ; 2, art. 1, art. 30]

La portée juridique de la modification est double : elle identifie des produits dont la détention en vue de la dispensation au public relève du champ réservé par l'article 30, et elle subordonne l'identification précise des compléments concernés à une liste réglementaire. Les critères de composition, de dosage et d'effet doivent être lus conjointement ; la seule présence d'un ingrédient donné ne suffit pas, dans cet article, à affirmer qu'un produit figure sur une liste non encore vérifiée. [2, art. 1]

5. Stocks de médicaments dans les cliniques : article 69

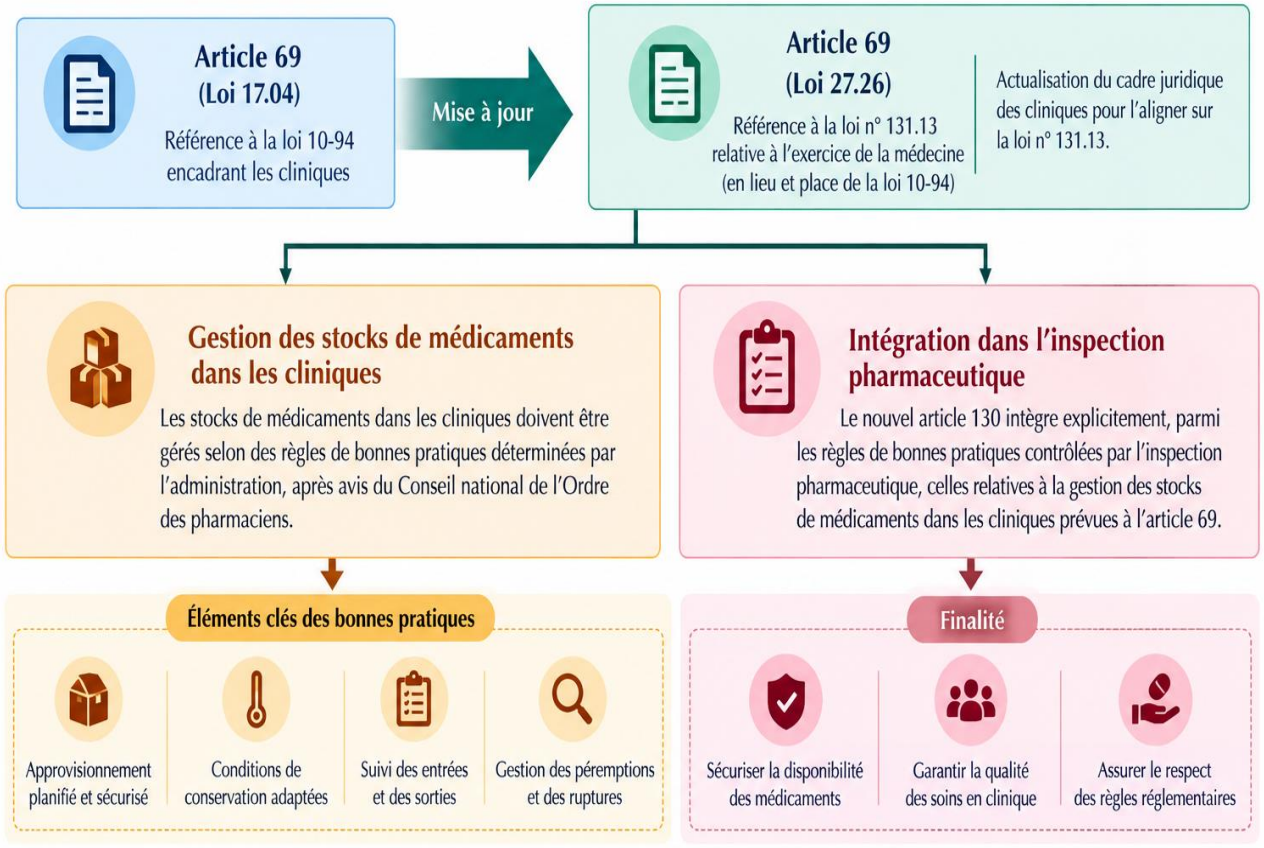


Figure 17 Actualisation du renvoi aux cliniques et insertion de bonnes pratiques de gestion des stocks.

L'article 69 actualise la référence juridique aux cliniques et établissements assimilés en renvoyant à la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine et à ses textes d'application. Ces structures peuvent disposer d'un stock de médicaments pour leurs besoins internes propres, dans les limites des autres conditions de l'article. La réforme ajoute que leurs stocks doivent être gérés conformément aux règles de bonnes pratiques fixées par l'administration après avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. [1, art. 69 ; 2, art. 1, art. 69]

Le renvoi aux bonnes pratiques constitue une obligation de gestion et non, dans le seul article 69, un protocole technique exhaustif. Approvisionnement, conservation, traçabilité, péremptions et mouvements de stocks sont des domaines de gestion illustrés par la figure ; leurs exigences opposables exactes doivent être recherchées dans les règles applicables, et ne peuvent être attribuées mot pour mot à l'article 69. La réforme relie en outre cette obligation au contrôle de l'inspection (article 130) et à une clause de sanction autonome (article 156). [2, art. 1, art. 69, 130 et 156]

6. Inspection pharmaceutique et contrôle du marché

6.1. Autorité de contrôle et inspecteurs : articles 130 et 131

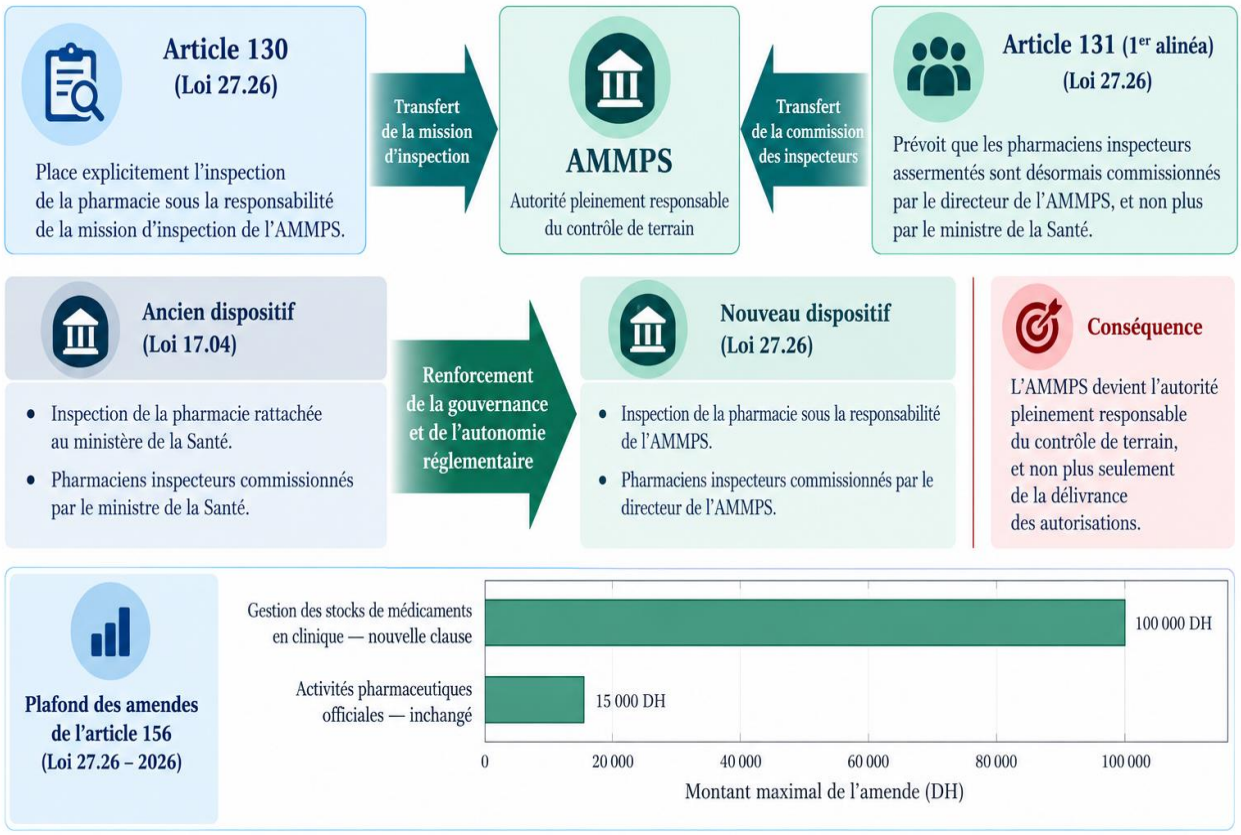


Figure 18 Rattachement de l'inspection à l'AMMPS et commissionnement des inspecteurs.

L'article 130 place l'inspection de la pharmacie sous l'AMMPS et précise son champ : officines, stocks de médicaments des cliniques, établissements pharmaceutiques et dépôts de médicaments. Parmi les contrôles explicitement mentionnés figurent les bonnes pratiques de pharmacovigilance, de fabrication, de distribution, les bonnes pratiques officinales et celles de gestion des stocks en clinique. L'inspection recherche et constate également les infractions relevant des dispositions relatives aux médicaments et aux produits de santé. [2, art. 1, art. 130]

Le premier alinéa de l'article 131 prévoit que les pharmaciens inspecteurs assermentés sont commissionnés par le directeur de l'AMMPS. La modification porte sur ce premier alinéa, et non sur une réécriture intégrale de l'article 131.

L'AMMPS exerce ces compétences dans le cadre légal de l'agence et sous réserve des compétences que les textes attribuent à d'autres organismes : le rattachement de l'inspection ne doit pas être décrit comme l'abolition de toute autre compétence publique en matière de médicament. [2, art. 1, art. 131 ; art. 4, art. 131 bis]

6.2. Nouveau contrôle du marché : article 131 bis

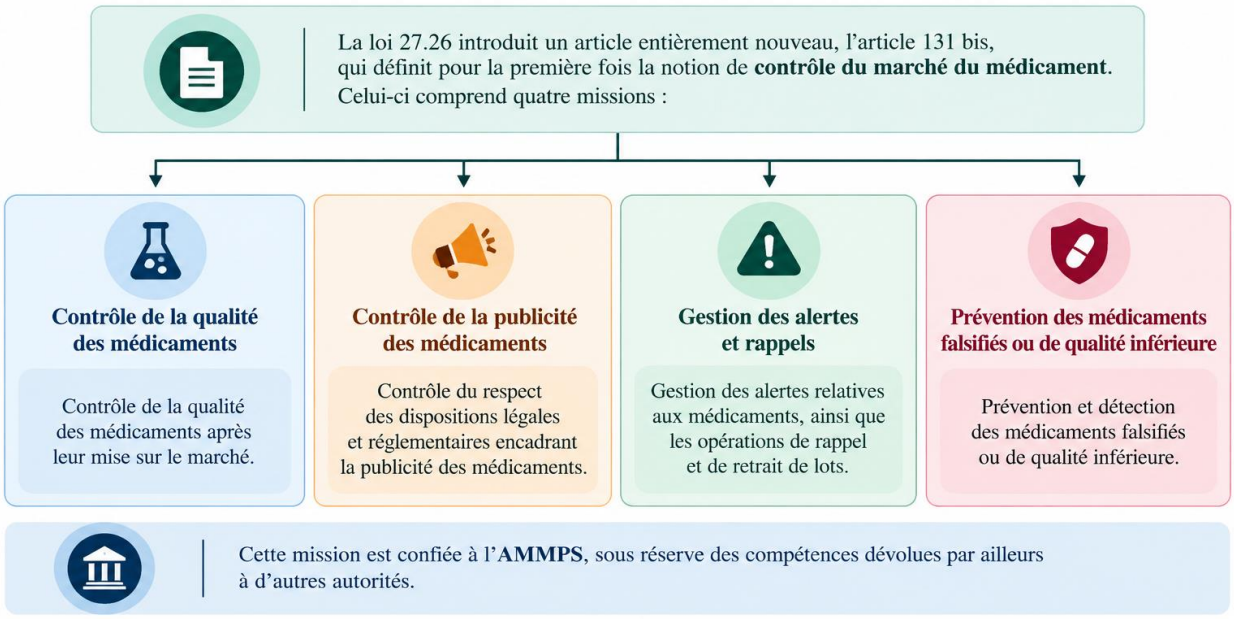


Figure 19 Les quatre composantes légales du contrôle du marché des médicaments.

L'article 131 bis crée un fondement explicite pour le contrôle du marché des médicaments. Il définit quatre objets :

- Contrôle de la qualité après mise sur le marché ;
- Contrôle du respect des règles législatives et réglementaires de publicité ;
- Gestion des alertes, des retraits et des rappels de lots ;

- Prévention et détection des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. L'AMMPS assure ce contrôle sous réserve des compétences et pouvoirs attribués à d'autres autorités, administrations et organismes. [2, art. 4, art. 131 bis]

L'article 130 et l'article 131 bis ne se confondent pas : le premier détermine le champ et certaines missions de l'inspection, tandis que le second énonce les objets du contrôle du marché. La publicité, les alertes et les rappels s'inscrivent dans un suivi post-commercialisation ; l'article 131 bis n'énonce cependant pas, à lui seul, les procédures détaillées de prélèvement, de décision de rappel, de notification ou de partage des compétences. Ses modalités d'application sont renvoyées à un texte réglementaire, et son entrée en vigueur est différée jusqu'à la publication de celui-ci. [2, art. 4 et 7]

7. Sanctions : identification précise des manquements visés

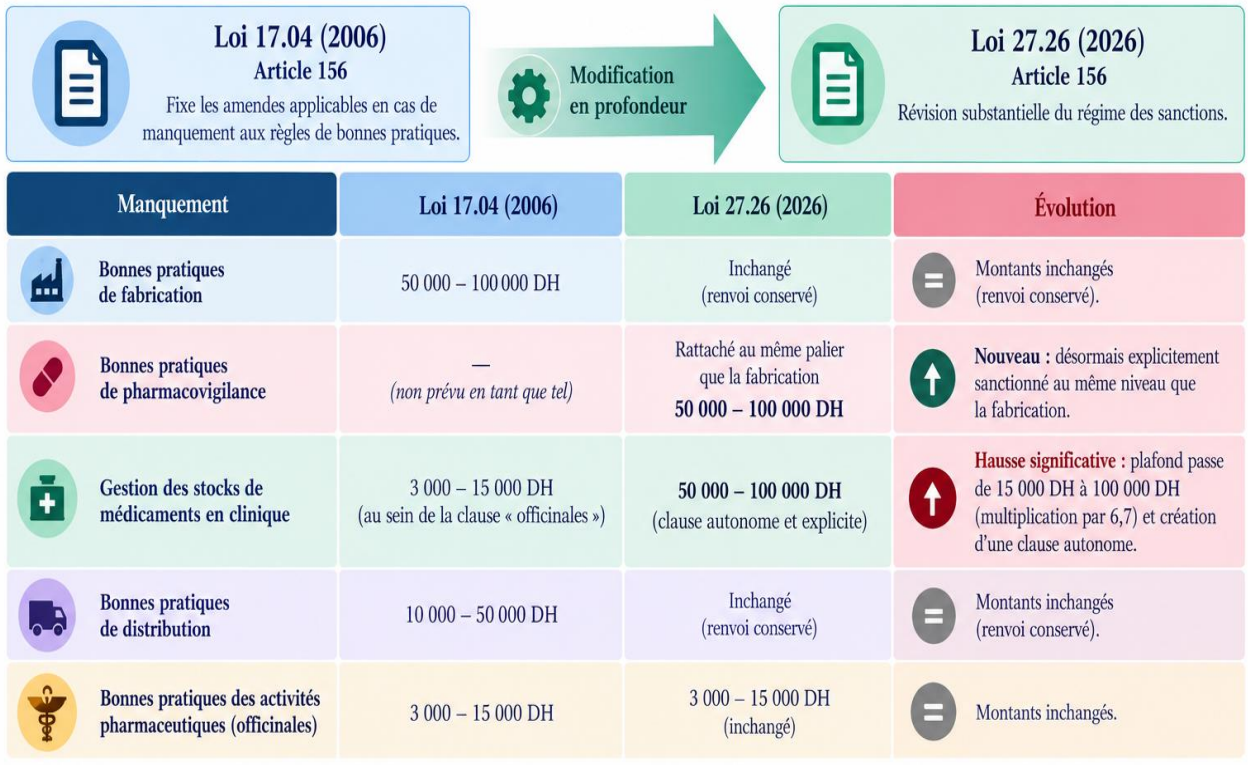


Figure 20 les sanctions : les montants antérieurs doivent être confrontés au Code consolidé.

L'article 156, tel que modifié, vise expressément les manquements aux bonnes pratiques de fabrication et de pharmacovigilance, ceux relatifs à la gestion des stocks de médicaments en clinique, les manquements aux bonnes pratiques de distribution et ceux relatifs aux bonnes pratiques officinales. La loi n° 27-26 fixe explicitement une amende de 50 000 à 100 000 dirhams pour les manquements aux bonnes pratiques de gestion des stocks en clinique et une amende de 3 000 à 15 000 dirhams pour les manquements aux bonnes pratiques officinales. [2, art. 1, art. 156] Pour la fabrication/pharmacovigilance et la distribution, la loi modificative utilise

des points de suspension à l'emplacement des montants. Il serait donc inexact d'attribuer à la seule loi n° 27-26 un montant qui n'y est pas intégralement reproduit. De même, la figure compare la gestion des stocks en clinique à une ancienne « clause officinale » : cette assimilation antérieure n'est pas démontrée par la seule lecture des textes modificatifs. L'analyse des sanctions doit distinguer la création explicite d'une catégorie d'infraction, les montants effectivement écrits dans la réforme et la vérification de l'état antérieur dans le Code consolidé. [1, art. 156 ; 2, art. 1]

8. Certificat du produit pharmaceutique et dispositions transitoires

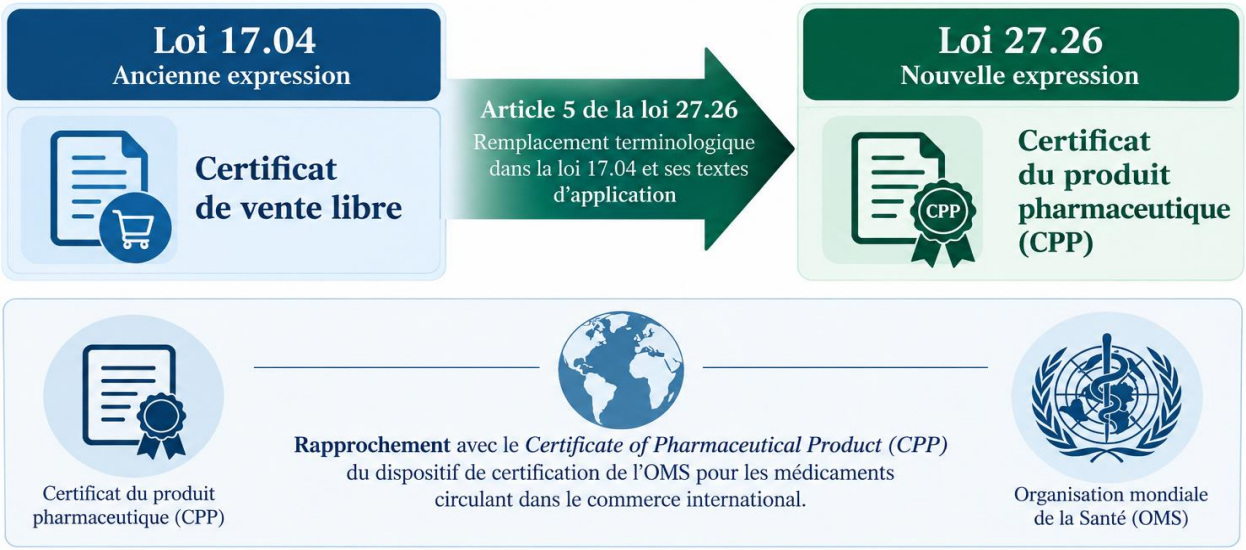


Figure 21 Remplacement de la dénomination « certificat de vente libre » par « certificat du produit pharmaceutique ».

L'article 5 de la loi n° 27-26 substitue l'expression « certificat du produit pharmaceutique » à « certificat de vente libre » dans la loi n° 17-04 et les textes réglementaires pris pour son application. Il s'agit d'une substitution terminologique générale dans ce corpus. Le rapprochement graphique avec le Certificate of Pharmaceutical Product de l'OMS est un repère documentaire ; la seule substitution des mots ne prouve pas, sans examen des textes d'application et des pratiques, l'identité de toutes les procédures, données ou garanties attachées aux certificats. [2, art. 5]

L'article 6 maintient en vigueur le décret n° 2-14-841 du 5 août 2015 relatif à l'AMM des médicaments à usage humain jusqu'à son remplacement conformément à la loi nouvelle. Il évite une rupture immédiate du cadre réglementaire de l'AMM. La présence d'un projet de modification du décret sur un portail de consultation ne suffit pas à établir son adoption ni son entrée en vigueur : seule la publication du texte applicable au Bulletin officiel permet de conclure sur ce point. [2, art. 6 ; SGG, portail des avant-projets]

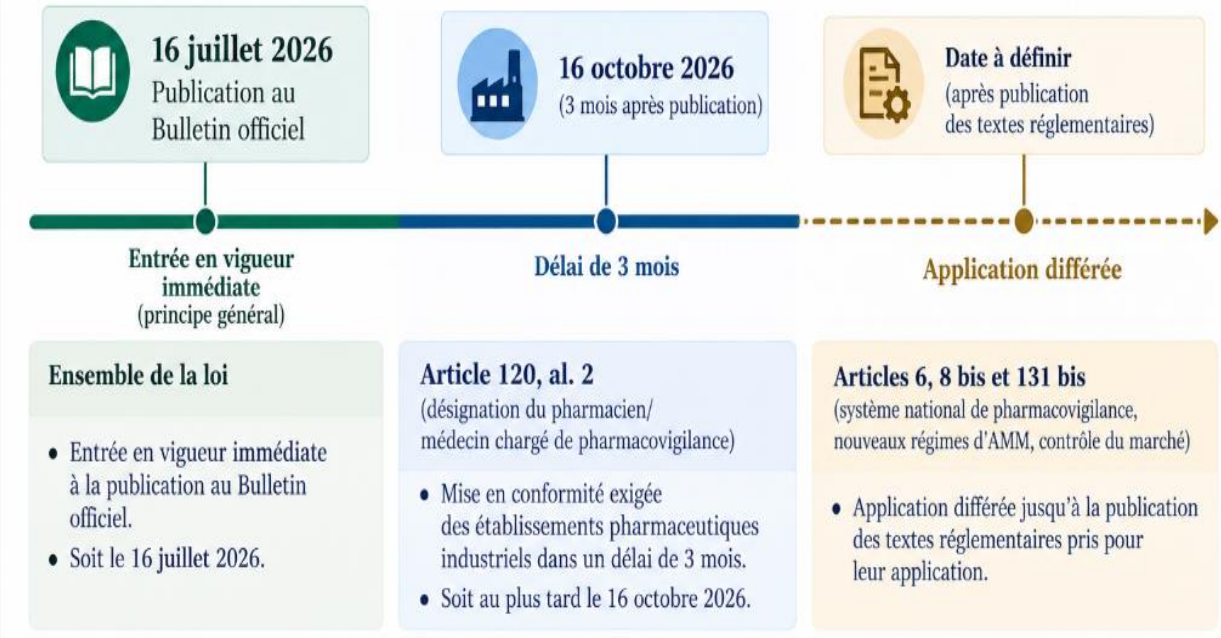


Figure 22 Calendrier différencié prévu par l'article 7 de la loi n° 27-26.

L'article 7 pose l'entrée en vigueur à la date de publication au Bulletin officiel, soit le 16 juillet 2026, sous deux réserves.

Premièrement, les établissements industriels disposent d'un délai maximal de trois mois pour se conformer au deuxième alinéa de l'article 120 : l'échéance correspond au 16 octobre 2026.

Deuxièmement, les articles 6, 8 bis et 131 bis n'entrent en vigueur qu'à la publication au Bulletin officiel des textes réglementaires pris pour leur application. La date d'application de ces trois dispositifs ne peut donc pas être déduite de la seule date du 16 juillet 2026. [2, art. 7]

Ce calendrier commande une lecture en trois niveaux : dispositions légales immédiatement applicables, obligation industrielle assortie d'un délai de mise en conformité, et dispositifs dont l'application attend des textes réglementaires publiés.

L'existence d'avant-projets relatifs au système national de pharmacovigilance, à l'AMM ou à la surveillance du marché renseigne sur le travail réglementaire, mais ne vaut pas publication définitive. [2, art. 7 ; SGG, avant-projets]

9. Lecture transversale de la loi n° 17-04 à la loi n° 27-26

Thématique	Avant (loi 17.04 – 2006)	Après (loi 27.26 – 2026)
Pharmacovigilance	Commission nationale peu opérationnelle ; notification réservée au pharmacien responsable (art. 6, 120).	Système national structuré ; pharmacien ou médecin dédié dans chaque établissement industriel.
Contrôle du marché	Non défini comme tel.	Article 131 bis nouveau : 4 missions explicites (qualité, publicité, alertes/rappels, anti-falsification).
Compléments alimentaires	Statut non délimité (art. 2-11).	Basculement sous prescription selon composition/dosage (art. 30).
Régimes d'autorisation	AMM unique ; plus autorisation spécifique limitée aux cas exceptionnels (art. 7).	5 formes : AMM standard, AMM export, autorisation spéciale, AMM conditionnelle, usage d'urgence (art. 7, 8 bis).
Stocks en clinique	Stock de sécurité obligatoire, peu articulé à l'inspection (art. 69, 84).	Bonnes pratiques définies par l'administration, intégrées explicitement à l'inspection (art. 69, 130).
Sanctions financières	Montants fixes depuis 2006 ; stocks en clinique noyés dans la clause officinale (art. 156).	Clause autonome pour les stocks (jusqu'à 100 000 DH) ; pharmacovigilance sanctionnée explicitement.
Gouvernance institutionnelle	Inspection sous tutelle du ministère de la Santé (art. 130, 131).	Inspection transférée à l'AMMPS (directeur commissionnant les inspecteurs).
Alignement international	Terminologie et régimes propres au Maroc.	Certificat du produit pharmaceutique (CPP, standard OMS) ; objectif de maturité ML3.

Une réforme structurante, renforçant la régulation pharmaceutique au Maroc et la convergence avec les standards internationaux.

Figure 23 Vue d'ensemble des principales évolutions réglementaires analysées.

La comparaison fait apparaître trois types d'opérations juridiques distinctes : remplacement d'une définition et d'un cadre d'organisation (article 6), compléments ou modifications d'obligations déjà présentes (articles 7, 15, 30, 69, 120, 130, 131 et 156), et création de dispositions autonomes (articles 8 bis et 131 bis). Les articles 5 à 7 organisent les effets transversaux et temporels de la réforme.

AXE 2 - Benchmarking du système réglementaire pharmaceutique marocain au regard du Global Benchmarking Tool (GBT) de l'OMS

1. Positionnement du GBT dans l'évaluation des systèmes réglementaires

Le Global Benchmarking Tool (GBT) est l'outil de référence utilisé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour évaluer de manière structurée les systèmes nationaux de réglementation des produits médicaux. Son fondement politique est la résolution WHA67.20 de 2014, qui reconnaît le renforcement des systèmes réglementaires comme une composante essentielle des systèmes de santé et de l'accès à des produits médicaux sûrs, efficaces et de qualité [1,2].

Le GBT n'est pas un simple audit de conformité d'un texte de loi. Il apprécie la capacité d'un système réglementaire à disposer d'un cadre juridique, d'une gouvernance, de ressources, de procédures, d'un système qualité et de preuves d'exécution. La présence d'une disposition légale constitue donc une preuve importante, mais elle ne suffit pas à démontrer à elle seule qu'une fonction est pleinement mise en œuvre. Les fiches du GBT demandent des preuves telles que procédures, dossiers traités, rapports d'inspection, décisions, indicateurs de performance et mécanismes d'amélioration [3,4].

L'OMS utilise le GBT pour identifier les forces et les lacunes, élaborer un plan de développement institutionnel (Institutional Development Plan - IDP/PDI), prioriser les actions correctives et suivre les progrès. Le GBT s'inscrit ainsi dans une logique de renforcement continu plutôt que dans une logique de sanction [2,3].

2. Architecture du Global Benchmarking Tool

Le GBT Revision VI organise l'évaluation en quatre niveaux hiérarchiques : système/fonctions réglementaires, indicateurs, sous-indicateurs et fiches descriptives (fact sheets). Les sous-indicateurs constituent l'unité élémentaire de l'évaluation. Chaque sous-indicateur précise notamment l'objectif, l'exigence, les preuves à examiner, le cadre auquel il appartient et l'échelle d'appréciation [3,5].

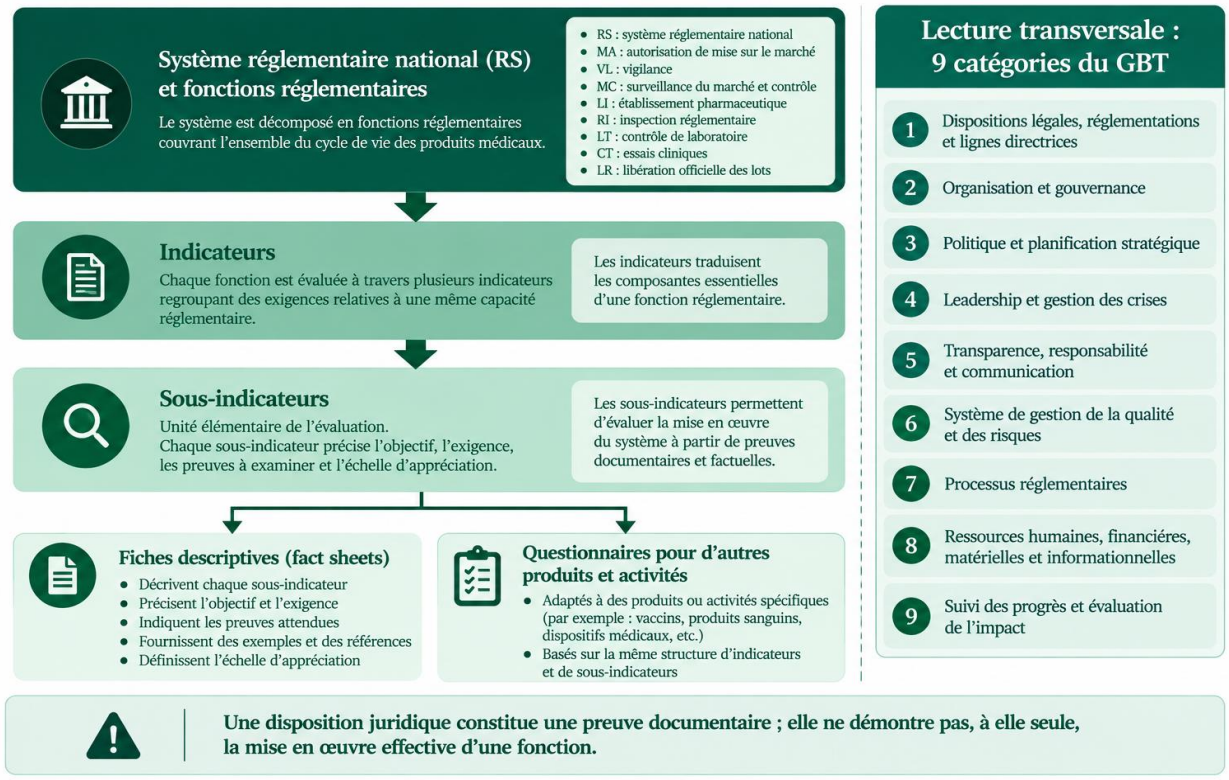


Figure 24 Architecture hiérarchique du Global Benchmarking Tool (GBT) de l'OMS et ses neuf catégories transversales.

2.1. Les neuf catégories transversales du GBT

Au-delà des fonctions, l'OMS regroupe les indicateurs en neuf catégories transversales. Cette lecture est particulièrement utile : un système peut posséder des textes juridiques solides mais rester limité par les ressources, la qualité, la gouvernance ou l'absence de preuves de performance [3].

3. Les niveaux de maturité réglementaire

Le GBT intègre quatre niveaux de maturité (Maturity Levels - ML), adaptés de l'ISO 9004. Ils ne décrivent pas la qualité d'un médicament particulier ; ils décrivent le degré de formalisation, d'intégration, de fonctionnement et d'amélioration du système réglementaire [3,6].

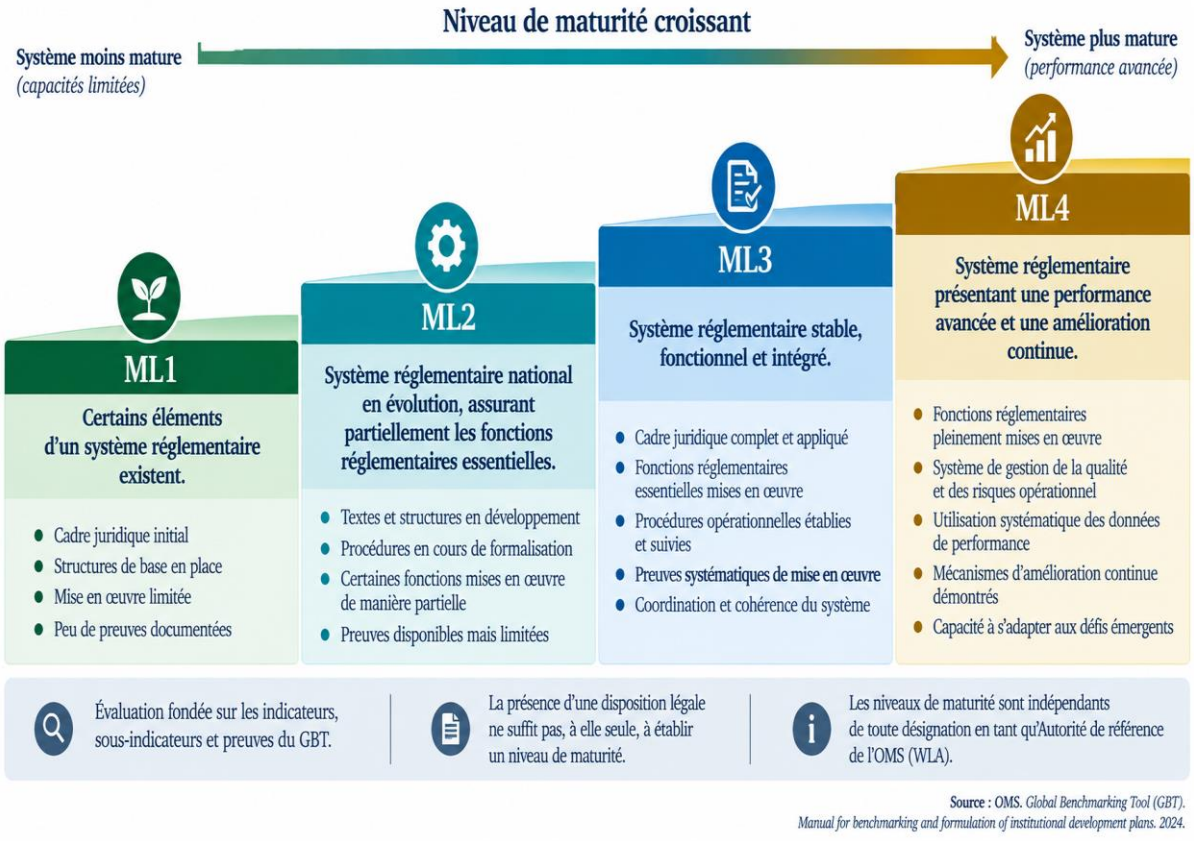


Figure 25 Les quatre niveaux de maturité réglementaire du GBT

L'objectif du programme de renforcement des systèmes réglementaires de l'OMS est d'aider les pays à atteindre et maintenir une surveillance efficace, efficiente et transparente, correspondant aux niveaux ML3 et ML4 [3].

ML3 constitue ainsi le seuil de maturité d'un système stable, fonctionnel et intégré ; ML4 traduit une performance avancée et une amélioration continue. Un point méthodologique est essentiel : le niveau global dépend des résultats obtenus dans les fonctions applicables et n'est pas la moyenne arithmétique de quelques indicateurs favorables.

La littérature décrivant le GBT souligne que la fonction la moins mature peut limiter le niveau global. Il est donc incorrect de conclure à ML3 uniquement parce qu'une nouvelle loi introduit plusieurs dispositions modernes [7]

3.1. Échelle d'appréciation des sous-indicateurs

Les fiches GBT utilisent des appréciations telles que Not Implemented (NI), Ongoing Implementation (OI), Partially Implemented (PI) et Implemented (I). Pour un sous-indicateur juridique, par exemple, la seule existence récente d'une disposition peut correspondre à une

phase partielle si les preuves de mise en œuvre ne sont pas encore consolidées ; le niveau « Implemented » suppose des dispositions satisfaisant l'exigence et effectivement appliquées et mises en œuvre [5].

4. Processus OMS de benchmarking et plan de développement institutionnel

Le renforcement réglementaire de l'OMS suit une séquence structurée : développement et maintenance du GBT ; benchmarking du système ; formulation d'un PDI/IDP ; renforcement des capacités par l'appui technique, la formation et les réseaux ; suivi continu des résultats et de l'impact [8]. Le manuel 2024 précise les modalités de préparation, d'évaluation, de gestion des preuves et de formulation du PDI [2].



Figure 26 Processus de benchmarking et de développement institutionnel de l'OMS

Le Maroc a fait l'objet d'une activité OMS de vérification et de revue du statut du système réglementaire des médicaments et vaccins utilisant le GBT, indiquée comme achevée pour la période janvier-août 2024 dans le dispositif UHC Partnership Live Monitoring [9].

Un document régional de l'OMS indique par ailleurs que le Maroc fait partie des pays engagés dans l'auto-benchmarking et que des évaluations formelles de certains pays de la Région sont attendues sur la période 2025-2028 [10].

Ces informations démontrent l'engagement dans le processus, mais elles ne constituent pas une publication officielle d'un niveau de maturité marocain.

5. Les fonctions réglementaires évaluées par le GBT

Pour les médicaments et vaccins, la Revision VI comprend un cadre transversal *« National Regulatory System (RS) »* et huit fonctions réglementaires : *Registration and Marketing Authorization (MA)*, *Vigilance (VL)*, *Market Surveillance and Control (MC)*, *Licensing Establishments (LI)*, *Regulatory Inspection (RI)*, *Laboratory Testing (LT)*, *Clinical Trials Oversight (CT)* et *NRA Lot Release (LR)* [5,11].

Ces fonctions couvrent le cycle de vie du produit, de l'autorisation et des essais à la surveillance post commercialisation.

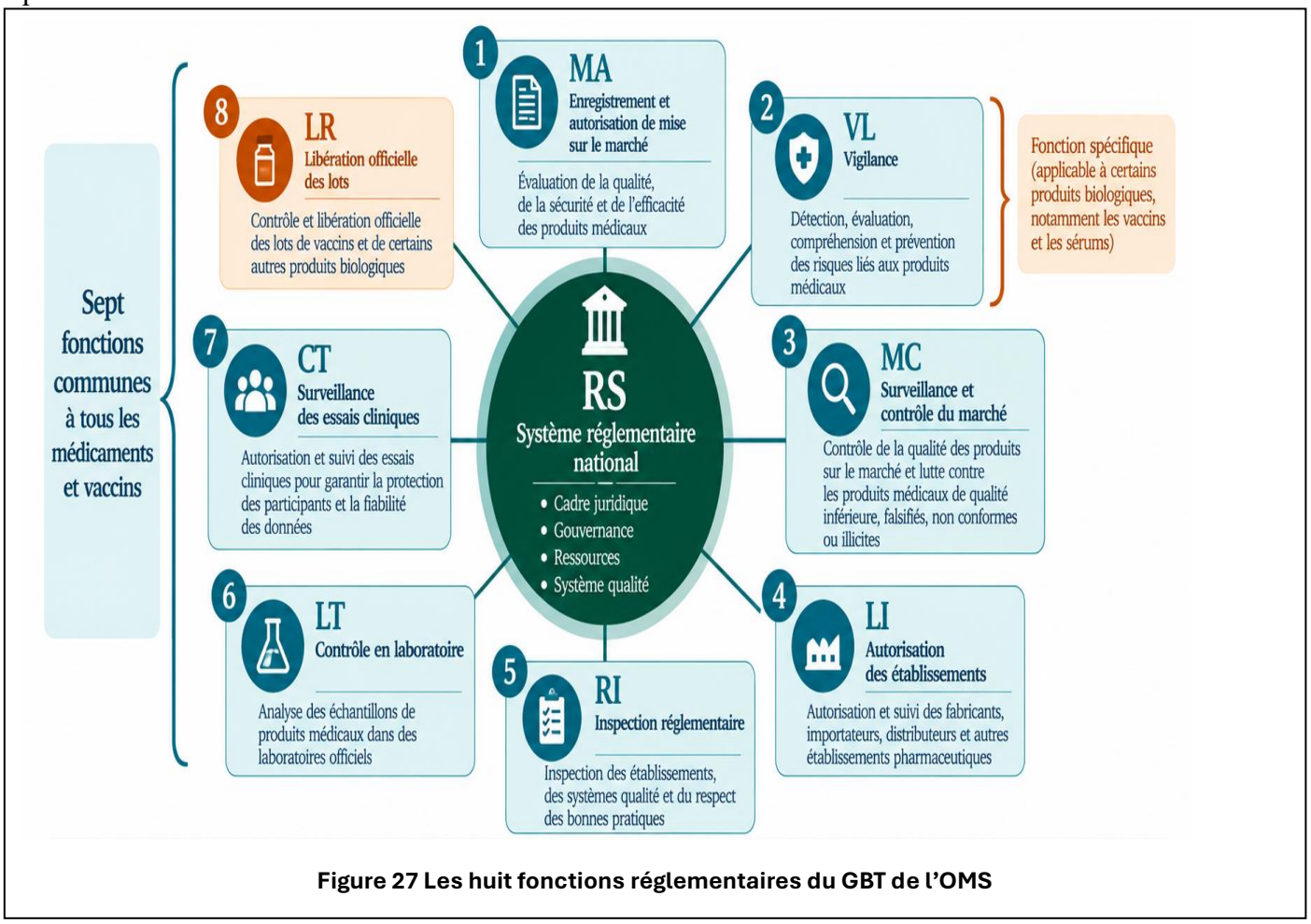


Figure 27 Les huit fonctions réglementaires du GBT de l'OMS

5.1. Système national de réglementation (RS)

Le RS constitue le socle qui permet aux fonctions spécialisées de fonctionner. L'OMS y examine notamment les bases légales, l'organisation, la gouvernance, l'indépendance, les mécanismes de coordination, la planification, la transparence, le système qualité, les ressources et la mesure de la performance [3,5].

Au Maroc, la loi n° 17-04 constitue le socle historique du médicament. La loi n° 10-22 a créé un établissement public dédié aux médicaments et produits de santé, avec personnalité morale et autonomie financière, et lui attribue des missions de coordination de la politique pharmaceutique, d'organisation et de contrôle du secteur ainsi que de veille sur la qualité, la sécurité et l'efficacité [12].

La loi n° 27-26 modifie ensuite plusieurs fonctions du Code. Ces textes constituent des preuves juridiques importantes, mais le GBT exige aussi des preuves organisationnelles et de performance.

5.2. Enregistrement et autorisation de mise sur le marché (MA)

Cette fonction évalue la capacité à recevoir, examiner et décider les demandes d'enregistrement/AMM selon des exigences définies, avec des critères de qualité, sécurité et efficacité, des procédures documentées, une gestion des variations et renouvellements, des délais, des compétences et des mécanismes de décision cohérents [5].

La loi 17-04 et le décret n° 2-14-841 structurent l'AMM. La réforme 27-26 reconfigure l'article 7 et introduit à l'article 8 bis l'AMM conditionnelle ainsi qu'un mécanisme d'autorisation d'urgence. Elle adapte aussi l'article 15. Du point de vue GBT, cela renforce le volet juridique de MA, mais l'évaluation de maturité requiert également des procédures opérationnelles, des dossiers traités, des délais réels, la qualité de l'évaluation et des preuves de suivi

5.3. Vigilance (VL)

La vigilance vise la détection, l'évaluation, la compréhension et la prévention des risques liés aux produits après leur utilisation. Le GBT recherche un mandat, des mécanismes de notification, d'analyse des signaux, de décision, de communication, d'inspection de vigilance et des preuves d'actions réglementaires [5].

La loi 27-26 remplace l'article 6 par une définition légale de la pharmacovigilance et un système national impliquant les acteurs concernés. L'article 120 impose en outre, dans l'établissement pharmaceutique industriel, un pharmacien ou médecin exclusivement chargé de la pharmacovigilance sous la responsabilité du pharmacien responsable. Ces changements rapprochent le cadre légal des exigences d'un système structuré. Toutefois, l'article 6 renvoie son organisation et son fonctionnement à un texte réglementaire : la maturité ne peut donc être déduite du seul texte législatif.

5.4. Surveillance et contrôle du marché (MC)

MC couvre la surveillance des produits présents sur le marché, la détection des produits de qualité inférieure ou falsifiés, l'échantillonnage, les alertes, retraits/rappels et les actions correctives. La fonction exige des programmes fondés sur le risque, des procédures et des preuves d'exécution [5].

Le nouvel article 131 bis de la loi 27-26 formalise le contrôle post-commercialisation : qualité des médicaments, publicité, gestion des alertes, retrait et rappel des lots, prévention/détection des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. C'est une correspondance juridique directe avec plusieurs composantes MC. Cependant, l'entrée en application de l'article 131 bis dépend de son texte réglementaire, ce qui impose de distinguer « disposition adoptée » et « fonction démontrée comme pleinement opérationnelle ».

5.5. Autorisation des établissements (LI)

LI apprécie les mécanismes d'autorisation/licence des fabricants, importateurs, grossistes et autres établissements pertinents, y compris les exigences documentaires, les responsabilités, la mise à jour des licences et le lien avec les inspections [5].

Le Code 17-04 encadre les établissements pharmaceutiques industriels et grossistes répartiteurs et leurs responsabilités. La loi 27-26 ne constitue pas une refonte générale de cette fonction. Dans un benchmark complet, LI doit donc être évaluée à partir du Code, des décrets d'exercice et d'ouverture, des procédures administratives et des preuves d'autorisation effectives, et non à partir de la seule réforme de 2026.

5.6. Inspection réglementaire (RI)

RI vérifie la conformité des établissements et activités aux bonnes pratiques applicables. Le GBT examine le mandat des inspecteurs, la planification fondée sur le risque, les procédures, les compétences, les rapports, les suites d'inspection et la coordination avec les autres fonctions [5].

Les articles 130 et 131 modifiés par la loi 27-26 renforcent le cadre de l'inspection et son rattachement institutionnel. L'article 130 mentionne notamment le contrôle des bonnes pratiques de fabrication, distribution, pharmacovigilance, officine et gestion des stocks en clinique, ainsi que la recherche d'infractions. Cela élargit la couverture juridique. La démonstration GBT exige néanmoins des plans d'inspection, SOP, qualifications, rapports, CAPA et données de suivi.

5.7. Contrôle en laboratoire (LT)

LT porte sur la capacité du système à accéder à des laboratoires compétents, à planifier et réaliser des analyses fiables, à gérer les échantillons, méthodes, résultats atypiques et décisions réglementaires associées. Les systèmes qualité et compétences analytiques sont centraux [5].

La législation marocaine comporte des mécanismes de contrôle de qualité et la réforme 2024 sur la libération officielle des lots exige l'examen de données de production et de résultats de contrôle pour les vaccins et sérums. Toutefois, la réforme 27-26 n'est pas, à elle seule, une réforme complète de LT. Un classement GBT nécessiterait des preuves sur le laboratoire national, ses méthodes, son système qualité, ses capacités, ses résultats et l'usage réglementaire de ces résultats.

5.8. Surveillance des essais cliniques (CT)

CT évalue le cadre légal et opérationnel des essais cliniques : autorisation, éthique, bonnes pratiques cliniques, sécurité des participants, modifications, suivi, inspections et communication des événements de sécurité [5].

Au Maroc, cette fonction ne doit pas être évaluée uniquement à travers la loi 27-26. Le cadre relatif aux recherches biomédicales et ses textes d'application doit être intégré au benchmark. Pour une conclusion de maturité, il faut documenter non seulement les textes mais aussi les procédures d'autorisation, les comités, les délais, les inspections et les dossiers effectivement supervisés.

5.9. Libération des lots par l'autorité nationale (LR)

LR concerne, lorsque la fonction est applicable, l'examen indépendant des lots de vaccins/produits biologiques par l'autorité ou le laboratoire national avant mise sur le marché, selon des procédures définies et fondées sur les données de fabrication et/ou de contrôle [5].

Le décret-loi n° 2-24-728 de 2024 a introduit les articles 17-1 à 17-4 dans la loi 17-04 : définition de la libération officielle, obligation de certificat pour chaque lot de vaccin ou sérum à usage humain fabriqué localement ou importé, exemption ciblée pour les lots acquis via l'UNICEF, et maintien de la responsabilité de l'établissement et du pharmacien responsable. L'article 150-1 prévoit une amende de 100 000 à 1 000 000 DH en cas de commercialisation en violation de l'obligation, doublée en récidive. Le décret n° 2-24-729 fixe les modalités de délivrance du certificat [13]. Cette réforme constitue une correspondance juridique particulièrement directe avec LR.

6. Matrice de correspondance : réformes marocaines et fonctions GBT

Fonction GBT (Code)	Textes marocains examinés (principaux)	Correspondance documentaire (avec les exigences du GBT)	Preuve opérationnelle restant à rechercher
RS Système réglementaire national	• Loi n° 17-04 • Loi n° 10-22	Cadre légal et mandat institutionnel de la régulation des médicaments. Définition des missions, attributions et organisation générale.	• Organigrammes et ressources effectives • Système de gestion de la qualité • Indicateurs de performance et rapports d'activité
MA Autorisation de mise sur le marché	• Loi n° 27-26 (articles 7 et 8 bis)	Régimes d'autorisation, procédures d'enregistrement et exigences d'évaluation des dossiers.	• Procédures opérationnelles détaillées • Données sur les dossiers traités (délais, issues) • Guides et lignes directrices publiés et appliqués
VL Pharmacovigilance	• Loi n° 27-26 (articles 6 et 120)	Mise en place d'un système national de pharmacovigilance et définition des responsabilités.	• Données nationales de vigilance (rapports, signalements) • Procédures de gestion des risques • Rapports périodiques et actions correctives
MC Surveillance du marché et contrôle	• Loi n° 27-26 (article 131 bis)	Renforcement du contrôle post-commercialisation et lutte contre les produits de qualité inférieure, falsifiés et illicites.	• Plans de surveillance du marché • Résultats des contrôles et des analyses • Gestion des alertes, retraits et rappels
LI Autorisation des établissements	• Loi n° 17-04 • Textes relatifs aux établissements pharmaceutiques (décrets et arrêtés)	Cadre des autorisations d'établissements pharmaceutiques (fabricants, importateurs, distributeurs, etc.).	• Registres des établissements autorisés • Dossiers de licences et conditions d'octroi • Inspections initiales et de suivi
RI Inspection réglementaire	• Loi n° 27-26 (articles 130 et 131)	Compétences et pouvoirs d'inspection renforcés, définition du périmètre et des modalités d'intervention.	• Procédures d'inspection et guides • Rapports d'inspection et plans d'actions • Suivi de la mise en conformité
LT Contrôle de laboratoire	• Cadre national de contrôle qualité (à documenter au-delà de la loi 27-26 : décrets, arrêtés, organisation du réseau laboratoires)	Correspondance partielle avec les exigences du GBT. Dispositions à compléter par les textes et documents d'organisation du contrôle qualité.	• Capacités analytiques des laboratoires officiels • Portée des essais et accréditations (ISO 17025) • Résultats des contrôles et participation aux EIL
CT Surveillance des essais cliniques	• Cadre des recherches biomédicales (à documenter séparément : loi, décrets, CNERS, etc.)	Non évalué sur la seule loi n° 27-26. Relève du cadre national des recherches biomédicales et des essais cliniques.	• Procédures d'autorisation des essais cliniques • Rapports d'inspection et suivi des essais • Base de données nationale des essais cliniques
LR Libération officielle des lots	• Décret-loi n° 2-24-728 (27/09/2024) • Décret n° 2-24-729 (30/09/2024)	Dispositif spécifique de libération officielle des lots de vaccins et de sérums à usage humain.	• Procédures de libération des lots • Certificats de libération et traçabilité • Données sur les délais et volumes traités

Correspondance juridique ≠ conformité démontrée aux sous-indicateurs OMS ; aucune maturité attribuée au Maroc.

Correspondance bien documentée dans les textes examinés | Correspondance partielle / à compléter | Preuve opérationnelle restant à rechercher dans les sources publiques

Source : Analyse documentaire du PFE ; OMS, Global Benchmarking Tool (GBT) Révision VI, 2021 ; textes marocains cités.

Figure 28 Matrice de correspondance entre les réformes marocaines et les fonctions GBT

7. Positionnement documentaire du Maroc dans l’approche de maturité

Les sources OMS disponibles permettent d’établir trois constats robustes. Premièrement, une mission de vérification/revue du système marocain utilisant le GBT est documentée comme achevée en 2024 [9].

Deuxièmement, le bureau régional OMS de la Méditerranée orientale décrit le Maroc comme engagé dans un processus d’auto-benchmarking, dans un contexte où des évaluations formelles sont programmées pour certains pays entre 2025 et 2028 [10]. Troisièmement, la liste OMS la plus récente des autorités reconnues ML3/ML4, publiée le 24 août 2026, ne fournit pas dans les sources publiques consultées une reconnaissance ML3 ou ML4 du Maroc [14].

Une réforme législative peut améliorer la conformité du cadre juridique à plusieurs exigences GBT, mais le niveau de maturité repose sur des preuves d’implémentation, d’intégration et de performance. Les nouvelles dispositions de 2024 et 2026 peuvent donc être interprétées comme des leviers de rapprochement avec les attentes du GBT, sans être transformées en score officiel.

8. GBT, ML3/ML4 et WHO-Listed Authority : ne pas confondre les concepts

L’évaluation de la maturité réglementaire et la désignation comme WHO-Listed Authority constituent deux processus complémentaires, mais distincts.

Le Global Benchmarking Tool permet d’apprécier le degré de développement et de fonctionnement d’un système réglementaire, tandis que le processus WLA repose sur une évaluation complémentaire de la performance.

L’atteinte du niveau global ML3 constitue une condition d’éligibilité, sous réserve des dispositions transitoires prévues par l’OMS, mais ne confère pas automatiquement le statut WLA. La figure suivante illustre cette articulation et les différentes étapes conduisant à une éventuelle désignation.

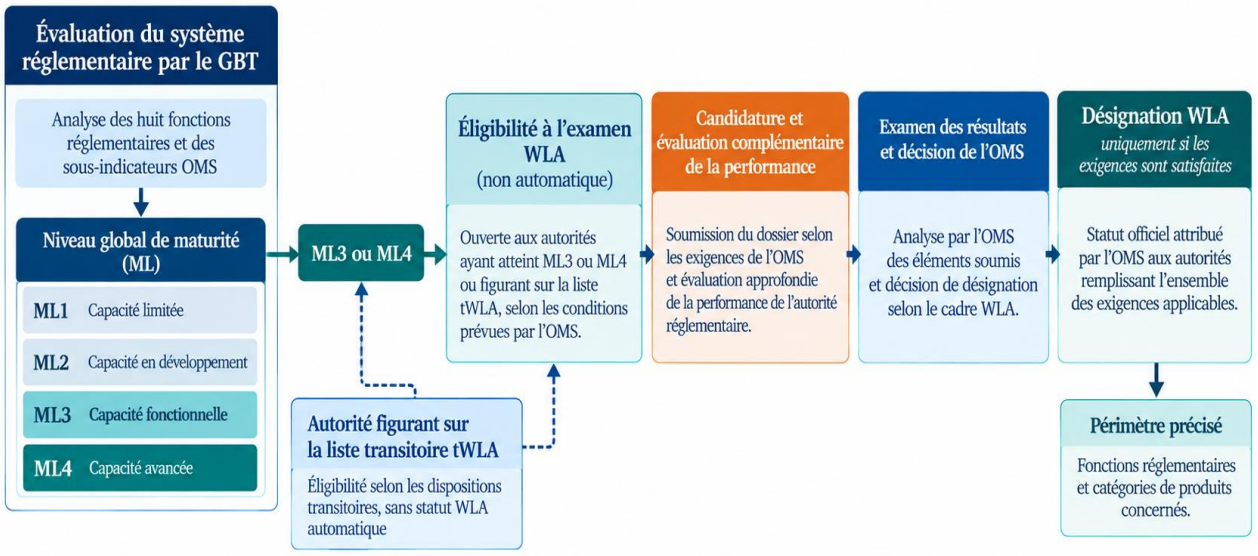


Figure 29 Distinction entre maturité GBT et statut WHO-Listed Authority (WLA)

Le niveau de maturité GBT et le statut WHO-Listed Authority (WLA) sont liés mais distincts. L'OMS indique qu'une autorité doit au minimum avoir atteint un niveau global ML3 pour être éligible au processus WLA, puis réussir une évaluation de performance complémentaire pour la ou les fonctions et catégories de produits demandées [15].

Le WLA ne doit donc pas être présenté comme un simple synonyme de ML3. Le cadre WLA vise à documenter la conformité aux indicateurs pertinents et la performance avancée, et peut soutenir la reliance réglementaire. Une étude publiée en 2024 dans Frontiers in Medicine décrit ce cadre comme une approche transparente et fondée sur les preuves, tout en soulignant des défis de ressources, de complexité et de conduite du changement [16].

11. Synthèse de benchmark documentaire au regard du Global Benchmarking Tool (GBT) de l'OMS

Le GBT fournit un référentiel beaucoup plus exigeant qu'une comparaison législative classique. Il examine le système national et huit fonctions réglementaires au moyen d'indicateurs, sous-indicateurs, fiches de preuve et neuf catégories transversales. Son architecture permet d'apprécier non seulement l'existence des règles, mais aussi leur mise en œuvre, leur intégration et leur performance.

Appliqué au Maroc, le benchmark documentaire montre que les réformes récentes touchent directement plusieurs fonctions clés. La réforme de 2024 renforce LR ; la loi 27-26 agit principalement sur MA, VL, MC et RI, tandis que LI, LT et CT exigent l'intégration d'autres textes et preuves. La loi 10-22 apporte des éléments pertinents pour le cadre RS. L'ensemble traduit une évolution normative cohérente avec plusieurs domaines couverts par le GBT, mais

une conclusion de maturité nécessite des preuves opérationnelles que les lois seules ne peuvent fournir.

Fonction GBT	Évolution juridique documentée	Preuves complémentaires nécessaires
RS Système réglementaire national	Loi n° 10-22 : cadre institutionnel Loi n° 17-04 et modifications	Organigrammes, ressources effectives, système de gestion de la qualité et indicateurs de performance.
MA Autorisation de mise sur le marché	Loi n° 27-26 : articles 7, 8 bis et 15	Procédures opérationnelles, dossiers traités et délais observés.
VL Pharmacovigilance	Loi n° 27-26 : articles 6 et 120	Procédures de vigilance, signalements et résultats des analyses.
MC Surveillance du marché et contrôle	Loi n° 27-26 : article 131 bis	Plans de surveillance du marché, alertes, rappels et bilans d'activité.
RI Inspection réglementaire	Loi n° 27-26 : articles 130 et 131	Rapports d'inspection, suites données et suivi des actions correctives.
LR Libération officielle des lots	Réforme de 2024 : articles 17-1 à 17-4	Dossiers de lots, décisions de libération et traçabilité.
LI, LT, CT Autres fonctions (établissements, laboratoires, essais cliniques)	Autres textes à intégrer au benchmark (loi 17-04, loi 27-26, décrets, arrêtés, etc.)	Autorisations d'établissements, capacités de laboratoire et dossiers d'essais cliniques.

Figure 30 Synthèse des correspondances entre les réformes du cadre juridique pharmaceutique marocain et les fonctions réglementaires du Global Benchmarking Tool de l'OMS.

La source OMS relative au Maroc confirme l'existence d'une activité de vérification/revue GBT achevée en 2024 et le contexte régional confirme l'engagement du pays dans l'auto-benchmarking. En revanche, aucune reconnaissance publique ML3/ML4 du Maroc n'a été identifiée dans la liste OMS la plus récente consultée.

La conclusion scientifiquement défendable est donc celle d'un système en réforme et engagé dans le processus GBT, dont la maturité officielle ne doit pas être présumée.

AXE 3 — Benchmark approfondi du système marocain de régulation pharmaceutique au regard du système réglementaire de l'Union européenne

1. Architecture institutionnelle : qui régule le médicament ?

1.1. Le réseau européen : plusieurs autorités, une réglementation coordonnée

L'Union européenne ne possède pas une « autorité européenne du médicament » qui remplacerait les autorités nationales. Le système est un réseau. Les autorités nationales compétentes des États de l'EEE conservent des compétences essentielles : autorisations nationales, évaluations coordonnées, inspections, contrôle des fabricants et grossistes, pharmacovigilance et surveillance du marché. L'EMA apporte une coordination scientifique et technique commune. La Commission européenne intervient notamment comme autorité décisionnelle pour les AMM centralisées. [6,7]

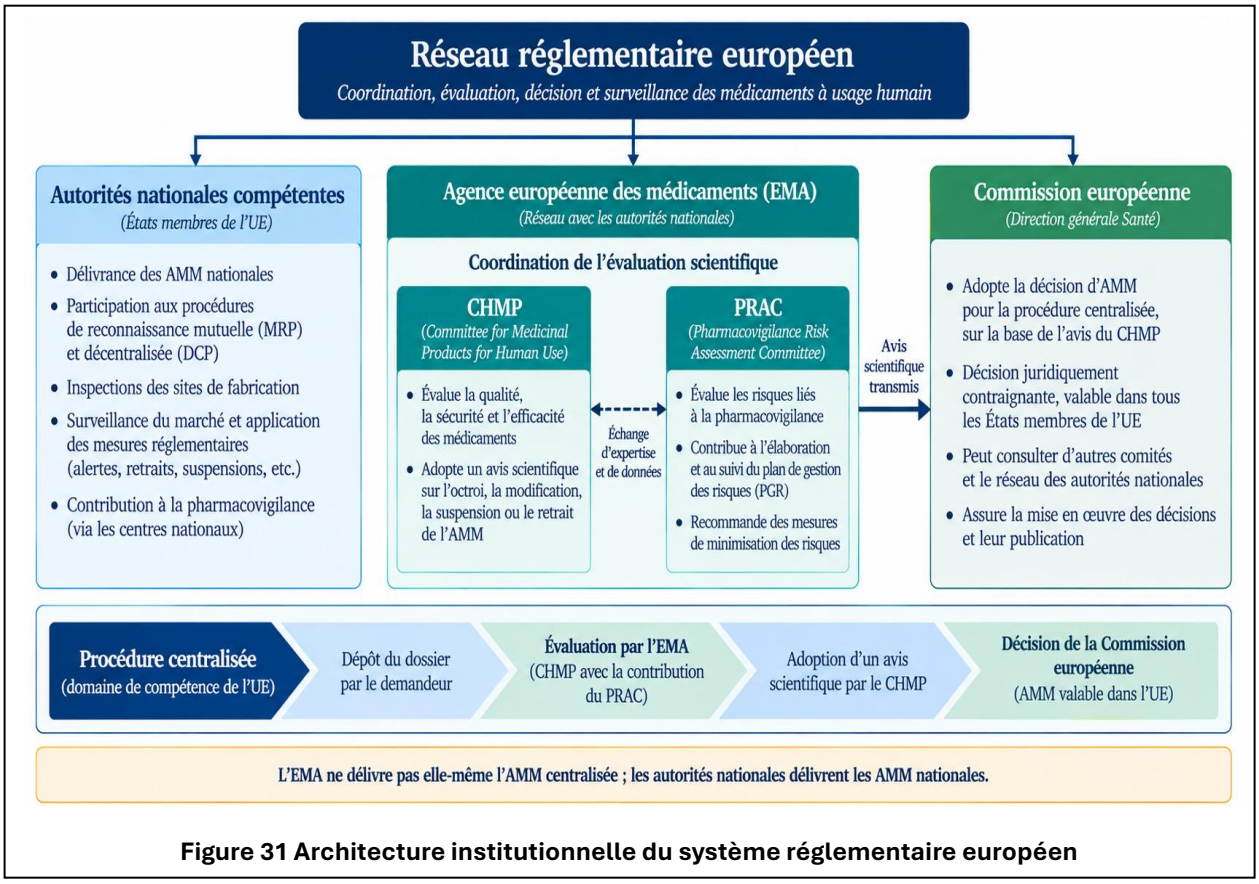


Figure 31 Architecture institutionnelle du système réglementaire européen

Cette distinction produit une chaîne précise. Dans une procédure centralisée, le dossier est soumis dans le cadre EMA ; le CHMP organise l'évaluation scientifique et adopte un avis ; lorsque le produit est un ATMP, l'expertise spécifique est mobilisée ; les aspects de sécurité

peuvent impliquer le PRAC ; après l'avis scientifique, la Commission adopte la décision juridiquement contraignante. Dire « l'EMA délivre l'AMM » simplifie donc excessivement le mécanisme. [6,7 ;43 ;12,13]

Pour les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées, les décisions restent nationales mais sont coordonnées. Le CMDh intervient lorsqu'il existe des désaccords entre États. Si un État invoque un risque potentiel grave pour la santé publique, le CMDh cherche un accord ; à défaut, le différend peut conduire à un arbitrage européen. Le réseau transforme ainsi plusieurs autorités nationales en un système capable de produire une position commune. [5,6]

1.2. Réforme européenne : simplifier sans supprimer l'expertise

Le nouveau paquet réorganise la structure scientifique de l'EMA. L'objectif est de concentrer la structure permanente principale autour du CHMP et du PRAC, tout en maintenant l'accès à l'expertise pédiatrique, orpheline, ATMP et autres domaines via des groupes de travail et pools d'experts. Il ne s'agit donc pas de supprimer l'expertise spécialisée, mais de modifier sa forme institutionnelle afin de réduire les duplications et de libérer du temps d'experts. [1-4;6,7;9;41;42]

1.3. Maroc : centralisation nationale autour de l'AMMPS

Tableau 1 Benchmark comparatif de l'architecture institutionnelle et de la gouvernance du système de régulation pharmaceutique dans l'Union européenne et au Maroc

Dimension comparée	Union européenne — système applicable en 2026	Maroc — système applicable / réforme 2026	Analyse comparative
Modèle général de gouvernance	Réseau réglementaire multiniveau associant les autorités nationales compétentes (NCAs), l'EMA et la Commission européenne. L'EMA coordonne et soutient le réseau ; elle ne remplace pas les autorités nationales.	Modèle national organisé autour de l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé (AMMPS), établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créé par la loi n° 10-22. La loi n° 27-26 renforce son inscription dans le Code du médicament.	Différence structurelle majeure. Il serait incorrect de rechercher un équivalent marocain individuel de chaque composante du réseau européen. La comparaison doit porter sur les fonctions réglementaires exercées.
Niveau territorial	Niveau européen et national : compétences réparties entre les institutions de l'Union et les autorités des États membres/EEE.	Niveau national, avec possibilité de représentations territoriales de l'AMMPS prévue par la loi n° 10-22.	L'UE doit organiser une coordination entre plusieurs juridictions nationales ; le Maroc fonctionne dans un cadre juridique national.
Autorité / structure scientifique centrale	L'EMA coordonne l'expertise scientifique et technique du réseau et travaille avec plus de 50 autorités nationales compétentes.	L'AMMPS constitue l'agence nationale spécialisée du médicament et des produits de santé ; les réformes récentes renforcent plusieurs de ses fonctions réglementaires.	Convergence fonctionnelle, mais architecture différente : l'EMA est une composante coordinatrice d'un réseau européen ; l'AMMPS est une agence nationale.
Autorités nationales	Les NCAs restent essentielles : elles sont notamment responsables des médicaments qui ne relèvent pas de la procédure centralisée et exercent également d'autres fonctions réglementaires.	Les fonctions réglementaires sont organisées dans le cadre institutionnel national, avec l'AMMPS au centre de la réforme et d'autres autorités compétentes selon le domaine.	Les NCAs ne doivent pas être supprimées du schéma européen au profit de l'EMA : elles constituent une composante essentielle du système.

Expertise scientifique	Les experts des autorités nationales participent aux comités scientifiques, groupes de travail et équipes d'évaluation de l'EMA. Le réseau permet de mutualiser plusieurs milliers d'experts.	Expertise organisée dans le cadre institutionnel national de l'AMMPS et des structures compétentes marocaines.	UE : mutualisation multinationale de l'expertise. Maroc : expertise organisée dans un cadre national.
Évaluation d'une AMM centralisée / nationale	Dans la procédure centralisée, le CHMP réalise l'évaluation scientifique des médicaments humains. Le PRAC contribue notamment aux aspects de gestion des risques et le CAT apporte l'expertise spécifique pour les ATMP.	Évaluation conduite dans le cadre national marocain conformément au Code du médicament et aux procédures applicables.	Même finalité générale d'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité / du rapport bénéfice-risque, mais chaîne institutionnelle différente.
Décision d'AMM	Pour la procédure centralisée, le CHMP émet un avis scientifique puis la Commission européenne prend la décision juridiquement contraignante. Il est donc inexact d'écrire simplement que « l'EMA délivre l'AMM ».	Décision prise dans le cadre national marocain selon le Code du médicament et les compétences attribuées aux autorités nationales.	Dans l'UE centralisée, l'évaluation scientifique et la décision juridique sont institutionnellement distinguées.
AMM hors procédure centralisée	Les autorités nationales sont principalement responsables des médicaments ne relevant pas de la procédure centralisée. Les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées permettent une coordination entre États.	Pas d'équivalent nécessaire à une coordination entre plusieurs États membres : le système est national.	Différence liée à la nature supranationale de l'UE, et non à une lacune du système marocain.
Gestion des divergences	Le CMDh intervient notamment dans les procédures de reconnaissance mutuelle et décentralisées et cherche à résoudre les désaccords entre États ; des mécanismes d'arbitrage européen existent selon les cas.	Aucun équivalent fonctionnel exact n'est attendu pour arbitrer des divergences entre États, puisque le Maroc constitue une juridiction nationale unique.	Non-comparabilité structurelle plutôt qu'insuffisance marocaine.
Portée géographique de l'AMM	Une AMM centralisée accordée par la Commission est valable dans l'ensemble de l'Union européenne et dans les pays de l'EEE concernés.	Portée nationale marocaine.	Différence inhérente aux territoires couverts par les deux systèmes.
Partage des ressources et de l'expertise	Le réseau européen permet la mutualisation des ressources scientifiques des États et l'accès à plusieurs milliers d'experts.	Une mutualisation supranationale comparable n'est pas applicable au modèle national marocain.	Caractéristique structurelle du modèle en réseau ; elle ne permet pas, à elle seule, de conclure à une performance réglementaire supérieure.
Infrastructure commune d'information	L'EMA et les autorités nationales utilisent des standards, processus et systèmes communs permettant l'échange et l'analyse d'informations dans plusieurs domaines réglementaires.	Le Maroc développe ses propres outils nationaux. Leurs équivalences précises avec les infrastructures européennes doivent être étudiées fonction par fonction.	Différence d'échelle et d'intégration ; aucune conclusion sur l'équivalence opérationnelle ne doit être anticipée à ce stade.
Inspection et contrôle du marché	Fonctions largement exercées au niveau des autorités nationales dans un environnement réglementaire et documentaire coordonné au niveau européen.	La loi n° 27-26 renforce explicitement l'inscription de l'AMMPS dans l'inspection et le contrôle du marché.	Convergence fonctionnelle ; les mécanismes opérationnels et les outils doivent être comparés séparément.
Nature de la coordination	Coordination verticale et horizontale : UE ↔ États membres et État ↔ État, avec l'EMA, la Commission, les comités et groupes comme mécanismes de coordination.	Coordination principalement organisée au sein du système national marocain.	Différence institutionnelle structurante du benchmark.
Réformes récentes et perspectives	Le cadre européen est en transition en 2026. Les règles actuellement applicables doivent être distinguées du nouveau paquet pharmaceutique en cours de finalisation législative et non encore applicable.	Réorganisation institutionnelle récente avec la loi n° 10-22 créant l'AMMPS et la réforme n° 27-26 du cadre pharmaceutique.	Les deux systèmes sont en transformation, mais selon des logiques institutionnelles différentes. Les réformes futures ne doivent pas être présentées comme déjà applicables.

Conclusion du benchmark institutionnel	Réseau supranational intégré et distribué : NCAs + EMA + Commission + comités/groupes + mécanismes communs.	Agence nationale spécialisée opérant dans un système juridique national.	D — différence structurelle documentée, avec convergence de plusieurs fonctions réglementaires. Cette différence ne constitue pas, en elle-même, une mesure de performance.

La comparaison met en évidence deux modèles institutionnels distincts. Le système européen repose sur un réseau réglementaire multiniveau dans lequel les autorités nationales compétentes conservent des responsabilités essentielles, tandis que l'EMA coordonne l'expertise scientifique et que la Commission européenne exerce notamment le pouvoir décisionnel pour les autorisations centralisées.

Le Maroc repose sur une architecture nationale organisée autour de l'AMMPS, agence spécialisée créée par la loi n° 10-22 et dont les fonctions sont renforcées dans le cadre des réformes récentes. Cette différence d'architecture ne doit pas être interprétée comme un écart de performance : la comparaison pertinente porte sur la capacité de chaque système à assurer les fonctions réglementaires requises, leurs procédures, leurs outils, leur traçabilité et leurs résultats.

2. Développement du médicament et essais cliniques

2.1. Pourquoi la régulation commence avant l'AMM

La qualité de l'AMM dépend de la manière dont les preuves ont été générées. Le régulateur intervient donc avant le dépôt d'AMM : conseil scientifique, qualification de méthodes, développement pédiatrique, essais cliniques, bonnes pratiques cliniques et gestion du médicament expérimental. Le benchmark doit intégrer cette phase, car deux systèmes peuvent exiger un CTD comparable tout en différant fortement dans la coordination du développement. [9;42;25]

2.2. CTIS : portail unique, mais décisions nationales

Le règlement (UE) n° 536/2014 a remplacé la logique de demandes séparées de l'ancienne directive par une procédure coordonnée. Depuis le 31 janvier 2023, les nouvelles demandes d'essais passent par CTIS. Depuis le 31 janvier 2025, les essais encore conduits sous l'ancien régime doivent être conformes au règlement et enregistrés dans CTIS. EudraCT n'est donc plus la voie de conduite des essais dans l'UE/EEE, sauf fonctions résiduelles précises. [10;39,40]

CTIS remplit plusieurs fonctions : dépôt d'une demande unique, coordination de l'évaluation entre États concernés, échanges entre promoteur et autorités, gestion des modifications substantielles et publication d'informations. L'EMA maintient le système, mais ce sont les États membres qui évaluent et autorisent les essais. Cette distinction est importante pour comprendre la gouvernance. [10]

2.3. Conseil scientifique, PRIME et développement accéléré

Le conseil scientifique permet au développeur d'obtenir un avis sur les études nécessaires pour démontrer qualité, sécurité et efficacité. PRIME est un dispositif de soutien renforcé pour des médicaments susceptibles de répondre à un besoin médical non satisfait. PRIME ne constitue ni une AMM conditionnelle ni une évaluation accélérée ; il intervient plus tôt, afin d'optimiser le plan de développement et de faciliter un dialogue précoce avec le régulateur. [9;5,6;25]

2.4. Maroc : lignes directrices CTD et essais cliniques 2026

Le 19 février 2026, l'AMMPS a publié des lignes directrices relatives aux données non cliniques et cliniques du CTD. Elles couvrent les données déposées pour une demande d'AMM mais aussi le dossier d'un médicament expérimental à l'appui d'une demande d'autorisation d'essai clinique. En avril 2026, l'Agence a également publié une ligne directrice pour la conduite des essais cliniques en situation d'urgence. [28,29;31]

Le résultat du benchmark est donc plus nuancé qu'un simple « UE digitalisée / Maroc non digitalisé ». Le Maroc formalise ses exigences de preuve et ses procédures. En revanche, le corpus ne démontre pas une plateforme nationale réunissant les fonctions multinationales et publiques de CTIS. L'écart porte ici principalement sur l'intégration de l'infrastructure et la coordination entre juridictions. [10]

3. Autorisation de mise sur le marché : analyse détaillée de la procédure

3.1. Les quatre voies européennes et leur logique

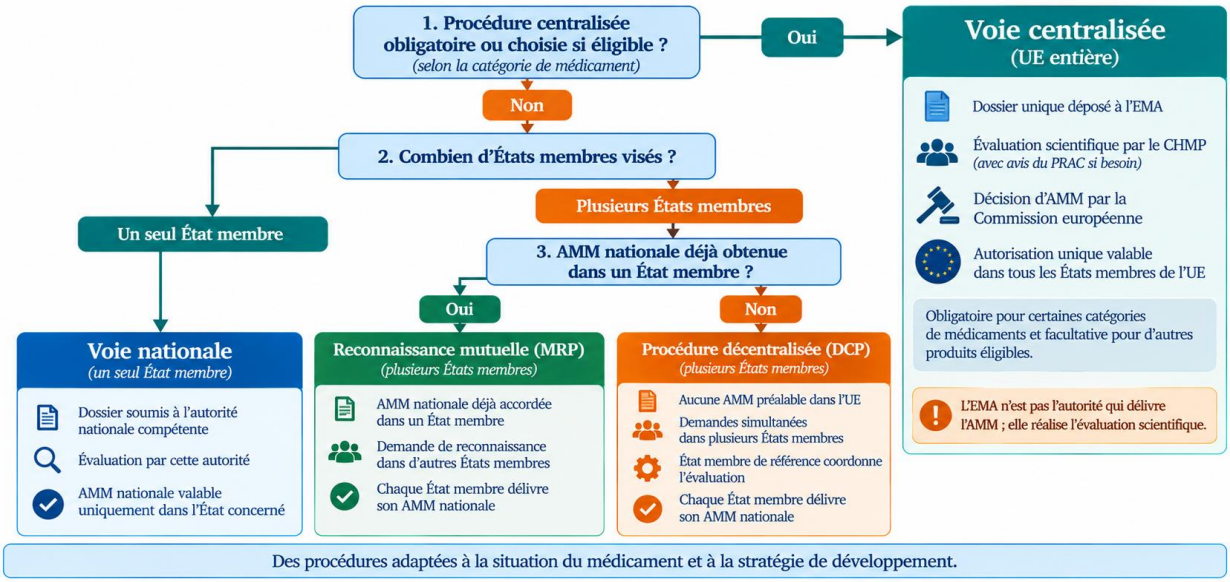


Figure 32 Les quatre voies d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne

La procédure centralisée aboutit à une autorisation unique valable dans le champ territorial européen concerné. Elle est obligatoire pour plusieurs catégories de produits innovants et peut être ouverte à d'autres produits éligibles. La procédure nationale aboutit à une AMM dans un seul État. La MRP suppose qu'une AMM existe déjà dans un État membre de référence ; les autres États sont invités à reconnaître l'évaluation. La DCP est utilisée lorsqu'aucune AMM n'existe encore et que plusieurs États doivent évaluer simultanément le dossier. [6,7 ;25]

La MRP et la DCP ne sont donc pas des « petites procédures centralisées ». L'autorité de référence produit ou porte l'évaluation, les États concernés examinent cette évaluation, les désaccords sont traités dans le mécanisme de coordination, et les autorisations finales restent nationales.

3.2. Centralisée : ce que signifient réellement les 210 jours

Le chiffre de 210 jours correspond au temps réglementaire actif maximal d'évaluation scientifique dans la procédure centralisée standard, et non à 210 jours calendaires entre dépôt et décision. Avant le démarrage, le dossier doit être validé. Une fois l'évaluation commencée, les rapporteurs préparent leurs analyses. Une première phase conduit à une liste de questions autour du jour 120. Le chronomètre réglementaire est alors interrompu pendant que le demandeur prépare ses réponses. [6,7;7]

Après réception de réponses jugées recevables, le clock redémarre. Une seconde phase approfondit les points encore ouverts. Une liste de points en suspens peut être adoptée vers le jour 180. Un second clockstop peut être nécessaire. Le CHMP peut demander une explication orale lorsque les questions ne peuvent pas être résolues uniquement par écrit. L'avis est ensuite adopté au terme du calendrier scientifique, normalement au plus tard au jour 210. [6,7]

L'EMA précise que le premier clock-stop dure souvent environ trois mois et le second environ un mois, mais la durée doit être convenue selon le temps nécessaire au demandeur. C'est pourquoi l'évaluation complète d'un nouveau médicament dure fréquemment autour d'un an. Le délai scientifique et le délai calendaire réel ne doivent donc jamais être confondus. [7,8]

3.3. Évaluation accélérée : 150 jours, mais mêmes exigences de preuve

Le demandeur peut solliciter une évaluation accélérée lorsque le médicament est considéré comme présentant un intérêt majeur pour la santé publique. La demande doit être justifiée et préparée avant le dépôt. Si le CHMP l'accepte, le temps d'évaluation est ramené à 150 jours. Les exigences de preuve restent les mêmes : l'accélération ne signifie pas que qualité, sécurité ou efficacité sont évaluées avec un standard inférieur. [6,7;8]

Le calendrier accéléré actuel est structuré en phases plus courtes. Les lignes procédurales EMA décrivent notamment un découpage 90 + 30 + 30 jours pour les médicaments ordinaires, avec un clock-stop par défaut d'un mois après la liste de questions du jour 90 et, par défaut, pas de

clock-stop après les points en suspens du jour 120. Les ATMP peuvent suivre un découpage adapté du fait de l'expertise supplémentaire. [7,8 ;43 ;30,33]

3.4. Après l'avis CHMP : l'AMM n'est pas encore la simple signature de l'EMA

Un avis positif du CHMP est une étape scientifique déterminante, mais il n'est pas lui-même la décision juridique de la Commission. Les documents de l'avis, notamment l'information produit, sont finalisés et la procédure décisionnelle de l'Union conduit ensuite à la décision de la Commission. Après autorisation, l'EPAR rend publique l'évaluation et les motifs scientifiques, sous réserve des règles de confidentialité. [6,7 ;7 ;25]

3.5. Nouveau paquet : 210 → 180 jours

Le nouveau règlement fixe un objectif de 180 jours pour l'avis scientifique du CHMP sur une demande valide, au lieu du maximum standard actuel de 210 jours. La diminution est de 30 jours de temps réglementaire actif, soit environ 14,3 %. Elle ne signifie pas automatiquement une réduction de 14,3 % du temps calendaire total, car les périodes de réponse du demandeur et d'autres étapes restent distinctes. [6,7 ;7 ;1,3 ;30,33]

L'évaluation accélérée demeure à 150 jours. La réforme cherche donc surtout à rapprocher la procédure standard d'un calendrier plus court tout en maintenant une voie accélérée pour les produits répondant aux critères. [8]

3.6. Validité et renouvellement : changement de logique

Dans le droit actuel, une AMM est normalement valable cinq ans. Avant son expiration, le rapport bénéficerisque est réévalué pour le renouvellement. Après renouvellement, l'AMM devient en principe illimitée, sauf si l'autorité exige un nouveau renouvellement à cinq ans pour des raisons de pharmacovigilance. [5,6]

Le nouveau cadre rend l'AMM illimitée par défaut dès l'origine, avec possibilité de limiter sa validité à cinq ans lorsqu'une justification de sécurité l'exige. La surveillance du cycle de vie remplace donc davantage le renouvellement administratif systématique. [1,3]

3.7. Maroc : comment comparer correctement l'article 7

L'article 7 modifié distingue l'AMM permettant la commercialisation au Maroc et éventuellement l'exportation, l'AMM exclusivement destinée à l'exportation et l'autorisation spéciale. Cette classification ne correspond pas aux quatre voies européennes, car elle ne répond pas au problème de coordination entre plusieurs États. Une comparaison numérique « 4 procédures UE contre 3 Maroc » serait méthodologiquement fausse. [29;25]

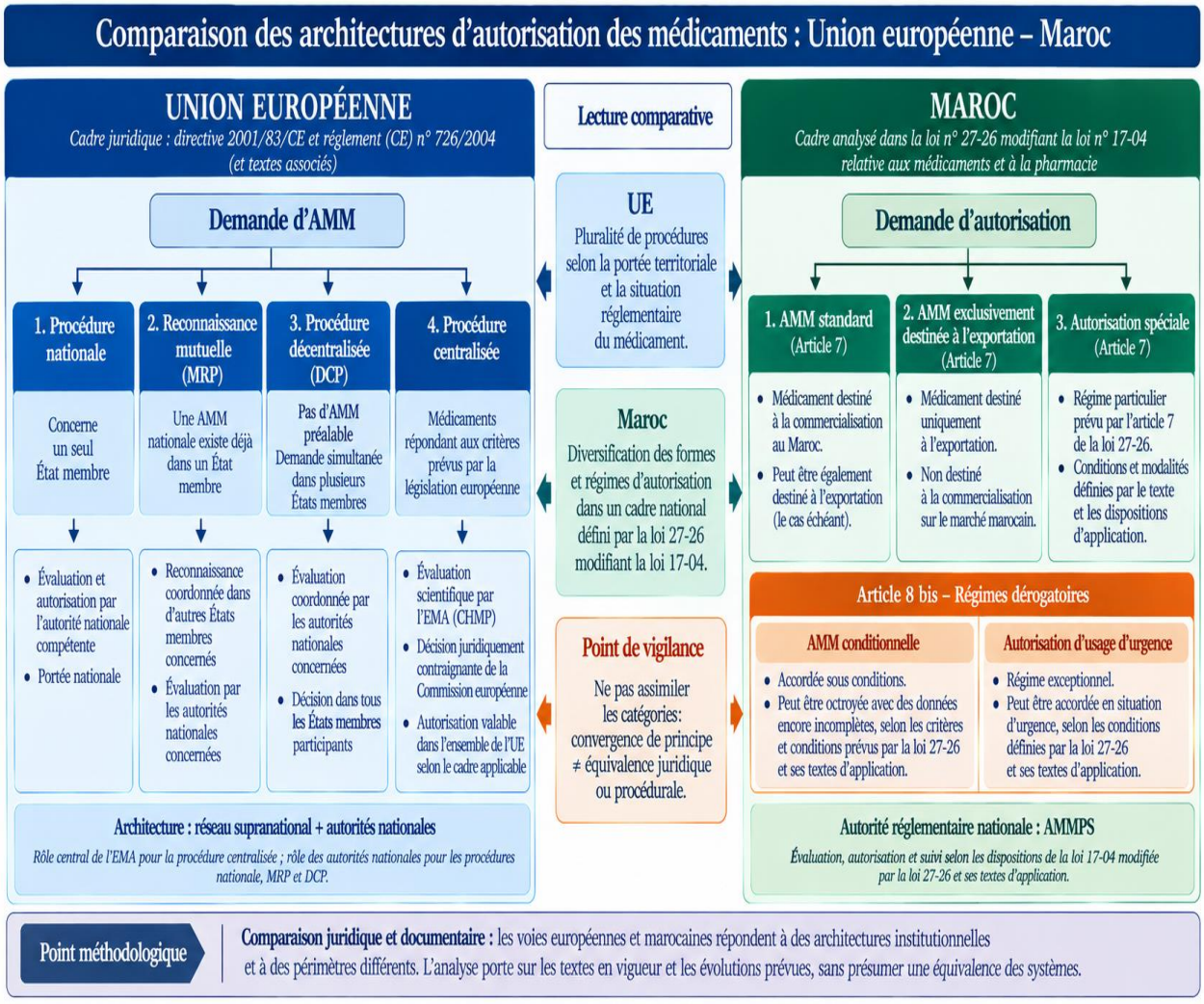


Figure 33 Comparaison des architectures d'autorisation des médicaments : Union européenne - Maroc

Cette figure met en parallèle une architecture européenne distribuée entre plusieurs procédures et acteurs avec une architecture marocaine nationale centrée sur l'AMMPS. Elle ne doit pas être lue comme un classement : les deux systèmes remplissent la fonction d'autoriser la mise sur le marché, mais selon des niveaux territoriaux, des circuits décisionnels et des mécanismes de coordination différents. Elle clôt logiquement la comparaison de l'AMM standard avant d'aborder les régimes particuliers.

La comparaison utile porte sur les exigences du dossier, l'évaluation qualité-sécurité-efficacité, le rôle de l'autorité, les conditions de décision et les mécanismes post-AMM. Les lignes directrices CTD publiées par l'AMMPS en 2026 constituent ici une source importante : elles précisent les attentes non cliniques et cliniques et couvrent des catégories comme génériques, biosimilaires et vaccins. [28,29;31;5,31]

Tableau 2 Benchmark comparatif de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) dans l'Union européenne et au Maroc

Dimension comparée	Union européenne — droit applicable en 2026	Maroc — cadre documenté / réforme 2026	Analyse comparative
Finalité de l'AMM	Autoriser un médicament après évaluation de sa qualité, sécurité, efficacité et de son rapport bénéfice-risque. Selon la voie, l'autorisation est européenne ou nationale.	AMM nationale après évaluation selon le Code du médicament. L'article 7 modifié distingue notamment commercialisation au Maroc/éventuelle exportation, AMM exclusivement destinée à l'exportation et autorisation spéciale.	Convergence forte de finalité ; classifications territoriales différentes.
Voies d'AMM	Quatre logiques : centralisée, nationale, décentralisée (DCP) et reconnaissance mutuelle (MRP).	Cadre national organisé selon les catégories de l'article 7 modifié et les procédures marocaines.	Ne pas comparer « 4 UE contre 3 Maroc » : les classifications répondent à des problèmes différents.
Centralisée	Une demande, une évaluation scientifique européenne et une AMM valable dans l'ensemble du territoire concerné ; obligatoire pour certaines catégories et possible pour d'autres produits éligibles.	Pas d'équivalent supranational attendu dans un système national.	Différence structurelle, non lacune marocaine.
Nationale	Une autorité nationale évalue et autorise pour son marché lorsque le produit ne relève pas obligatoirement de la centralisée.	Évaluation et décision dans le cadre national marocain.	Logique territoriale la plus directement comparable.
DCP	Pour un produit pas encore autorisé dans l'UE : évaluation coordonnée simultanée par plusieurs États, avec État de référence ; décisions finales nationales.	Pas d'équivalent interétatique nécessaire.	Différence inhérente à l'UE multinationale.
MRP	Une AMM existe déjà dans un État de référence ; d'autres États reconnaissent l'évaluation selon la procédure coordonnée.	Pas d'équivalent interétatique nécessaire.	Non-comparabilité structurelle.
Désaccords	CMDh et, selon les cas, arbitrage européen pour les divergences DCP/MRP.	Pas d'arbitrage entre États membres attendu.	Différence de gouvernance territoriale.
Dossier d'AMM	Dossier CTD/eCTD : données administratives, qualité, non cliniques et cliniques selon la base juridique.	Le PDF documente des lignes directrices CTD AMMPS 2026, notamment sur les données non cliniques et cliniques et plusieurs catégories de produits.	Convergence importante de structuration ; identité complète à démontrer module par module.
Critères scientifiques	Qualité, sécurité, efficacité et rapport bénéfice-risque favorable.	Même logique d'évaluation qualité-sécurité-efficacité retenue dans le benchmark.	Convergence scientifique forte.
Validation	La demande centralisée est validée avant le début du calendrier actif d'évaluation.	Le PDF ne décrit pas assez finement la chronologie nationale pour assimiler chaque étape à la validation EMA.	Recevabilité administrative ≠ évaluation scientifique.
Évaluation scientifique	CHMP, rapporteurs/co-rapporteurs et expertise des comités/groupes concernés ; coordination EMA.	Évaluation dans le cadre national par l'AMMPS/autorité compétente selon les textes applicables.	Même fonction, architecture différente.
Décision juridique	Le CHMP rend l'avis scientifique ; la Commission européenne adopte la décision juridiquement contraignante pour la centralisée.	Décision dans le cadre national marocain par l'autorité compétente.	UE : séparation institutionnelle avis scientifique / décision juridique.
Délai standard actuel	Maximum de 210 jours actifs d'évaluation scientifique, hors clock-stops.	Pas de délai marocain directement comparable documenté dans §3 du PDF.	Ne pas comparer temps actif européen et délai calendaire marocain sans définition commune.
Séquence 210 jours	Après validation : évaluation ; liste de questions vers J120 ; clock-stop ; reprise ; points en suspens possibles vers J180 ; second clock-stop possible ; avis normalement au plus tard J210.	Jalons J120/J180/J210 équivalents non démontrés dans le corpus marocain.	UE : calendrier public standardisé ; Maroc : équivalence précise ND.
Clock-stop	Le chronomètre actif s'arrête pendant les réponses du demandeur. Le premier clock-stop dure souvent ~3 mois et le second ~1 mois, selon accord.	Mécanisme identique non démontré dans §3.	Explique pourquoi 210 jours actifs ≠ 210 jours calendaires.
Durée réelle	L'évaluation complète dure souvent autour d'un an ; elle inclut notamment clock-stops et étapes post-avis/décision.	Données empiriques marocaines comparables non fournies dans §3.	La performance exige des délais réels calculés avec la même définition.
Évaluation accélérée	Pour médicaments d'intérêt majeur de santé publique : sur demande justifiée, 150 jours actifs au lieu de 210.	Équivalent strict non documenté dans §3.	Différence de mécanisme documenté ; ne pas conclure à l'absence de toute priorisation au Maroc.
Niveau de preuve accéléré	L'accélération ne réduit pas le standard de preuve ; le dossier doit être mature.	Non comparable terme à terme faute de mécanisme identique démontré.	Accéléré ≠ dossier incomplet ; les autorisations avec données incomplètes relèvent du T4.
Calendrier accéléré	150 jours actifs ; guidance EMA 2026 : schéma 90 + 30 + 30 pour médicaments	Équivalent précis non démontré.	UE : procédure détaillée ; Maroc : ND.

	ordinaires, adapté pour ATMP.		
Après avis CHMP	Finalisation des documents puis décision de la Commission ; publication réglementaire et EPAR.	Décision nationale ; équivalent public strict de l'EPAR non démontré dans §3.	Différence de transparence à approfondir dans T16.
EPAR	Rapport public expliquant l'évaluation scientifique et les raisons de la décision, après traitement des informations confidentielles.	AMMPS publie guides, notes et documents ; le PDF ne démontre pas un EPAR marocain systématique.	Type d'information publique différent ; équivalence EPAR = ND.
Portée territoriale	AMM centralisée valable dans toute l'UE et l'EEE concerné.	Portée nationale ; article 7 distingue aussi commercialisation Maroc/éventuelle exportation et exportation exclusive.	Différence territoriale inhérente.
Validité actuelle UE	En principe 5 ans ; après renouvellement, durée normalement illimitée, sauf renouvellement supplémentaire justifié notamment par pharmacovigilance.	Mécanisme directement superposable non établi dans §3.7.	À détailler avec le cycle de vie post-AMM au T17.
Réforme UE 2026 — statut	Conseil : position en première lecture adoptée le 28/09/2026. Au 30/09/2026, adoption du Parlement et publication au JO restent nécessaires : nouveau cadre non encore applicable.	Réformes marocaines 10-22/27-26 dans un contexte national distinct.	Toujours séparer droit UE actuel et futur cadre.
Réforme UE — délai	Le PDF benchmark présente le futur cadre comme réduisant le maximum standard de 210 à 180 jours actifs, tandis que l'accélérée reste à 150 jours.	Pas d'équivalent direct identifié dans 27-26 par le corpus.	Orientation vers simplification ; le temps calendaire total reste distinct du temps actif.
Réforme UE — validité	Le futur cadre étudié prévoit une AMM illimitée par défaut, avec possibilité de limitation à 5 ans pour raisons de sécurité.	Pas d'équivalent direct démontré dans le corpus 27-26.	Passage d'un renouvellement administratif systématique vers davantage de surveillance continue.
Article 7 marocain	Voies UE classées surtout selon territorialité et coordination entre autorités.	Article 7 : commercialisation Maroc/éventuelle exportation ; exportation exclusive ; autorisation spéciale.	Pas de correspondance artificielle voie par voie.
CTD AMMPS 2026	CTD/eCTD + corpus scientifique et procédural européen étendu.	Guides CTD AMMPS 2026 précisant les attentes non cliniques/cliniques et couvrant notamment génériques, biosimilaires, vaccins selon le PDF.	Convergence de formalisation ; équivalence complète à démontrer.
Conclusion	Système multivoies, coordination européenne, calendrier actif standardisé, accélération, décision Commission et transparence EPAR.	Système national centré sur l'article 7, avec formalisation accrue par guides AMMPS 2026.	Convergence forte de fonction ; différences d'architecture, coordination, outils et transparence documentée. ND si équivalence non démontrée.

L'UE et le Maroc poursuivent la même finalité fondamentale : ne permettre la commercialisation qu'après une évaluation réglementaire de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité. La différence principale réside dans l'architecture. L'UE combine plusieurs voies pour articuler plusieurs États et dispose, pour la centralisée, d'un calendrier scientifique public, de clock-stops, d'une voie accélérée et d'une séparation entre avis CHMP et décision de la Commission. Le Maroc fonctionne dans un cadre national ; l'article 7 modifié répond à une classification différente et les lignes directrices AMMPS 2026 renforcent la formalisation des exigences de preuve.

4. Autorisations avec données incomplètes et accès précoce

4.1. AMM conditionnelle UE : ce qu'elle permet et ce qu'elle n'est pas

L'AMM conditionnelle autorise un médicament avant que toutes les données normalement attendues ne soient disponibles. Ce mécanisme n'est possible que si plusieurs conditions sont réunies : rapport bénéfice/risque positif, possibilité de fournir les données complètes ultérieurement, besoin médical non satisfait et bénéfice de disponibilité immédiate supérieur au risque lié à l'incomplétude. L'autorisation est assortie d'obligations spécifiques juridiquement contraignantes. [5,6;25]

Elle est valable un an et renouvelable. Le titulaire doit exécuter les obligations spécifiques dans les délais prévus. Lorsque les données complètes confirment le profil du médicament et que les obligations sont satisfaites, l'autorisation peut être convertie en AMM standard.

4.2. Circonstances exceptionnelles : pourquoi ce n'est pas la même chose

Dans les circonstances exceptionnelles, l'impossibilité d'obtenir des données complètes est structurelle : maladie extrêmement rare, état des connaissances scientifiques ou impossibilité éthique de collecter certaines données. Le système n'attend donc pas nécessairement qu'un dossier complet devienne disponible. L'autorisation reste soumise à des obligations spécifiques et à une réévaluation annuelle. [5,6]

La différence essentielle est temporelle : dans l'AMM conditionnelle, les données manquantes sont censées pouvoir être produites ; dans les circonstances exceptionnelles, leur production complète est considérée comme non réalisable. [5,6]

4.3. Accéléré, PRIME, compassionnel : quatre outils, quatre fonctions

Une évaluation accélérée réduit le temps d'examen. PRIME soutient le développement. Une AMM conditionnelle accepte temporairement un niveau de complétude différent sous conditions. L'usage compassionnel organise l'accès à un médicament non autorisé pour certains patients ou groupes selon le cadre applicable. Ces mécanismes peuvent se croiser mais ne sont pas interchangeables. [9;5,6;6;39,40]

4.4. Maroc : article 8 bis expliqué condition par condition

L'article 8 bis marocain prévoit une AMM conditionnelle malgré l'incomplétude de certaines données complémentaires d'efficacité et de sécurité. Cinq conditions sont cumulatives : bénéfice-risque favorable ; besoin médical non satisfait ; maladie grave, invalidante ou menaçant le pronostic vital ; bénéfice de santé publique de la disponibilité immédiate supérieur au risque lié aux données incomplètes ; engagement de l'établissement à produire les données complémentaires dans le délai fixé par l'AMMPS. [28,29;5,6;29;25]

Le même article crée une autorisation exceptionnelle d'utilisation d'urgence en cas de situation de santé publique, épidémie grave, extrême urgence ou état d'urgence sanitaire déclaré. Le texte renvoie aux conditions 1, 2, 4 et 5, mais pas à la condition 3. L'urgence marocaine ne doit donc pas être décrite comme une simple AMM conditionnelle raccourcie. [5,6]

La possibilité de conversion vers une AMM ordinaire lorsque les exigences correspondantes sont remplies rapproche fonctionnellement le régime conditionnel marocain de la logique européenne, mais les durées, modalités de renouvellement et obligations détaillées doivent être appréciées dans leurs textes propres. [5,6,28,29]



Figure 34 Régimes d'autorisation et d'accès précoce : Union européenne

La figure corrige la confusion entre plusieurs instruments qui n'interviennent pas au même stade du cycle de vie. Dans l'UE, PRIME relève du soutien au développement, l'évaluation accélérée réduit le temps d'évaluation sans abaisser les exigences de preuve, l'AMM conditionnelle accepte temporairement des données complémentaires incomplètes sous obligations, les circonstances exceptionnelles répondent à l'impossibilité de constituer un dossier complet, et l'usage compassionnel relève de l'accès avant AMM. Le Maroc dispose, via l'article 8 bis, d'une AMM conditionnelle et d'une autorisation exceptionnelle d'utilisation d'urgence ; la comparaison correcte est donc fonctionnelle et non une équivalence terme à terme.

5. Génériques, biosimilaires, Bolar et protections réglementaires

5.1. Distinguer brevet et protection réglementaire

Le brevet protège une invention selon le droit de la propriété intellectuelle. La protection des données et la protection du marché sont des mécanismes réglementaires distincts. Dans le système actuel dit 8 + 2 + 1, le générique/biosimilaire ne peut pas s'appuyer réglementairement sur le dossier du produit de référence avant huit ans ; la mise sur le marché est normalement bloquée jusqu'à dix ans ; une année supplémentaire peut être obtenue dans certaines conditions pour une nouvelle indication apportant un bénéfice clinique significatif. [5;5,31;1,4,5]

5.2. Biosimilaire : similarité, pas identité

Un biosimilaire n'est pas évalué comme un générique chimique simple. Le développement repose sur un exercice de comparabilité progressif démontrant une similarité élevée avec le produit de référence en qualité, activité biologique, sécurité et efficacité, sans différence cliniquement significative. L'objectif n'est pas de répéter tout le développement clinique du produit de référence mais de démontrer la biosimilarité par un ensemble intégré de données. [5,31]

5.3. Bolar : préparer l'entrée avant expiration des droits

L'exemption Bolar permet d'effectuer certaines études, essais et démarches nécessaires à l'autorisation d'un générique ou biosimilaire avant l'expiration des droits concernés, afin que l'entrée puisse intervenir rapidement ensuite. Le nouveau paquet clarifie et élargit ce champ, notamment aux démarches liées aux appels d'offres. L'exemption ne signifie pas que le générique peut être commercialisé avant expiration ; elle évite que les démarches réglementaires ne créent un retard supplémentaire après expiration. [1-4;5,31;1,4,5;25]

5.4. Nouveau système d'incitations

La position du Conseil du 28 septembre 2026 conserve huit ans de protection des données et prévoit une protection de marché de base d'un an, avec possibilités d'extension selon des critères réglementaires. Le plafond combiné est de onze ans, ou douze lorsqu'un voucher transférable d'exclusivité est utilisé. Cette architecture finale est différente de la proposition Commission 2023, qui avait envisagé une protection de données de base plus courte assortie d'extensions. [1-4;1,4,5;1,3]

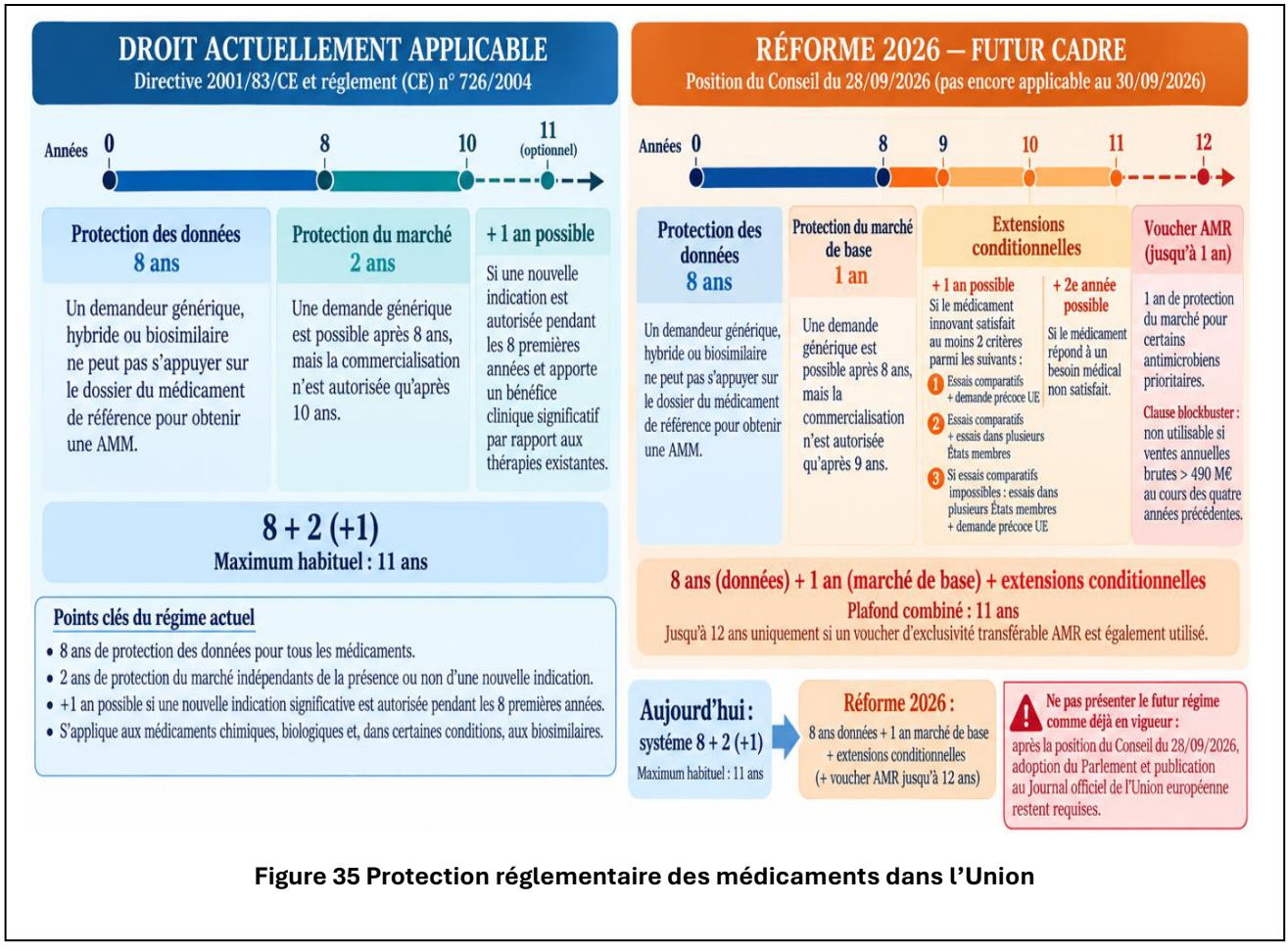


Figure 35 Protection réglementaire des médicaments dans l'Union

5.5. Maroc

Les lignes directrices CTD AMMPS 2026 traitent les exigences pour génériques et biosimilaires, ce qui permet une comparaison scientifique des dossiers. En revanche, la loi 27-26 n'instaure pas un système d'incitations et d'exclusivités identique au nouveau modèle européen. Le benchmark doit donc séparer deux dimensions : convergence des exigences d'évaluation et différence des mécanismes d'incitation. [28,29 ;31 ;5,31]

6. Orphelins, pédiatrie et thérapies innovantes

6.1. Médicaments orphelins

Le système européen crée une désignation orpheline avant l'AMM pour les produits répondant aux critères de rareté et de bénéfice significatif/absence de méthode satisfaisante selon le cadre. La désignation ouvre l'accès à des incitations et, après AMM, à une exclusivité de marché spécifique. Le nouveau cadre prévoit neuf ans d'exclusivité pour les orphelins ordinaires et jusqu'à onze ans pour certains orphelins breakthrough répondant aux critères définis. [41]

6.2. Pédiatrie et PIP

Le PIP est un programme de développement pédiatrique qui organise les études nécessaires chez l'enfant. Il peut prévoir des reports lorsque les études pédiatriques doivent être réalisées après les données adultes, ou des dérogations lorsque le développement n'est pas pertinent. La réforme cherche à rendre les plans plus adaptatifs, notamment lorsque le mécanisme du produit ou les indications futures ne sont pas suffisamment connus au début du développement. [42;25]

6.3. ATMP

Les thérapies géniques, cellulaires somatiques et produits issus de l'ingénierie tissulaire relèvent du cadre ATMP. Elles sont centralisées et nécessitent une expertise spécialisée en raison de leurs caractéristiques de fabrication, de qualité, de persistance et de risques. La réforme modifie l'organisation institutionnelle de cette expertise sans supprimer la nécessité d'une évaluation spécialisée. [9;43;25]

6.4. Maroc

Le corpus 17-04/27-26 ne met pas en évidence un paquet directement équivalent combinant désignation orpheline, exclusivité dédiée, PIP obligatoire et cadre ATMP de même granularité. [41;42;43]

Il s'agit d'une différence de spécialisation réglementaire documentée, et non d'une conclusion sur la disponibilité clinique de ces traitements. [25]

7. Pharmacovigilance : de la déclaration à la décision réglementaire

7.1. ICSR : la donnée individuelle de sécurité

L'ICSR est le rapport structuré d'un cas individuel de sécurité. Les cas peuvent provenir de professionnels de santé, patients, études, littérature ou autres sources prévues. Les titulaires et autorités doivent collecter, valider et transmettre les cas selon les règles applicables. EudraVigilance sert de système européen d'échange et d'analyse de ces données. [11]

7.2. Signal : une hypothèse à investiguer, pas une causalité prouvée

Un signal de sécurité est une information suggérant une association nouvelle potentiellement causale, ou un nouvel aspect d'une association connue, qui justifie une investigation. Un signal peut provenir des déclarations spontanées, études cliniques, littérature, données observationnelles ou autres sources. La détection n'est que le début : validation, confirmation, analyse, priorisation, évaluation et recommandation sont nécessaires avant une mesure réglementaire. [12,13;25]

7.3. PRAC : quatre instruments qu'il ne faut pas mélanger

Le PRAC examine notamment les signaux, les Risk Management Plans, les Periodic Safety Update Reports et les Post-Authorisation Safety Studies. Un RMP décrit les risques importants, les informations manquantes et les activités de pharmacovigilance/minimisation. Un PSUR synthétise périodiquement l'expérience mondiale et réévalue le rapport bénéfice-risque. Une PASS est une étude post-autorisation visant une question de sécurité. Un signal est une information nouvelle nécessitant évaluation. Ces instruments ont donc des fonctions différentes. [12,13;4,40;39,40;25]

7.4. QPPV et PSMF

Le titulaire doit disposer en permanence d'une Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance établie dans l'Union. Le PSMF décrit le système de pharmacovigilance du titulaire : organisation, responsabilités, processus, systèmes, données et contrôle qualité. Sa localisation et son identifiant sont intégrés dans les systèmes réglementaires. Le PSMF n'est pas un rapport de sécurité sur un médicament particulier ; c'est le dossier maître du système de pharmacovigilance. [32,39,40;25;5,37]

7.5. Du signal à l'action

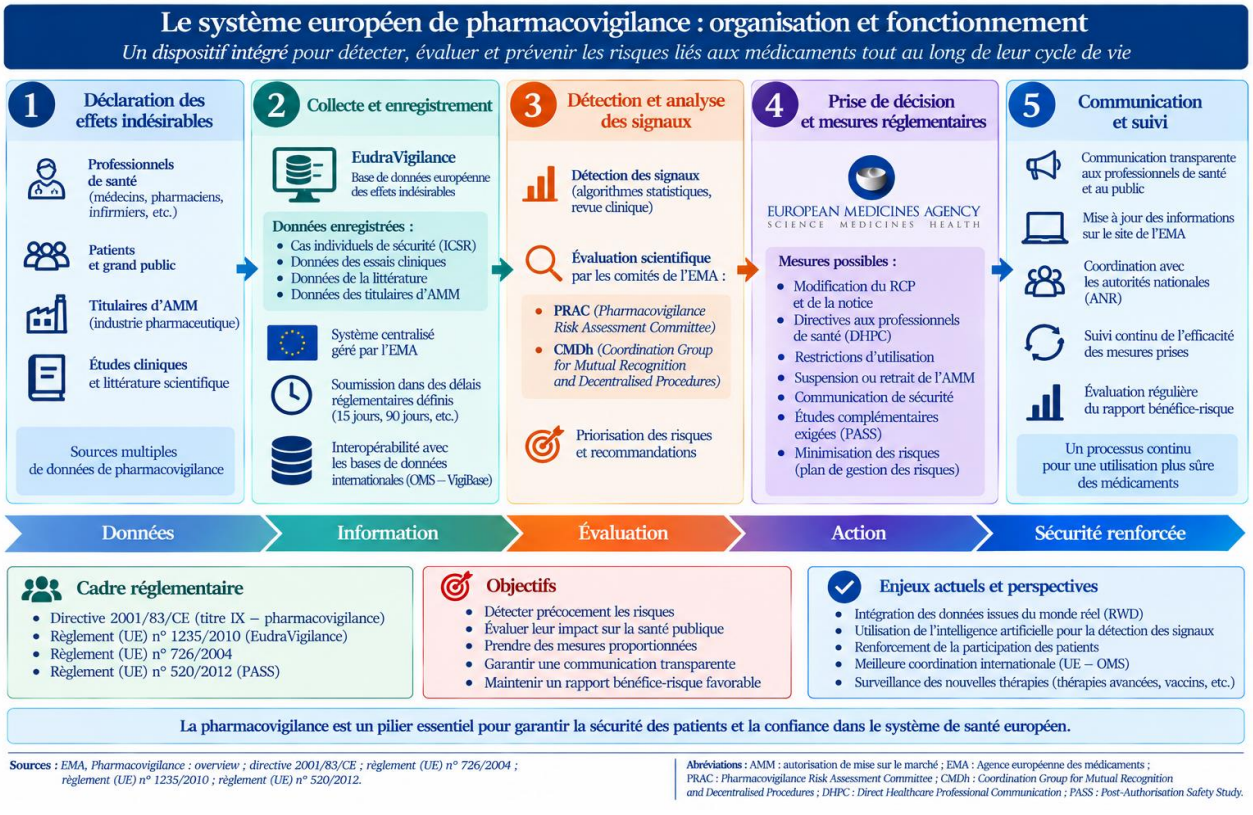


Figure 36 Le système européen de pharmacovigilance : organisation et et fonctionnement

La figure visualise la pharmacovigilance comme une chaîne continue allant de la déclaration et de la collecte des données à la détection des signaux, leur évaluation scientifique et la décision réglementaire. Elle permet de relier les acteurs et outils européens - notamment EudraVigilance, PRAC, QPPV/PSMF, RMP, PSUR/PSUSA et PASS - à leur fonction réelle. Placée avant la partie marocaine, elle fournit le référentiel fonctionnel nécessaire pour interpréter ensuite les convergences documentées autour du responsable de pharmacovigilance et du PSMF au Maroc.

Après évaluation, plusieurs issues sont possibles : aucune action supplémentaire ; surveillance renforcée ; modification du RCP/notice ; communication de sécurité ; mesures additionnelles de minimisation ; PASS ; restriction d'indication ; suspension ou retrait. La pharmacovigilance est donc un processus de gouvernance du rapport bénéfice-risque tout au long du cycle de vie. [39,40]

7.6. Maroc : réforme + mise en œuvre 2026

L'article 6 institue le système national et définit la pharmacovigilance. L'article 120 impose un pharmacien ou médecin exclusivement chargé de la pharmacovigilance sous responsabilité du pharmacien responsable. Le 25 septembre 2026, l'AMMPS a rendu cette exigence beaucoup plus opérationnelle : désignation au plus tard le 16 octobre 2026, résidence au Maroc, plein temps, disponibilité 24 h/24 et 7 j/7, compétences en pharmacovigilance, épidémiologie et biostatistique. [28,29;32]

La même note précise que les compétences feront l'objet d'un examen dans le cadre de l'évaluation du PSMF. Cette information est majeure pour le benchmark : le Maroc documente désormais explicitement un PSMF dans la mise en œuvre de l'article 120. Il serait donc dépassé d'écrire que le PSMF est uniquement un élément européen. [32,39,40]

En revanche, il ne faut pas aller trop loin : la source ne démontre pas que le PSMF marocain est juridiquement et techniquement identique au PSMF européen, ni qu'un équivalent complet d'EudraVigilance existe. La conclusion correcte est une convergence renforcée de l'organisation interne, avec différence/ND concernant l'infrastructure de données et certaines procédures harmonisées. [11;32,39,40]

8. Inspection pharmaceutique, GMP/GDP et EudraGMDP

8.1. Ce qu'une inspection réglementaire vérifie

L'inspection ne consiste pas uniquement à visiter un établissement. Elle vérifie la conformité du système qualité, des locaux, équipements, personnel, documentation, validation, fabrication, contrôle, stockage, distribution et autres obligations applicables. Les inspections peuvent être planifiées ou inopinées et leur fréquence peut être fondée sur le risque selon le type d'opérateur.

8.2. Article 111 et inspections dans/pays tiers

La directive 2001/83/CE prévoit des inspections répétées des fabricants et grossistes et permet des inspections inopinées. Les autorités peuvent prélever des échantillons et demander des analyses à un laboratoire officiel ou désigné. Les fabricants de pays tiers peuvent également être inspectés lorsqu'ils fournissent le marché européen. La coordination entre autorités évite les duplications et permet de partager les résultats. [5,6]

8.3. EudraGMDP : transformer le résultat d'inspection en information partagée

EudraGMDP contient les Manufacturing and Importation Authorisations, certificats GMP, rapports de nonconformité GMP, Wholesale Distribution Authorisations, certificats GDP et non-conformités GDP, ainsi que certaines données sur les substances actives. Les autorités nationales alimentent la base ; l'EMA l'héberge. Une inspection locale produit ainsi une information réglementaire consultable à l'échelle du réseau. [14,37,38;37;38;5,37]

La présence d'un rapport de non-conformité dans EudraGMDP a une portée différente d'une simple note interne : les autres autorités peuvent en tenir compte dans leurs décisions. C'est un exemple d'intégration réglementaire par la donnée. [14,37,38]

8.4. Maroc : articles 130-131

L'article 130 rattache l'inspection de la pharmacie à l'AMMPS et couvre les officines, stocks de médicaments des cliniques, établissements pharmaceutiques et dépôts. Il mentionne les bonnes pratiques de fabrication, distribution, pharmacovigilance, officine et gestion des stocks des cliniques. L'article 131 précise le rôle des pharmaciens inspecteurs assermentés commissionnés par le directeur de l'Agence. [28,29;29]

La convergence de fonction est claire : inspection et contrôle des bonnes pratiques. Le principal écart démontrable dans le corpus porte sur l'outil partagé : aucune base publique marocaine de même périmètre qu'EudraGMDP n'est établie par les sources étudiées. Cela ne permet pas de conclure à une inspection moins efficace ; seulement à une architecture documentaire différente. [14,37,38]



Figure 37 Inspection pharmaceutique et bonnes pratiques : comparaison

Cette figure compare la fonction d'inspection sur cinq dimensions : base juridique, acteurs, champ de contrôle, référentiels de bonnes pratiques et circulation de l'information. Elle montre une convergence de fonction - vérifier la conformité des activités pharmaceutiques - mais une différence d'architecture : le système européen s'appuie sur un réseau d'autorités et des outils partagés tels qu'EudraGMDP, alors que le cadre marocain confie la mission à l'AMMPS selon les articles 130-131 et les bonnes pratiques applicables. L'interprétation doit rester institutionnelle et procédurale, sans transformer cette différence en jugement de performance.

9. Défauts qualité, rappels, Rapid Alert et falsification

9.1. Défaut qualité ≠ signal de pharmacovigilance

Un défaut qualité concerne par exemple une contamination, erreur de teneur, problème de stérilité, conditionnement ou non-conformité de fabrication. Un signal de pharmacovigilance

concerne une information de sécurité clinique. Les deux peuvent se rejoindre si un défaut provoque des effets indésirables, mais les chaînes réglementaires sont distinctes. [15,16]

9.2. Classification européenne des rappels

Les lignes européennes de gestion des défauts utilisent une classification fondée sur l'urgence et le risque. Une classe I concerne une situation potentiellement vitale et peut nécessiter un rappel jusqu'au patient. Une classe II correspond généralement à un risque modéré pouvant provoquer maladie ou mauvais traitement, avec rappel typiquement jusqu'au niveau pharmacie/détail. Une classe III concerne un problème ne présentant généralement pas de danger significatif ; le rappel peut être motivé par la nonconformité et reste souvent au niveau grossiste. Les classes III ne sont normalement pas diffusées par le Rapid Alert System. [15,16;16]

Le Rapid Alert System sert à informer rapidement les autorités concernées lorsqu'une action urgente est nécessaire. Pour une classe I, l'alerte est largement diffusée ; pour une classe II, elle vise au minimum les pays où le lot a été distribué, avec extension si la distribution est incertaine. [15,16;16]

9.3. Falsification : sérialisation pack par pack

Le règlement délégué 2016/161 met en œuvre deux dispositifs de sécurité : identifiant unique et dispositif antieffraction. L'identifiant comprend notamment un code produit et un numéro de série unique. Le système fonctionne selon une vérification end-to-end : les identifiants légitimes sont stockés dans des répertoires, puis l'authenticité du pack est vérifiée et l'identifiant est désactivé lors de la délivrance ou dans les autres situations prévues. [17;25]

Le système de répertoires comprend un hub central et des répertoires nationaux ou supranationaux. Les pharmaciens et autres personnes autorisées à délivrer se connectent au répertoire desservant leur territoire. Si le système indique une suspicion de non-authenticité, le produit ne doit pas être délivré et les autorités doivent être informées. La lutte contre la falsification devient ainsi un contrôle numérique individualisé des boîtes.

9.4. Maroc : article 131 bis

L'article 131 bis confie au contrôle du marché quatre fonctions : qualité post-commercialisation, publicité, alertes/retraits/rappels, prévention et détection des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure. Cette disposition rapproche fortement le périmètre fonctionnel marocain du cycle post-AMM européen. [29;25;5,29]

Cependant, l'article ne suffit pas à démontrer une sérialisation pack par pack ou un système national de répertoires équivalent au règlement 2016/161. Le benchmark doit donc conclure : convergence de mission, différence/ND concernant le dispositif technique de vérification. [17;25]

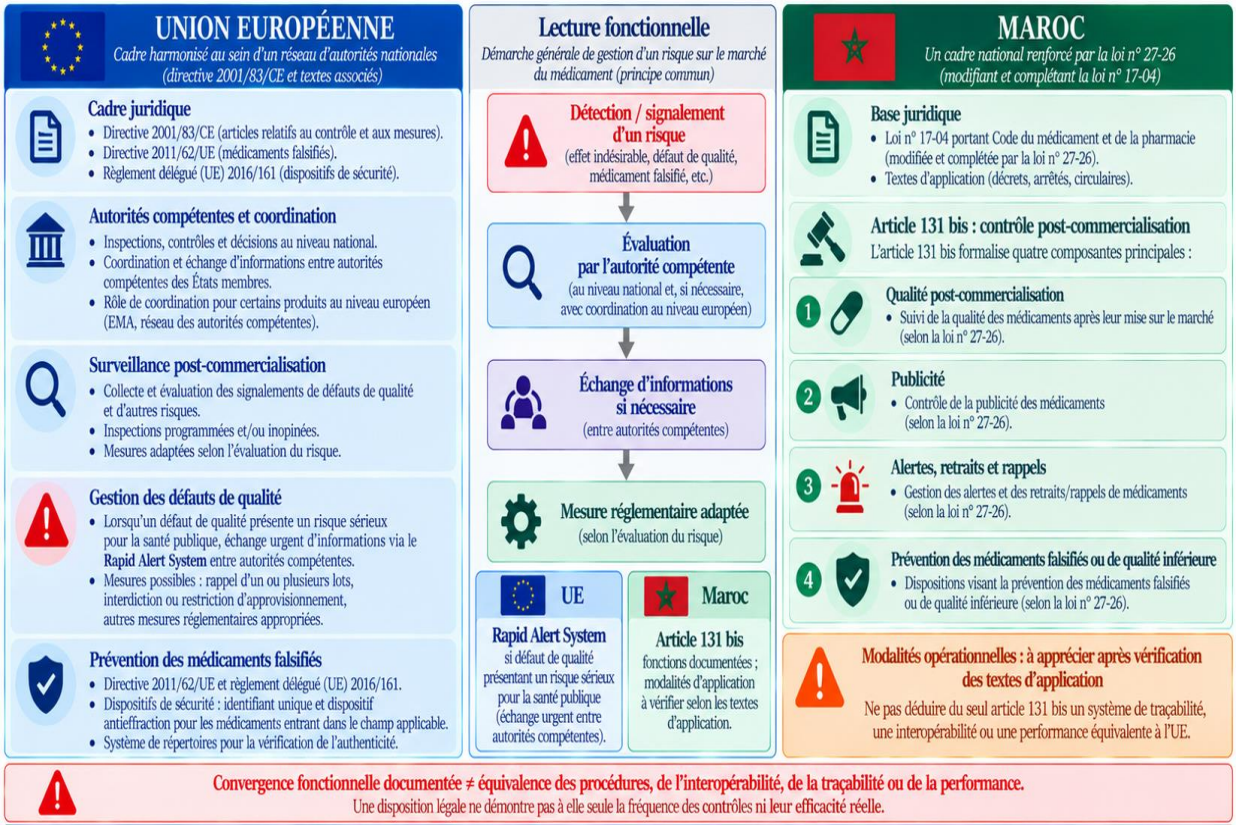


Figure 38 Contrôle post-commercialisation, alertes, retraits/rappels et médicaments falsifiés : Union européenne – Maroc

La figure montre que le contrôle du marché ne se limite pas à la pharmacovigilance. Il comprend la détection des défauts qualité, l'évaluation du risque, les alertes, retraits et rappels ainsi que la prévention et la détection des médicaments falsifiés. Le Maroc documente désormais explicitement ces missions dans l'article 131 bis ; l'UE dispose de mécanismes coordonnés et d'outils spécifiques. La convergence porte donc sur la finalité de protection du marché, tandis que les procédures, réseaux d'alerte et infrastructures techniques restent à distinguer.

10. Libération officielle des lots : OCABR et réforme marocaine

10.1. UE : pourquoi un second contrôle officiel existe

Pour certains médicaments biologiques, notamment des vaccins et produits dérivés du sang/plasma selon le champ applicable, l'autorisation du produit et la libération du fabricant ne suffisent pas toujours. Une autorité officielle de contrôle réalise un contrôle indépendant du lot avant sa mise sur le marché. Cette logique répond à la variabilité biologique et au niveau de risque de ces produits. [25]

Le réseau OCABR fonctionne avec les OMCL et des guidelines produit-spécifiques coordonnées par l'EDQM. Le laboratoire officiel examine le protocole de lot et réalise les essais requis selon la guideline. Lorsqu'un lot satisfait aux exigences, un certificat OCABR est émis. La reconnaissance des certificats dans le réseau évite que chaque État répète les mêmes essais. [18]

10.2. Maroc : procédure 60 / 30 / 7 jours

La réforme de 2024 a introduit les articles 17-1 à 17-4 et le décret n° 2-24-729. Tout lot de vaccin ou sérum à usage humain, fabriqué localement ou importé, doit disposer du certificat officiel requis avant mise sur le marché, sous réserve des exceptions prévues. Le certificat ne transfère pas la responsabilité du fabricant ou du pharmacien responsable vers l'autorité.



Figure 39 Libération officielle des lots de vaccins et sérums : comparaison Union européenne - Maroc

Cette figure met en regard l'OCABR/OMCL européen et la procédure marocaine de libération officielle des lots de vaccins et sérums. Pour le Maroc, elle doit être interprétée avec les délais réglementaires exacts : 60 jours pour le délai ordinaire, 30 jours pour certaines situations prévues, 7 jours pour les lots importés accompagnés d'un certificat d'une autorité reconnue, et

contrôles analytiques réalisés chaque fois que nécessaire. La figure montre une convergence fonctionnelle forte - contrôle officiel avant mise sur le marché - sans assimiler l'organisation marocaine au réseau européen OCABR

Le dossier comprend demande, protocole de fabrication et contrôle, résultats des essais, données de transport/conservation, références d'AMM, échantillons et réactifs selon le cas. Pour les importations, des éléments supplémentaires liés au lot et à sa libération dans le pays d'origine sont requis. [22]

Le délai ordinaire maximal est de 60 jours. Il est de 30 jours pour les lots destinés à une campagne nationale de vaccination ou au programme national d'immunisation. Il peut être de 7 jours pour certains lots importés bénéficiant d'un certificat délivré par une autorité reconnue. Une demande d'informations complémentaires suspend le délai ; l'établissement dispose de 30 jours maximum pour répondre. [30,33;25]

Les contrôles analytiques sont effectués chaque fois que nécessaire. Cette formule doit être conservée exactement : elle exclut l'affirmation erronée selon laquelle tous les lots sont systématiquement retestés intégralement. L'AMMPS a encore actualisé le 22 septembre 2026 la check-list des demandes de libération de lots, ce qui montre que le mécanisme est entré dans une phase d'opérationnalisation documentaire. [28,29;33]

11. Pénuries et sécurité d'approvisionnement

11.1. Du signal de pénurie à la coordination européenne

Une pénurie est un problème de disponibilité, distinct d'un défaut qualité même si un défaut peut en être la cause. La gestion nécessite des informations sur stocks, demande, production, alternatives et durée prévue. Le règlement 2022/123 a renforcé le rôle de l'EMA et créé/renforcé la gouvernance du MSSG pour les situations critiques. [15,16;19]

11.2. ESMP : la donnée comme outil de gestion

L'ESMP permet aux titulaires et autorités nationales de transmettre des informations harmonisées sur disponibilité, offre et demande. Son utilisation est obligatoire depuis le 2 février 2025 pour les titulaires et autorités dans le champ prévu. L'intérêt n'est pas seulement administratif : une plateforme commune rend possible l'agrégation de données et une réponse coordonnée. [19]

11.3. Liste de médicaments critiques

La liste de l'Union identifie les médicaments dont une interruption d'approvisionnement pourrait causer un préjudice important aux patients et aux systèmes de santé. Cette liste sert à prioriser l'analyse des vulnérabilités et les mesures de prévention. « Critique » ne signifie donc pas

simplement « souvent en rupture » ; il s'agit d'une qualification de l'importance clinique et systémique. [5,6]

11.4. Nouveau paquet : prévention en amont

Le nouveau cadre renforce les obligations de prévention et de notification. Le titulaire doit anticiper les perturbations et notifier suffisamment tôt ; le cadre adopté prévoit notamment une notification au moins six mois à l'avance dans les situations couvertes. Les plans de prévention deviennent un outil structuré pour les médicaments concernés.

11.5. Critical Medicines Act : autre texte, autre fonction

Le Critical Medicines Act n'est pas le nouveau Code pharmaceutique. Il complète la politique de sécurité d'approvisionnement par des instruments industriels et d'achat : diversification des chaînes, capacités de production, projets stratégiques, critères de résilience dans les marchés publics et achats collaboratifs. Un accord provisoire Conseil-Parlement a été atteint le 12 mai 2026. [21]

11.6. Maroc

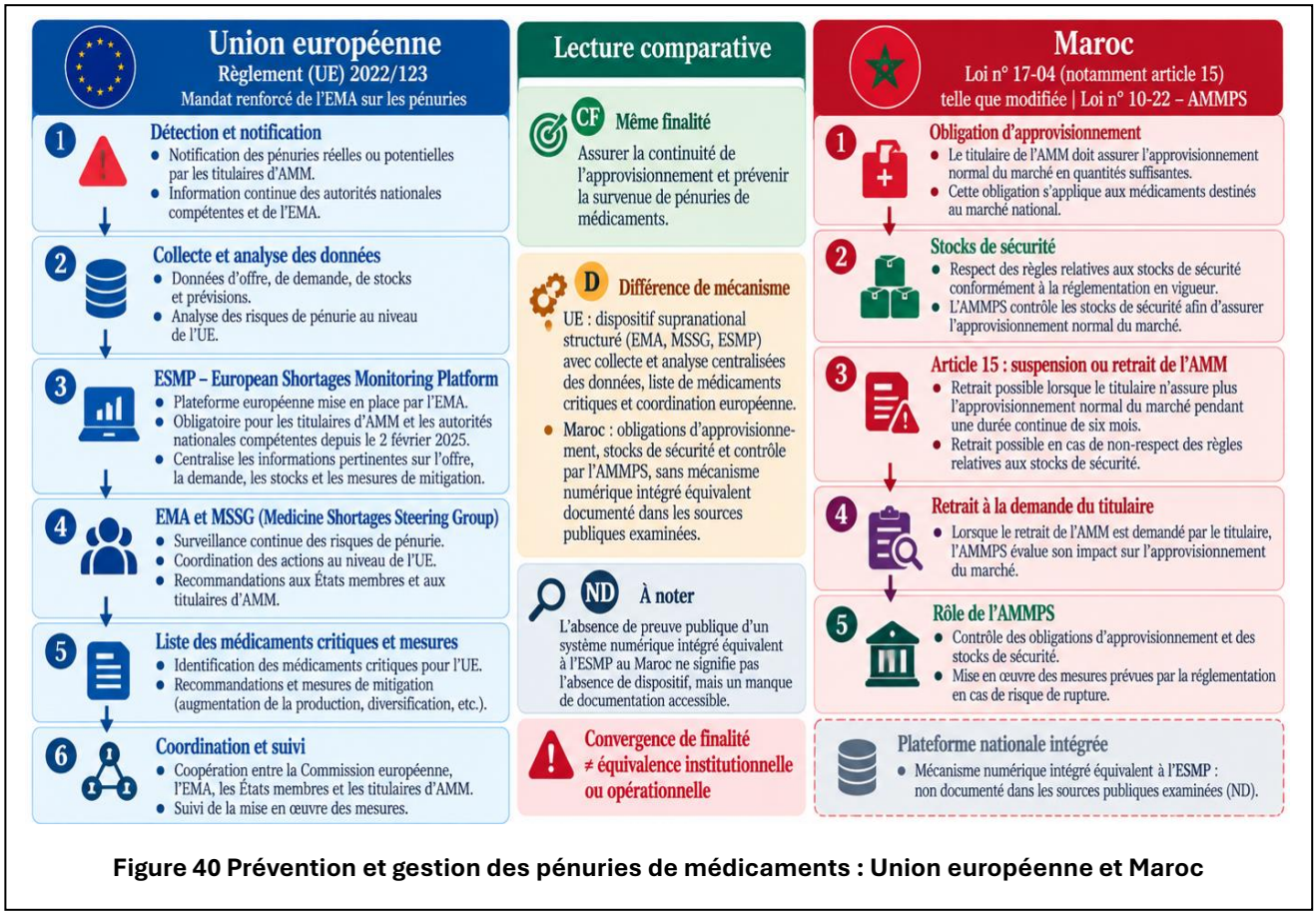


Figure 40 Prévention et gestion des pénuries de médicaments : Union européenne et Maroc

La figure compare deux systèmes visant la continuité d'approvisionnement mais utilisant des mécanismes différents. Dans l'UE, le règlement (UE) 2022/123 organise une coordination supranationale autour de l'EMA, du MSSG et de l'ESMP ; l'ESMP est obligatoire dans son champ depuis le 2 février 2025. Au Maroc, la comparaison repose sur les obligations d'approvisionnement, les stocks de sécurité et le contrôle par l'AMMPS. En l'absence de preuve publique d'un système numérique national intégré équivalent à l'ESMP, la conclusion doit rester « convergence de finalité / différence de mécanisme ou ND », et non « absence ».

Le Code marocain contient des obligations relatives à l'approvisionnement et aux stocks de sécurité, notamment autour de l'article 15 et des textes associés. Ces obligations permettent une comparaison sur la finalité de continuité d'approvisionnement.

En revanche, les sources retenues ne démontrent pas une plateforme nationale équivalente à l'ESMP, un organe analogue au MSSG ou une liste publique structurée exactement comme la liste de l'Union. La conclusion est donc une convergence d'objectif mais une différence documentée dans les outils supranationaux de coordination.

12. Données réglementaires et transformation numérique

12.1. ISO IDMP et SPOR : donner un langage commun aux données

Les standards ISO IDMP visent à identifier de manière structurée les médicaments et leurs composants. L'EMA les met en œuvre par les domaines SPOR : Substance, Product, Organisation et Referential. OMS identifie organisations et lieux ; RMS harmonise les référentiels ; PMS fournit des données structurées sur les médicaments autorisés ; SMS couvre les substances. [22;23;25]

L'intérêt réglementaire est l'interopérabilité : une organisation, une substance ou un produit ne doit pas être décrit différemment dans chaque procédure. Les mêmes identifiants et référentiels peuvent être réutilisés dans les systèmes. [25]

12.2. ePI : information produit lisible par les systèmes

L'ePI transpose le contenu réglementaire du RCP, de la notice et de l'étiquetage dans un format électronique structuré. Le 17 septembre 2026, la version 1.0.0 du guide d'implémentation européen fondé sur HL7 FHIR a été publiée. FHIR permet aux informations de devenir interrogeables et réutilisables par des systèmes numériques plutôt que de rester uniquement dans des PDF. [22]

12.3. DARWIN EU : RWE produite à la demande du régulateur

DARWIN EU est un réseau fédéré : les données restent chez les partenaires, sont transformées selon un modèle commun et des analyses standardisées sont exécutées localement. Cette

architecture réduit la nécessité de centraliser toutes les données patients dans une base unique. [24]

En 2026, le réseau donne accès à des données concernant environ 250 millions de patients et compte 40 partenaires de données dans 18 pays européens. Les études portent sur utilisation, épidémiologie, sécurité, efficacité et faisabilité. Le rapport 2026 indique qu'environ 30 % des études de la période récente ont directement soutenu une décision réglementaire formelle. [24]

12.4. Maroc : TARKHISS, mais attention au périmètre

L'AMMPS a lancé TARKHISS en mars 2026 comme plateforme de dématérialisation réglementaire. Une note décrit le dépôt électronique et les paiements électroniques pour des procédures couvertes. Toutefois, le communiqué de lancement précise que la première phase concernait les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. [28,29;34,35;25]

Il serait donc excessif d'écrire que TARKHISS est déjà l'équivalent marocain de CTIS, SPOR/PMS ou de l'écosystème européen d'enregistrement des médicaments. Le résultat correct est : transformation numérique nationale démontrée, mais périmètre médicament et interopérabilité comparables à l'UE à documenter séparément. [10;22;23;34,35]

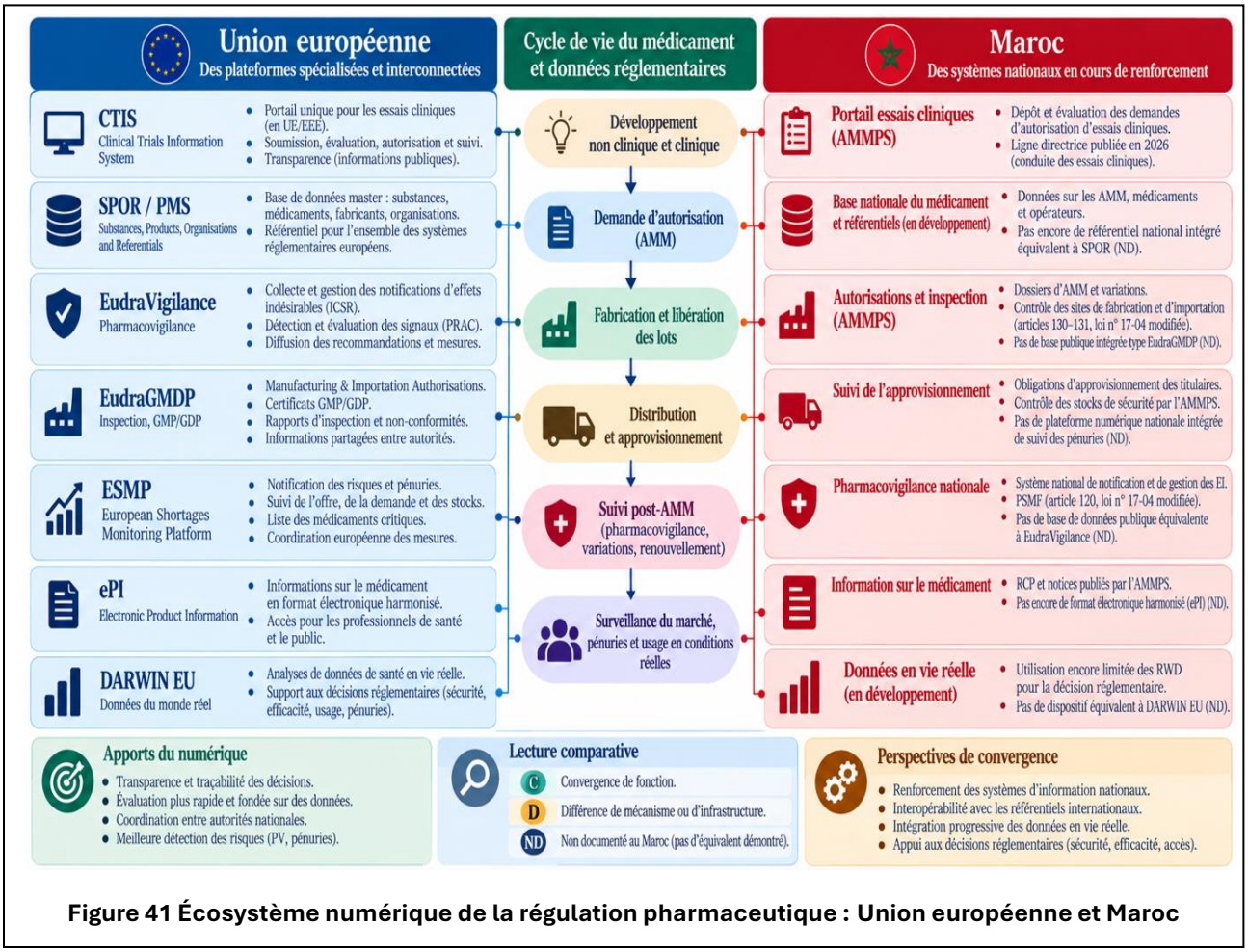


Figure 41 Écosystème numérique de la régulation pharmaceutique : Union européenne et Maroc

La figure compare deux systèmes visant la continuité d'approvisionnement mais utilisant des mécanismes différents. Dans l'UE, le règlement (UE) 2022/123 organise une coordination supranationale autour de l'EMA, du MSSG et de l'ESMP ; l'ESMP est obligatoire dans son champ depuis le 2 février 2025. Au Maroc, la comparaison repose sur les obligations d'approvisionnement, les stocks de sécurité et le contrôle par l'AMMPS. En l'absence de preuve publique d'un système numérique national intégré équivalent à l'ESMP, la conclusion doit rester « convergence de finalité / différence de mécanisme ou ND », et non « absence ».

13. IA, méthodes innovantes et regulatory sandbox

L'EMA a adopté en 2024 un reflection paper sur l'utilisation de l'IA tout au long du cycle de vie. En janvier 2026, EMA et FDA ont publié dix principes communs de bonne pratique de l'IA couvrant génération de preuves et suivi depuis la recherche jusqu'à la fabrication et la sécurité. [25]

Le nouveau cadre pharmaceutique introduit les regulatory sandboxes. Une sandbox est un environnement temporaire et contrôlé permettant de développer, valider ou tester un médicament ou une méthodologie innovante sous supervision réglementaire lorsque les règles ordinaires ne permettent pas un développement approprié. Elle n'est pas une zone sans réglementation : la supervision, la protection de la santé publique et les exigences fondamentales restent en place. [26]

Un atelier Commission-EMA tenu le 21 septembre 2026 a déjà travaillé sur l'identification des candidats, le plan de sandbox, la transparence et les modalités d'implémentation. Cela montre que la préparation opérationnelle commence avant même l'applicabilité du nouveau paquet. [1-4;26;7,10,14]

Aucun mécanisme pharmaceutique marocain équivalent n'est établi dans le corpus étudié. Ce domaine constitue donc un exemple de spécialisation émergente du système européen. [25]

14. Environnement et résistance aux antimicrobiens

L'évaluation environnementale examine les risques que l'utilisation et l'élimination d'un médicament peuvent créer pour l'environnement. La réforme renforce cette dimension et relie plus explicitement les mesures de réduction du risque au cycle réglementaire.

Pour les antimicrobiens, la problématique dépasse la toxicité environnementale : les résidus peuvent contribuer à la sélection de résistances. Le nouveau paquet ajoute des mesures de bon usage et un instrument d'incitation : le transferable exclusivity voucher pour certains antimicrobiens prioritaires. [1-4;39,40;1,3]

Le voucher accorde une année supplémentaire de protection du marché à un produit choisi selon les règles. Le compromis adopté contient une clause empêchant l'utilisation du voucher sur un produit dont les ventes annuelles brutes dépassent 490 millions d'euros dans la période de référence. Le mécanisme cherche à stimuler un domaine où l'innovation est économiquement difficile, tout en limitant l'impact budgétaire potentiel. [39,40;1,3]

Le Maroc dispose d'actions de santé publique contre l'antibiorésistance, mais la loi 27-26 n'introduit pas un mécanisme d'exclusivité transférable comparable. Le benchmark doit distinguer politique de santé publique, règles d'AMM et incitations économiques. [28,29]

15. HTA : pourquoi l'AMM ne suffit pas à expliquer l'accès

Une AMM européenne signifie que le rapport bénéfice-risque est jugé favorable pour les indications autorisées. Elle ne détermine pas automatiquement le prix, le remboursement ni l'utilisation financée dans chaque État. Le HTA évalue notamment la valeur clinique relative dans un contexte de décision de santé. [27]

Le règlement HTA est applicable depuis janvier 2025. Les Joint Clinical Assessments couvrent d'abord les nouveaux médicaments anticancéreux et ATMP ; les médicaments orphelins entrent en 2028 et l'ensemble des nouveaux médicaments en 2030. La JCA évite de répéter certaines évaluations cliniques dans chaque État, mais les États conservent leurs décisions de valeur, prix et remboursement selon leurs compétences. [41;43;27]

Dans le benchmark Maroc-UE, l'HTA doit donc être présenté comme une interface avec la régulation pharmaceutique, pas comme une fonction identique à l'AMMPS. [28,29;27]

16. Transparence réglementaire et information publique

L'UE publie les EPAR des médicaments centralisés, les informations produit, de nombreuses recommandations du PRAC, des données d'essais via CTIS, des informations GMP/GDP via EudraGMDP et des informations de pénuries via les systèmes concernés. La transparence est distribuée entre plusieurs infrastructures. [10;7;12,13;14,37,38]

L'AMMPS publie également des lignes directrices, notes d'information, alertes et documents opérationnels. L'intensification de ces publications en 2026 est importante pour la traçabilité réglementaire. Toutefois, il faut comparer document par document : publier une ligne directrice n'est pas équivalent à publier un rapport public d'évaluation d'AMM ou une base de certificats d'inspection. [28,29]

17. Gestion du cycle de vie après l'AMM : variations, extensions, renouvellement et transfert

17.1. Pourquoi l'AMM n'est jamais un dossier figé

Après l'autorisation initiale, presque tout médicament évolue : nouveau site de fabrication, modification d'un procédé, nouvelle méthode analytique, nouvelle taille de lot, changement de conditionnement, nouvelle indication, nouvelle population, modification de posologie, ajout d'une contre-indication ou actualisation de l'information produit. Le système réglementaire doit donc déterminer quelles modifications peuvent être mises en œuvre immédiatement, lesquelles exigent une notification préalable et lesquelles nécessitent une nouvelle évaluation scientifique approfondie. [25]

17.2. Type IA et IA_IN : changements mineurs

Le règlement sur les variations définit les Type IA comme des modifications mineures ayant un impact minimal ou nul sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité. Elles suivent principalement une logique « do and tell » : le titulaire peut mettre en œuvre le changement avant l'approbation formelle, puis le notifier selon les règles applicables. Certaines IA_IN exigent une notification immédiate après mise en œuvre en raison de leur importance administrative ou réglementaire. Depuis le 15 janvier 2026, les nouvelles lignes directrices européennes révisées sur les variations sont applicables. [25;36]

Le cadre 2026 introduit aussi une logique d'annual update pour de nombreuses Type IA : plusieurs modifications mineures mises en œuvre pendant le cycle peuvent être regroupées dans une notification annuelle. L'objectif est de réduire les soumissions répétitives sans diminuer la responsabilité du titulaire quant à la conformité du changement. [25]

17.3. Type IB : « tell, wait and do »

Une Type IB est une modification mineure qui n'entre ni dans Type IA, ni dans Type II, ni dans une extension. Elle doit être notifiée avant sa mise en œuvre. Après validation et démarrage de la procédure, le titulaire attend normalement 30 jours. Si l'autorité ne formule pas d'objection empêchant l'acceptation, le changement peut être mis en œuvre. Le mécanisme est donc intermédiaire entre la notification postérieure de Type IA et l'approbation scientifique préalable d'une Type II. [30,33;25]

17.4. Type II : modification majeure

Une Type II est une modification susceptible d'avoir un impact significatif sur la qualité, la sécurité ou l'efficacité. Elle exige une évaluation avant mise en œuvre. Une nouvelle indication thérapeutique, des changements majeurs de fabrication ou d'autres modifications affectant

substantiellement le profil du médicament peuvent relever de cette catégorie. La durée d'évaluation dépend de la nature du changement et peut être adaptée lorsque des questions supplémentaires sont nécessaires.

17.5. Extension d'AMM

Certaines modifications sont si fondamentales qu'elles ne peuvent pas être traitées comme une simple Type II. L'annexe I du règlement sur les variations les qualifie d'extensions de l'AMM. Il peut s'agir, selon le cas, de changements fondamentaux de substance active, de forme pharmaceutique, de voie d'administration ou d'autres transformations définies par le cadre. L'extension est rattachée à l'AMM globale mais suit une procédure plus proche d'une nouvelle autorisation. [25;36]

17.6. Grouping, super-grouping et worksharing

Le système européen permet de regrouper plusieurs variations liées afin d'éviter des évaluations fragmentées. Le grouping rassemble plusieurs changements concernant une même AMM. Le supergrouping peut regrouper certaines Type IA identiques touchant plusieurs AMM d'un même titulaire. Le worksharing permet qu'une même modification concernant plusieurs AMM soit évaluée une seule fois par une autorité de référence, puis appliquée aux autorisations concernées. Cette logique est particulièrement importante pour les portefeuilles multinationaux.[25;36]

17.7. PACMP : planifier à l'avance un changement de fabrication

Le Post-Approval Change Management Protocol permet au titulaire et au régulateur de convenir à l'avance de la stratégie, des études et des critères qui permettront d'évaluer un futur changement. Une fois le protocole approuvé et exécuté conformément aux engagements, le changement peut suivre une voie réglementaire plus prévisible. La révision européenne du guide PACMP est juridiquement effective depuis le 15 janvier 2026. [5,6]

17.8. Renouvellement, sunset clause et transfert

Dans le système actuel, une AMM doit normalement être renouvelée cinq ans après son octroi. La réévaluation porte sur le rapport bénéfice-risque actualisé. Après renouvellement, la validité devient généralement illimitée. La sunset clause répond à une autre logique : l'AMM peut perdre sa validité si le médicament n'est pas effectivement mis sur le marché dans les trois années suivant l'autorisation ou s'il disparaît du marché pendant trois années consécutives, sous réserve des exemptions prévues pour des raisons de santé publique. [5]

Le transfert d'AMM change le titulaire juridique. Il ne s'agit pas d'un simple changement de nom lorsque la personne morale reste identique. Le nouveau titulaire reprend également les

obligations post-AMM restant à exécuter. Depuis 2025, plusieurs procédures post-AMM, dont transferts et renouvellements, sont gérées dans IRIS.

17.9. Benchmark Maroc

Le cadre marocain prévoit également des modifications, renouvellements et actes de gestion du cycle de vie de l'AMM selon les textes applicables. Toutefois, la loi 27-26 ne constitue pas à elle seule un équivalent détaillé du règlement européen 1234/2008 et de ses lignes directrices 2026. Pour le benchmark, la différence principale est donc la granularité publique du système européen de classification des changements et de mutualisation des évaluations.

Tableau 3 Comparaison des modifications post-AMM et des règles de maintien de l'autorisation de mise sur le marché entre l'Union européenne et le Maroc.

Élément	Union européenne	Maroc	Lecture comparative
Modification mineure	IA : do-and-tell ; IB : tell-wait-and-do, 30 jours.	Procédures nationales selon cadre applicable.	UE : classification publique très granulaire.
Modification majeure	Type II, approbation préalable.	Modification majeure selon dossier national.	Convergence de principe ; nomenclature différente.
Mutualisation	Grouping, super-grouping, worksharing.	Pas d'équivalent supranational attendu.	Spécificité du réseau UE.
Sunset clause	3 ans sans commercialisation / 3 ans d'absence.	Régime marocain propre à vérifier selon texte consolidé.	Ne pas assimiler sans base juridique identique.

18. Referrals : comment l'Union résout un problème réglementaire commun

Les procédures de referral constituent une fonction essentielle du réseau européen. Elles permettent de transformer un problème touchant plusieurs autorisations ou plusieurs États en une évaluation scientifique commune. Elles sont particulièrement importantes lorsque les médicaments concernés ont été autorisés nationalement et qu'une action harmonisée devient nécessaire. [5,6]

18.1. Article 31 : intérêt de l'Union

Une procédure de l'article 31 peut être engagée lorsqu'une question concernant un médicament présente un intérêt pour l'Union. Dans le domaine de la pharmacovigilance, elle est utilisée lorsque les préoccupations de sécurité nécessitent une évaluation européenne mais que les critères d'urgence de l'article 107i ne sont pas remplis. L'évaluation peut concerner un médicament, une substance active ou une classe. [5]

18.2. Article 107i : procédure urgente de l'Union

L'article 107i est déclenché lorsque les données de pharmacovigilance conduisent à envisager une action urgente : suspension ou retrait d'une AMM, interdiction de fourniture, refus de renouvellement ou, dans certaines circonstances, nouvelle contre-indication, réduction de dose ou restriction d'indication. Un État ou la Commission peut l'initier ; le titulaire ne peut pas déclencher lui-même cette procédure. [5]

Le PRAC évalue la question de sécurité et adopte une recommandation. Si au moins un produit centralisé est inclus, le CHMP adopte ensuite un avis ; si seuls des produits nationaux sont concernés, le CMDh adopte une position. L'objectif est qu'une même préoccupation ne conduise pas à des décisions incompatibles entre pays. [6,7;5,6;12,13]

18.3. Article 20 du règlement 726/2004

Lorsqu'un problème de pharmacovigilance concerne uniquement un ou plusieurs produits autorisés par la procédure centralisée, la procédure de l'article 20 du règlement 726/2004 est utilisée plutôt que l'article 107i. Cette distinction montre que la voie procédurale dépend à la fois de la nature du risque et du type d'autorisation. [6,7;5;6]

18.4. Maroc

Dans un système national, il n'existe pas le même besoin d'arbitrer entre plusieurs États et plusieurs AMM nationales juridiquement distinctes.

19. Fabrication, importation, certification des lots et Qualified Person

19.1. Autorisation de fabrication/importation

Dans l'EEE, fabriquer ou importer des médicaments depuis un pays tiers requiert une Manufacturing and Importation Authorisation pour les opérations couvertes. L'autorisation identifie les sites et activités autorisés. Le respect des GMP est une obligation continue, vérifiée par inspection. [37;5,37]

19.2. Qualified Person : responsabilité de certification

L'article 51 de la directive 2001/83/CE exige que chaque lot soit certifié par une Qualified Person avant libération sur le marché de l'EEE. La QP vérifie que le lot a été fabriqué et contrôlé conformément aux GMP, à l'AMM et aux exigences applicables. La certification QP ne doit pas être confondue avec l'OCABR : la première relève de la responsabilité de fabrication/libération de chaque lot ; l'OCABR ajoute un contrôle officiel indépendant pour certaines catégories biologiques. [37;18;5,37]

19.3. Importation depuis un pays tiers

Pour un produit importé, le site de certification QP situé dans l'EEE est considéré comme site d'importation réglementaire pour cette fonction. L'importation physique et la certification peuvent être réalisées sur des sites différents, à condition que les autorisations et accords techniques requis soient en place. Les accords de reconnaissance mutuelle avec certains pays peuvent modifier la nécessité de répéter certains contrôles, mais ils ne suppriment pas automatiquement toutes les responsabilités de la QP. [9]

19.4. Annex 16

L'Annex 16 du guide GMP détaille la certification par la QP et la libération des lots. La QP doit disposer d'informations suffisantes sur la chaîne de fabrication et de contrôle, les déviations, résultats, sites impliqués et conformité du lot. La certification est une décision documentée inscrite dans le système qualité pharmaceutique. [37;25]

19.5. Maroc

Le Maroc repose sur le pharmacien responsable et les obligations des établissements pharmaceutiques industriels, avec respect des bonnes pratiques de fabrication. La comparaison révèle une convergence sur la responsabilité pharmaceutique et la libération conforme, mais les concepts juridiques de QP européenne et de pharmacien responsable marocain ne doivent pas être déclarés identiques sans analyse de leurs responsabilités respectives article par article. [5,6,28,29]

20. Distribution en gros et bonnes pratiques de distribution

La qualité d'un médicament peut être compromise après sa fabrication. Les GDP encadrent donc réception, stockage, préparation, transport, retours, réclamations, rappels et traçabilité. Dans l'EEE, toute activité de distribution en gros nécessite normalement une Wholesale Distribution Authorisation délivrée par l'autorité nationale compétente. [38;22;5,38]

Le distributeur doit s'approvisionner auprès d'acteurs autorisés, maintenir les conditions de conservation pendant le stockage et le transport, éviter contamination et mélange, assurer une

rotation correcte des stocks et livrer au destinataire légitime. Un système de traçabilité doit permettre de retrouver rapidement les produits défectueux et d'exécuter un rappel. [22]

Après inspection, l'autorité peut émettre un certificat GDP ou un statement of non-compliance ; ces informations sont enregistrées dans EudraGMDP. La distribution devient ainsi une fonction contrôlée et visible à l'échelle du réseau. [14,37,38;38;25]

Au Maroc, la loi 27-26 inclut explicitement le contrôle des bonnes pratiques de distribution dans le périmètre d'inspection. Le benchmark montre donc une convergence normative, mais l'équivalent public d'EudraGMDP et la même architecture d'échange de certificats ne sont pas démontrés. [14,37,38]

21. Pharmacovigilance approfondie : RMP, PSUR/PSUSA, PASS et minimisation du risque

21.1. Risk Management Plan

Le RMP est soumis avec une demande d'AMM et accompagne ensuite le médicament lorsque son profil évolue. Il décrit les connaissances de sécurité, les risques importants identifiés ou potentiels, les informations manquantes, les activités permettant de mieux caractériser ces risques et les mesures destinées à les prévenir ou les réduire.

Le RMP n'est pas statique. Il doit être actualisé lorsque de nouvelles informations modifient substantiellement le profil bénéfice-risque ou le système de gestion des risques, à la demande de l'autorité ou lors de jalons importants. Depuis octobre 2023, l'EMA publie le corps principal et certaines annexes des RMP des produits centralisés, ce qui renforce la transparence. [4,40;7,10,14]

21.2. PSUR et liste EURD

Le PSUR est une réévaluation périodique structurée du rapport bénéfice-risque à partir des données accumulées pendant une période définie. Sa fréquence n'est pas simplement « tous les six mois » ou « chaque année » pour tous les médicaments. La liste EURD fixe, substance par substance, la date de référence, le data lock point, la fréquence et la date de soumission ; cette liste est juridiquement contraignante et peut primer sur la fréquence indiquée dans une AMM. [9;39,40]

21.3. PSUSA

Lorsque plusieurs médicaments contenant la même substance active sont autorisés dans différents États, l'Union évite des évaluations séparées des mêmes données. Une PSUSA réalise une évaluation unique des PSUR correspondants. Le résultat peut être le maintien sans

modification, mais aussi une variation de l'information produit ou d'autres mesures. Des procédures PSUSA publiées en 2026 illustrent ces deux résultats possibles. [39,40;25]

21.4. PASS

Une PASS vise à identifier, caractériser ou quantifier un risque, confirmer le profil de sécurité ou mesurer l'efficacité des mesures de minimisation. Elle peut être interventionnelle ou non interventionnelle selon sa conception. Les PASS peuvent être imposées par l'autorité ou réalisées volontairement dans le cadre du RMP. Pour les PASS non interventionnelles imposées, le PRAC intervient dans l'évaluation des protocoles et résultats selon la procédure applicable. [12,13;4,40;39,40]

21.5. Mesures de minimisation

La minimisation du risque peut être routinière - information produit, statut de prescription, conditionnement - ou additionnelle lorsque le risque l'exige : matériel éducatif, cartes patients, programmes contrôlés, outils de suivi ou autres mesures approuvées. Leur efficacité peut elle-même devoir être évaluée. La boucle réglementaire est donc : identifier le risque, choisir la mesure, mettre en œuvre, mesurer l'efficacité et réviser si nécessaire. [40]

21.6. Maroc

L'AMMPS a désormais explicitement relié l'organisation du responsable PV au PSMF. Pour aller jusqu'à une équivalence complète avec le système européen, il faudrait documenter dans les textes marocains applicables la structure attendue du RMP, les périodicités et mécanismes de rapports périodiques, les études post-AMM imposées et le circuit de décision. Lorsque ces éléments ne sont pas publiquement démontrés, ils doivent rester ND. [28,29;4,40;32,39, 40]

Tableau 4 Benchmark comparatif du système de pharmacovigilance dans l'Union européenne et au Maroc

Dimension comparée	Union européenne — système applicable	Maroc — cadre documenté / mise en œuvre 2026	Analyse comparative
Finalité de la pharmacovigilance	Surveillance continue de la sécurité des médicaments et gouvernance du rapport bénéfice-risque pendant tout le cycle de vie, à partir de multiples sources de données.	L'article 6 institue le système national et définit la pharmacovigilance ; le dispositif national vise la surveillance des effets indésirables et des risques liés aux médicaments.	Convergence forte de finalité : la sécurité n'est pas figée au moment de l'AMM.
Base organisationnelle	Système en réseau associant titulaires d'AMM, autorités nationales, EMA et comités scientifiques, avec procédures harmonisées européennes.	Système national marocain, renforcé par les articles 6 et 120 et par la mise en œuvre opérationnelle publiée par l'AMMPS en septembre 2026.	Convergence normative ; différence d'architecture supranationale/nationale.
ICSR — définition	L'Individual Case Safety Report est le rapport structuré d'un cas individuel de sécurité provenant notamment de professionnels de santé, patients, études, littérature	Le système national collecte des données de vigilance ; le corpus ne documente pas dans le même niveau de détail une architecture ICSR strictement équivalente à	Convergence de fonction de collecte ; équivalence technique complète = ND.

	ou autres sources prévues.	tous les flux européens.	
Collecte et traitement des cas	Titulaires et autorités collectent, valident et transmettent les cas selon les règles européennes applicables.	Collecte et traitement dans le système national ; flux, standards et délais doivent être documentés par les textes marocains spécifiques pour une comparaison terme à terme.	Fonction comparable, granularité procédurale différente/ND.
EudraVigilance	Base et réseau européen d'échange, de gestion et d'analyse des déclarations de sécurité, utilisés par les autorités et titulaires selon leurs obligations.	Système national/Centre national de vigilances ; le PDF précise qu'un équivalent complet d'EudraVigilance avec les mêmes flux ICSR n'est pas démontré.	Différence d'infrastructure documentée ; ne pas écrire qu'il n'existe aucune base marocaine.
Signal — définition	Information suggérant une association nouvelle potentiellement causale ou un nouvel aspect d'une association connue, nécessitant investigation.	Fonction nationale de détection/évaluation des signaux ; le corpus ne documente pas toute la chaîne avec la même granularité que l'UE.	Convergence conceptuelle/fonctionnelle, profondeur documentaire différente.
Signal ≠ causalité prouvée	La détection d'un signal déclenche une investigation ; elle ne prouve pas à elle seule un lien causal.	Même principe scientifique applicable à l'analyse de sécurité.	Convergence méthodologique importante.
Cycle de gestion d'un signal	Détection → validation → confirmation → analyse → priorisation → évaluation → recommandation/mesure réglementaire selon les procédures harmonisées.	Chaîne nationale d'évaluation à documenter plus précisément dans les textes/procédures applicables.	UE : procédure harmonisée détaillée ; Maroc : fonction démontrée mais granularité procédurale à approfondir.
PRAC	Le Pharmacovigilance Risk Assessment Committee joue un rôle central dans l'évaluation européenne des signaux, RMP, PSUR et PASS et formule des recommandations.	Pas d'équivalent institutionnel supranational attendu dans un système national ; fonctions exercées dans le cadre marocain par les structures compétentes.	Différence d'architecture, non absence de fonction.
RMP — fonction	Le Risk Management Plan décrit les connaissances de sécurité, risques importants identifiés/potentiels, informations manquantes, activités de PV et mesures de minimisation.	Pour conclure à une équivalence complète, le PDF indique qu'il faut encore documenter dans les textes marocains la structure attendue du RMP.	RMP européen très structuré ; équivalent marocain précis = ND dans le corpus.
RMP — cycle de vie	Soumis avec la demande d'AMM et actualisé lorsque de nouvelles informations modifient substantiellement le profil bénéfice-risque ou le système de gestion des risques, à la demande de l'autorité ou à certains jalons.	Cycle de mise à jour directement équivalent non démontré dans le corpus.	Différence/ND de granularité procédurale.
Transparence du RMP	Depuis octobre 2023, l'EMA publie le corps principal et certaines annexes des RMP des produits centralisés.	Le PDF ne documente pas un dispositif marocain public équivalent de publication systématique des RMP.	Différence de transparence documentée dans le corpus ; ne pas transformer ND en absence absolue.
PSUR — fonction	Le Periodic Safety Update Report réévalue périodiquement le rapport bénéfice-risque à partir des données accumulées pendant une période définie.	Les périodicités et mécanismes marocains de rapports périodiques doivent encore être documentés pour établir une équivalence complète.	Fonction européenne structurée ; équivalent détaillé marocain = ND.
Liste EURD	Fixe substance par substance la date de référence, le data lock point, la fréquence et la date de soumission des PSUR ; elle est juridiquement contraignante et peut primer sur la fréquence de l'AMM.	Équivalent national de même architecture non démontré dans le corpus.	Différence d'outil de coordination.
PSUSA	Évaluation unique européenne de PSUR pour plusieurs médicaments contenant la même substance,	Un mécanisme supranational de même type n'est pas attendu dans un système national ; procédure	Différence structurelle liée au réseau européen.

	évitant des évaluations nationales parallèles ; elle peut conduire à une variation ou d'autres mesures.	nationale précise à documenter.	
PASS — fonction	Étude post-autorisation visant à identifier, caractériser ou quantifier un risque, confirmer le profil de sécurité ou mesurer l'efficacité des mesures de minimisation.	Les études post-AMM imposées et leur circuit de décision doivent être documentés dans les textes marocains applicables avant de conclure à une équivalence.	Convergence possible de finalité ; équivalence réglementaire détaillée = ND.
PASS — statut	Une PASS peut être imposée ou volontaire dans le cadre du RMP ; selon sa conception elle peut être interventionnelle ou non interventionnelle.	Catégorisation et procédure directement équivalentes non démontrées dans le corpus.	Différence/ND de formalisation.
PASS imposée et PRAC	Pour certaines PASS non interventionnelles imposées, le PRAC intervient dans l'évaluation des protocoles et résultats selon la procédure applicable.	Pas d'équivalent PRAC attendu ; mécanisme national détaillé non documenté dans le PDF.	Différence d'architecture et de procédure.
Minimisation du risque — mesures routinières	Information produit, statut de prescription, conditionnement et autres mesures ordinaires peuvent réduire les risques.	Mesures nationales de gestion du risque applicables ; architecture complète à documenter selon les textes.	Convergence de principe.
Minimisation additionnelle	Matériel éducatif, cartes patients, programmes contrôlés, outils de suivi ou autres mesures peuvent être exigés lorsque les mesures routinières sont insuffisantes.	Équivalent détaillé et systématique non démontré dans le corpus.	Convergence possible de fonction ; granularité marocaine = ND.
Évaluation de l'efficacité de la minimisation	La boucle réglementaire est : identifier le risque → choisir la mesure → mettre en œuvre → mesurer son efficacité → réviser si nécessaire.	Procédure nationale équivalente avec mêmes outils/indicateurs non démontrée.	UE : boucle explicitement structurée ; Maroc : ND pour l'équivalence opérationnelle.
QPPV — UE	Le titulaire doit disposer en permanence d'une Qualified Person Responsible for Pharmacovigilance établie dans l'Union, responsable de la disponibilité et du fonctionnement du système de PV.	Le concept juridique de QPPV UE ne doit pas être transposé mot pour mot au Maroc.	Fonction de responsabilité dédiée comparable, statuts juridiques distincts.
Responsable PV — Maroc	Référence comparative : QPPV et permanence du système européen.	L'article 120 impose un pharmacien ou médecin exclusivement chargé de la PV sous la responsabilité du pharmacien responsable. La note AMMPS du 25/09/2026 opérationnalise cette exigence.	Convergence forte de responsabilité dédiée.
Résidence	La QPPV doit être établie dans l'Union selon le cadre applicable.	La note AMMPS du 25/09/2026 exige que le responsable PV réside au Maroc.	Convergence fonctionnelle sur l'ancrage territorial du responsable.
Temps plein / exclusivité	Le système européen exige la disponibilité permanente d'une QPPV et d'un système opérationnel ; l'organisation est décrite dans le PSMF.	Le responsable marocain doit être exclusivement chargé de la PV et exercer à plein temps selon la note 2026.	Renforcement opérationnel marocain clairement documenté.
Disponibilité 24 h/24 et 7 j/7	Le titulaire doit garantir en permanence le fonctionnement et l'accessibilité de la fonction de PV selon le cadre européen.	La note AMMPS impose une disponibilité 24 h/24 et 7 j/7.	Convergence forte de permanence de la fonction.
Compétences	Le système européen exige une QPPV disposant des compétences nécessaires et d'une autorité suffisante pour superviser le système.	La note AMMPS cite des compétences en pharmacovigilance, épidémiologie et biostatistique ; elles feront l'objet d'un examen dans le cadre de l'évaluation du PSMF.	Convergence renforcée et très concrète en 2026.
Délai de désignation	Sans équivalent ponctuel : les obligations européennes sont déjà	L'AMMPS demande la désignation du responsable concerné au plus	Mesure de mise en œuvre nationale datée, importante pour

marocain	intégrées au système permanent.	tard le 16 octobre 2026.	l'état documentaire du PFE.
PSMF — fonction	Le Pharmacovigilance System Master File décrit le système du titulaire : organisation, responsabilités, processus, systèmes, données et contrôle qualité. Ce n'est pas un rapport de sécurité sur un produit particulier.	Le PSMF est explicitement mentionné par l'AMMPS en 2026 dans l'évaluation de l'organisation/compétences du responsable PV.	Convergence terminologique et fonctionnelle majeure par rapport à une lecture antérieure du système marocain.
PSMF — équivalence	Structure et obligations encadrées par le système européen ; localisation/identifiant intégrés aux systèmes réglementaires.	La note 2026 ne démontre pas que le PSMF marocain est juridiquement et techniquement identique au PSMF européen.	Convergence renforcée, mais équivalence complète non démontrée.
Du signal à la décision	Après évaluation : aucune action, surveillance renforcée, modification RCP/notice, communication de sécurité, minimisation additionnelle, PASS, restriction d'indication, suspension ou retrait.	Le système national peut conduire à des mesures réglementaires de sécurité ; le circuit détaillé doit être documenté selon les textes/procédures marocains.	Convergence de finalité décisionnelle ; architecture et granularité différentes.
Information produit et communication de sécurité	Les résultats de PV peuvent modifier le RCP/notice et conduire à des communications directes aux professionnels ou autres mesures de gestion du risque.	Les mesures nationales de sécurité peuvent affecter l'information et la communication ; la comparaison détaillée est traitée au T20.	Convergence de fonction ; renvoi au tableau dédié.
Surveillance tout au long du cycle de vie	La PV accompagne le médicament avant et après AMM, avec réévaluation continue du bénéfice-risque.	Le système national instauré par l'article 6 et renforcé par l'article 120 s'inscrit dans une logique continue de vigilance.	Convergence fondamentale.
Ce qui est désormais démontré au Maroc	QPPV + PSMF font partie de l'architecture européenne établie.	Responsable PV dédié : pharmacien/médecin ; résidence Maroc ; plein temps ; 24/7 ; compétences précisées ; PSMF explicitement mentionné par l'AMMPS en septembre 2026.	Convergence organisationnelle nettement renforcée ; il serait dépassé d'écrire que le PSMF est exclusivement européen.
Ce qui reste ND au Maroc	EudraVigilance, procédures harmonisées de signaux, RMP, EURD/PSUR, PSUSA, PASS et outils européens sont documentés de manière détaillée.	Le corpus ne démontre pas encore une équivalence complète des flux ICSR/EudraVigilance, de la structure RMP, des périodicités PSUR, des PASS imposées ou du circuit complet de décision.	ND = équivalence précise non démontrée, jamais absence.
Conclusion du benchmark	Système intégré : EudraVigilance + QPPV/PSMF + PRAC + signal management + RMP + PSUR/PSUSA + PASS + minimisation du risque.	Système national renforcé en 2026 : articles 6/120, responsable PV dédié et opérationnalisé, PSMF explicitement intégré ; certaines infrastructures et procédures détaillées restent à documenter.	Convergence forte et croissante sur l'organisation de la PV ; différence/ND surtout sur l'infrastructure de données, la coordination et certains instruments spécialisés.

La pharmacovigilance constitue l'un des domaines où le benchmark montre une convergence marocaine particulièrement renforcée en 2026. Les articles 6 et 120 structurent le système national et la responsabilité dédiée ; surtout, la note AMMPS du 25 septembre 2026 rend cette organisation opérationnelle en imposant un responsable pharmacovigilance résident au Maroc, à plein temps, disponible 24 h/24 et 7 j/7, avec des compétences spécifiques, et en reliant explicitement son évaluation au PSMF. Il serait donc incorrect de présenter désormais le PSMF comme un élément exclusivement européen. En revanche, le corpus ne permet pas d'assimiler juridiquement et techniquement le PSMF marocain au PSMF européen ni de démontrer un équivalent complet d'EudraVigilance, des mécanismes RMP/PSUR/PSUSA/PASS ou de toute la chaîne harmonisée européenne. Le résultat est une convergence forte de l'organisation interne, avec différence/ND sur l'infrastructure et certaines procédures spécialisées.

22. Information produit, étiquetage, publicité et communication du risque

Dans l'Union, le Summary of Product Characteristics est le document scientifique de référence destiné aux professionnels ; la notice traduit l'information essentielle pour le patient ; l'étiquetage porte les mentions réglementaires nécessaires sur les conditionnements. Ces documents font partie de l'AMM et leurs modifications nécessitent une procédure réglementaire. [5]

La communication de sécurité peut aussi prendre la forme d'une Direct Healthcare Professional Communication lorsqu'une information urgente ou importante doit être portée directement aux professionnels. La communication n'est donc pas une activité marketing : elle fait partie des mesures de gestion du risque lorsqu'elle est approuvée ou requise. [40]

La publicité des médicaments est encadrée séparément afin d'éviter qu'une communication promotionnelle compromette l'usage rationnel. Au Maroc, l'article 131 bis place explicitement le contrôle de la publicité dans la surveillance du marché. La comparaison doit distinguer publicité, information produit autorisée et communication de sécurité. [29;5,29]

23. Produits particuliers : orphelins, pédiatrie, ATMP et hospital exemption

La désignation orpheline intervient avant l'AMM et répond à des critères spécifiques. Elle donne accès à des incitations ; l'AMM d'un médicament orphelin passe par la procédure centralisée. Dans le droit actuellement applicable, l'exclusivité de marché est normalement de dix ans, avec mécanismes de réduction ou d'extension pédiatrique selon les conditions. Le nouveau paquet modifiera ce modèle lorsqu'il deviendra applicable. [1-4;6,7;41;42;39,40]

Le développement pédiatrique est organisé autour du PIP. Le développeur ne peut pas simplement décider de ne pas étudier l'enfant lorsqu'un PIP est requis : il doit obtenir un accord, une dérogation ou un report. Les récompenses pédiatriques sont liées au respect des obligations. [42;25]

Les ATMP couvrent thérapie génique, thérapie cellulaire somatique et ingénierie tissulaire. Leur fabrication et leur suivi soulèvent des questions spécifiques de variabilité, persistance, traçabilité et suivi à long terme. Ils relèvent de la centralisée. [43;25]

L'hospital exemption constitue un mécanisme particulier pour certains ATMP préparés de façon non routinière, selon des normes de qualité spécifiques, utilisés dans un hôpital d'un même État membre sous responsabilité médicale individuelle et sous autorisation nationale. Elle n'est pas une voie commerciale parallèle à l'AMM centralisée. [43;25]

Le corpus marocain 17-04/27-26 ne fournit pas un ensemble spécialisé de même granularité. Le benchmark doit donc conserver la catégorie D/ND selon la fonction précise, plutôt que conclure globalement à une absence de réglementation des produits innovants. [25]

Tableau 5 Matrice finale de synthèse du benchmark réglementaire Union européenne–Maroc

Dimension comparée	Union européenne — situation / référentiel	Maroc — situation documentée	Résultat comparatif / portée
Gouvernance réglementaire	Réseau NCAs–EMA–Commission ; expertise, évaluation, coordination et décision réparties selon les procédures.	AMMPS comme agence nationale spécialisée, avec compétences renforcées par les réformes étudiées.	Architecture différente ; fonctions réglementaires comparables sans équivalence institutionnelle terme à terme.
Logique générale du système	Régulation distribuée et supranationale, avec mécanismes de coordination entre États membres.	Régulation nationale centralisée autour des autorités marocaines compétentes.	Différence structurelle ; ne constitue pas en soi un indicateur de performance.
Essais cliniques	CTR 536/2014 + CTIS ; dépôt coordonné ; évaluation et décision par les États membres ; transparence intégrée.	Cadre national + lignes directrices AMMPS 2026 ; infrastructure multinationale équivalente à CTIS non démontrée.	Convergence d'encadrement ; différence d'infrastructure et de coordination.
Conseil scientifique / développement	Scientific advice, PRIME et autres mécanismes d'accompagnement dans le réseau européen.	Accompagnement national possible selon les procédures applicables ; équivalent PRIME de même architecture non démontré.	Convergence possible de soutien réglementaire ; spécialisation UE plus documentée.
AMM standard	Plusieurs voies : centralisée, nationale, MRP, DCP ; centralisée 210 jours actifs, hors clock-stops.	AMM nationale, notamment art. 7, avec exigences CTD documentées.	Ne pas comparer le nombre de voies ; comparer dossier, évaluation, décision et résultat.
AMM accélérée	Procédure accélérée centralisée : 150 jours actifs lorsque les critères sont remplis.	Équivalent procédural strict de même architecture non démontré dans le corpus.	Différence procédurale documentée/ND.
Futur délai européen d'AMM	Le paquet 2026 prévoit un futur objectif de 180 jours actifs dans le cadre stabilisé décrit par le corpus.	Pas d'équivalent direct identifié dans la loi 27-26.	Évolution future UE vers simplification ; non applicable au 30/09/2026.
Validité de l'AMM — droit actuel	Renouvellement normalement à cinq ans, puis validité généralement illimitée.	Régime national de renouvellement selon le cadre marocain applicable.	Convergence de gestion du cycle de vie ; règles juridiques propres.
Validité de l'AMM — futur UE	Le futur paquet prévoit une AMM illimitée par défaut, avec possibilité de limitation lorsque la sécurité le justifie.	Pas d'équivalent direct documenté dans 27-26.	Futur cadre UE, à ne pas présenter comme droit applicable au 30/09/2026.
AMM conditionnelle	CMA avec obligations spécifiques et renouvellement annuel selon le droit actuel.	Art. 8 bis : autorisation avec données incomplètes sous cinq conditions cumulatives et obligations complémentaires.	Convergence forte de logique ; détails juridiques propres.
Circonstances exceptionnelles / urgence	Exceptional circumstances distinctes de la CMA ; mécanismes européens propres.	Autorisation exceptionnelle d'utilisation d'urgence prévue dans le cadre marocain étudié.	Catégories non équivalentes terme à terme.
Accès précoce	PRIME, compassionate use et autres mécanismes distincts selon leurs bases juridiques.	Mécanismes nationaux à analyser séparément ; équivalents précis non démontrés pour chaque outil européen.	Convergence d'objectif possible ; outils différents.
Génériques	Voies abrégées fondées sur la référence au médicament de référence et cadre harmonisé.	Exigences CTD spécifiques documentées par l'AMMPS en 2026.	Convergence scientifique et réglementaire importante.
Biosimilaires	Comparabilité structurée qualité/non-clinique/clinique selon le cadre européen.	Lignes directrices CTD AMMPS 2026 pour les biosimilaires.	Convergence scientifique renforcée ; profondeur documentaire à comparer.
Exemption Bolar	Mécanisme juridique européen permettant certaines études avant expiration des protections.	Équivalent juridique identique non démontré dans le corpus.	ND, et non affirmation d'absence.
Protections réglementaires	Droit actuel 8+2+1 ; futur paquet modifie l'architecture des protections lorsqu'il deviendra applicable.	Modèle identique d'exclusivité réglementaire non démontré.	Différence de politique d'incitation/protection.
Médicaments orphelins	Désignation, procédure centralisée, incitations et exclusivité de marché spécifiques.	Paquet spécialisé équivalent non établi dans 17-04/27-26.	Différence de spécialisation ; ne pas conclure à absence de réglementation des maladies rares.
Développement pédiatrique	PIP, waivers, deferrals et récompenses pédiatriques structurés.	Mécanisme équivalent complet non établi dans le corpus.	Différence de spécialisation réglementaire.
ATMP	Cadre spécifique, centralisée, exigences particulières de fabrication, traçabilité et suivi.	Paquet réglementaire de même granularité non démontré.	Différence de spécialisation.
Hospital exemption	Mécanisme particulier pour certains ATMP non routiniers, sous conditions strictes et autorisation nationale.	Équivalent précis non démontré.	ND ; ne pas assimiler à une voie commerciale parallèle.
Pharmacovigilance — gouvernance	EudraVigilance, QPPV, PSMF, RMP, PSUR/PSUSA, PASS, PRAC et procédures harmonisées.	Arts. 6/120 ; responsable PV dédié, résident au Maroc, plein temps et disponibilité 24/7 selon note AMMPS du 25/09/2026 ; PSMF explicitement mentionné.	Convergence organisationnelle nettement renforcée en 2026.
PSMF	Dossier maître réglementaire du système PV, structuré dans le cadre européen.	PSMF explicitement documenté par l'AMMPS en 2026.	Convergence terminologique/fonctionnelle ; identité juridique et technique complète non démontrée.
Base de cas PV	EudraVigilance avec flux ICSR harmonisés et réseau européen.	Système national/Centre national de vigilances ; équivalent complet d'EudraVigilance non démontré.	Différence d'infrastructure ; élément à conserver ND.
Détection des signaux	Processus harmonisé, rôle du PRAC et publication de recommandations.	Fonction nationale de détection/évaluation ; granularité procédurale comparable non entièrement documentée.	Convergence de fonction, profondeur procédurale différente.
Referrals / réévaluation de sécurité	Articles 31, 107i et 20 ; PRAC puis CHMP ou CMDh selon le champ.	Capacité nationale à réévaluer et modifier/suspendre/retirer les AMM pour sécurité ; arbitrage inter-États non	Convergence de finalité ; architecture supranationale spécifique à l'UE.

Dimension comparée	Union européenne — situation / référentiel	Maroc — situation documentée	Résultat comparatif / portée
		pertinent.	
Inspection pharmaceutique	Article 111, inspections répétées/inopinées, approche fondée sur le risque, possibilité d'inspections de pays tiers.	Arts. 130-131, inspections AMMPS, contrôle des bonnes pratiques.	Convergence de fonction importante.
EudraGMDP	Base partagée pour MIA/WDA, certificats GMP/GDP et certaines non-conformités.	Base publique nationale de même périmètre non démontrée.	Différence d'infrastructure/transparence ; ND.
GMP/BPF	Référentiel européen détaillé et inspections associées.	Respect des BPF par les établissements pharmaceutiques industriels.	Convergence forte de principe qualité.
GDP/BPD	Cadre européen de distribution en gros, WDA, GDP et contrôle des opérateurs.	BPD et contrôle de la distribution documentés dans le cadre national.	Convergence fonctionnelle ; infrastructure de certificats différente.
Fabrication/importation	MIA, GMP, contrôle des sites et importations depuis pays tiers.	Autorisation et contrôle des établissements pharmaceutiques industriels/importations selon le droit national.	Convergence de contrôle des opérateurs.
Qualified Person	Certification de chaque lot par une QP conformément au cadre UE et à l'Annex 16.	Responsabilité centrale du pharmacien responsable ; équivalence juridique QP/pharmacien responsable non démontrée.	Convergence fonctionnelle partielle, non-équivalence juridique.
Libération fabricant vs contrôle officiel	Certification QP du lot distincte de l'OCABR pour certains biologiques.	Responsabilité fabricant/pharmacien responsable distincte du certificat officiel AMMPS pour vaccins/sérums.	Convergence conceptuelle forte sur les deux niveaux de contrôle.
Défauts qualité / rappels	Rapid Alert, classification et coordination en réseau.	Art. 131 bis : alertes, retraits et rappels.	Convergence de mission ; procédure détaillée et réseau différents.
Falsification	Unique identifier, dispositif anti-effraction, repositories et decommissioning selon le cadre applicable.	Art. 131 bis : prévention/détection des médicaments falsifiés ou de qualité inférieure.	Convergence de finalité ; sérialisation pack par pack équivalente non démontrée.
Sérialisation / répertoire	Infrastructure de vérification et désactivation des identifiants selon le règlement 2016/161.	Système national avec répertoire et désactivation pack par pack équivalent non démontré.	À conserver ND tant qu'une source plus précise n'est pas obtenue.
Libération officielle des lots biologiques	OCABR/OMCL, guidelines produit-spécifiques et reconnaissance en réseau.	Vaccins/sérums : certificat officiel ; délais 60 jours ordinaire, 30 jours campagne/PNI, 7 jours pour certains lots importés ; analyses si nécessaire.	Convergence fonctionnelle forte ; architecture de réseau différente.
Responsabilité après contrôle officiel	OCABR ne supprime pas la responsabilité du fabricant/QP.	Le certificat officiel ne transfère pas la responsabilité du fabricant/pharmacien responsable.	Convergence juridique de principe très nette.
Pénuries — gouvernance	MSSG, ESMP, liste de médicaments critiques et mécanismes coordonnés.	Obligations d'approvisionnement et stocks de sécurité, notamment autour de l'art. 15.	Convergence d'objectif de continuité d'approvisionnement.
ESMP	Plateforme européenne structurée de données sur disponibilité, offre et demande, obligatoire dans son champ depuis 2025.	Plateforme nationale comparable à ESMP non démontrée.	Différence d'outil ; ND.
Médicaments critiques	Liste de l'Union et analyses de vulnérabilité/prévention.	Liste publique nationale structurée exactement de même type non démontrée.	Différence de coordination/documentation.
Futur paquet UE — pénuries	Renforcement futur de la prévention, plans et notifications anticipées, dont six mois dans les situations couvertes.	Pas d'équivalent direct établi dans 27-26.	Futur cadre UE ; distinguer des obligations marocaines actuelles.
Critical Medicines Act	Instrument distinct du Code pharmaceutique : capacités, diversification, projets stratégiques, résilience et achats collaboratifs.	Pas d'équivalent direct traité dans le corpus marocain.	Comparaison de politique industrielle, distincte de l'AMM.
Données réglementaires	SPOR/PMS/IDMP structurent substances, produits, organisations et référentiels.	Transformation numérique AMMPS démontrée ; standards nationaux de même architecture non démontrés.	Écart d'écosystème de données documenté.
TARKHISS	Sans équivalent direct unique : l'UE dispose de plusieurs plateformes spécialisées.	Plateforme AMMPS lancée en mars 2026 ; première phase explicitement centrée sur cosmétiques/hygiène corporelle.	Numérisation nationale démontrée ; ne pas l'assimiler à CTIS/SPOR/PMS pour les médicaments.
ePI / FHIR	Information produit électronique structurée ; guide v1.0.0 publié le 17/09/2026 sur HL7 FHIR.	Équivalent national ePI/FHIR non démontré.	Différence d'interopérabilité ; ND.
DARWIN EU / RWE	Réseau fédéré de données du monde réel utilisé pour soutenir les besoins réglementaires.	Réseau RWE national comparable à DARWIN EU non démontré.	Différence de spécialisation et d'infrastructure ; ND.
IA réglementaire	Principes EMA/FDA de bonne pratique de l'IA en 2026 et réflexion sur l'usage de l'IA dans le cycle de vie.	Cadre pharmaceutique spécifique de même granularité non établi dans le corpus.	Domaine émergent ; différence documentaire.
Regulatory sandbox	Le futur paquet introduit des sandboxes réglementaires sous supervision ; préparation opérationnelle en 2026.	Regulatory sandbox pharmaceutique équivalente non démontrée.	Futur mécanisme UE ; ND au Maroc.
Environnement / ERA	Évaluation environnementale intégrée au cadre UE, renforcée dans le futur paquet.	Équivalent du futur dispositif européen renforcé non établi dans le corpus.	Différence de spécialisation à documenter sans nier les politiques environnementales nationales.
Antibiorésistance	Mesures de bon usage et futur mécanisme d'incitation pour certains antimicrobiens prioritaires.	Actions de santé publique contre l'AMR ; mécanisme d'exclusivité transférable comparable non documenté.	Convergence d'objectif de santé publique, différence d'outil économique/réglementaire.
Transferable exclusivity voucher	Futur mécanisme : une année supplémentaire de protection du marché	Pas d'équivalent direct dans 27-26.	Différence d'incitation ; futur cadre UE non applicable au 30/09/2026.

Dimension comparée	Union européenne — situation / référentiel	Maroc — situation documentée	Résultat comparatif / portée
	selon les règles du paquet, avec garde-fous décrits dans le corpus.		
HTA	Règlement HTA applicable depuis janvier 2025 ; JCA progressivement déployées.	L'HTA doit être traité comme interface avec la régulation, et non comme fonction identique de l'AMMPS.	Différence d'architecture ; AMM ≠ prix/remboursement.
JCA — calendrier	Nouveaux anticancéreux et ATMP d'abord ; orphelins en 2028 ; tous les nouveaux médicaments en 2030.	Calendrier national équivalent non documenté.	Spécificité de coopération européenne.
Prix et remboursement	Les décisions nationales de prix, valeur et remboursement restent aux États membres malgré le JCA.	Cadre national propre ; ne pas attribuer automatiquement ces fonctions à l'AMMPS.	Convergence sur la distinction AMM / accès financé.
Transparence réglementaire	EPAR, information produit, PRAC, CTIS, EudraGMDP, informations de pénuries et autres publications distribuées.	Lignes directrices, notes, alertes et documents opérationnels AMMPS ; intensification importante en 2026.	Convergence de transparence institutionnelle ; profondeur documentaire différente.
Rapports publics d'évaluation	EPAR pour les médicaments centralisés.	Rapport public d'évaluation systématique équivalent non démontré.	ND ; une ligne directrice publique n'est pas un EPAR.
Cycle de vie post-AMM	Classification détaillée IA/IAIN, IB, II, extensions, grouping, worksharing, PACMP et autres outils.	Modifications et renouvellements existent ; nomenclature/procédures strictement équivalentes non démontrées.	Convergence de fonction ; granularité procédurale UE supérieure dans le corpus.
Lignes directrices variations 2026	Révision applicable depuis le 15/01/2026, avec outils de simplification comme l'annual update.	Équivalent public de même granularité non démontré.	Actualisation importante du référentiel UE.
Information produit	SmPC/RCP, notice et étiquetage intégrés à l'AMM et au cycle post-AMM.	Information produit réglementée dans le cadre national.	Convergence forte de fonction.
Communication de sécurité	DHPC et autres communications encadrées, distinctes de la publicité et des alertes qualité.	Alertes/informations AMMPS ; procédure DHPC strictement équivalente non démontrée.	Convergence de finalité ; mécanisme précis ND.
Publicité	Cadre distinct de l'information produit et de la communication de sécurité.	Art. 131 bis : contrôle de la publicité explicitement intégré à la surveillance du marché.	Convergence nette de mission.
Résultat transversal 1 — fonctions essentielles	Système mature couvrant l'ensemble des fonctions centrales et spécialisées du cycle de vie.	Réformes 2024-2026 renforcent PV, inspection, contrôle du marché, rappels, falsification, autorisations avec données incomplètes et contrôle officiel des lots.	Convergence réelle au niveau des fonctions réglementaires de base.
Résultat transversal 2 — données et coordination	CTIS, EudraVigilance, EudraGMDP, ESMP, SPOR/PMS, ePI et DARWIN EU forment un écosystème spécialisé interconnecté.	Numérisation en progression, mais équivalents complets de plusieurs infrastructures non démontrés.	Les différences les plus nettes concernent intégration des données et coordination.
Résultat transversal 3 — spécialisation	Couches spécialisées pour orphelins, pédiatrie, ATMP, HTA, RWE, IA et sandboxes.	Réforme étudiée davantage centrée sur la consolidation des fonctions centrales du Code.	Différence de granularité ; ne doit pas être utilisée comme mesure directe de performance.
Résultat transversal 4 — UE en transition	Réforme orientée vers simplification, réduction de certains délais, allègement de renouvellements systématiques, pénuries et données interopérables.	Le benchmark marocain doit être comparé au droit UE actuel tout en signalant la direction du futur référentiel.	Éviter de comparer le Maroc actuel à des règles UE qui ne sont pas encore applicables.
Résultat transversal 5 — benchmark vivant	Le référentiel UE et les publications réglementaires évoluent continuellement.	En 2026 : responsable PV/PSMF explicités, TARKHISS lancé, check-list de libération des lots actualisée.	Le benchmark doit toujours être daté et actualisé.
ND — définition méthodologique	Sans objet : l'UE sert de référentiel comparatif pour les fonctions analysées.	ND signifie que l'équivalent fonctionnel précis n'a pas été démontré par les sources juridiques et institutionnelles publiques examinées.	ND ne signifie jamais « absent ».
ND — EudraVigilance	Flux ICSR européens harmonisés et base de réseau.	Équivalent complet avec mêmes flux ICSR non démontré.	Conserver ND.
ND — EudraGMDP	Base publique européenne de certificats/autorisations/non-conformités.	Base publique GMP/GDP comparable non démontrée.	Conserver ND.
ND — sérialisation	Répertoire et désactivation pack par pack dans le cadre 2016/161.	Système équivalent non démontré.	Conserver ND.
ND — ESMP	Plateforme structurée de pénuries et données d'approvisionnement.	Plateforme nationale comparable non démontrée.	Conserver ND.
ND — SPOR/IDMP/PMS	Architecture de données de référence harmonisée.	Standards nationaux de même architecture non démontrés.	Conserver ND.
ND — ePI FHIR	Information produit structurée et interopérable.	Équivalent ePI FHIR non démontré.	Conserver ND.
ND — DARWIN EU	Réseau fédéré de RWE pour besoins réglementaires.	Réseau national comparable non démontré.	Conserver ND.
ND — sandbox pharmaceutique	Futur mécanisme réglementaire UE pour innovations/méthodologies.	Équivalent légal pharmaceutique non démontré.	Conserver ND.
ND — orphelins/pédiatrie/ ATMP	Ensemble de mécanismes spécialisés, obligations et incitations.	Ensemble équivalent dans sa totalité non démontré.	Conserver ND ; ne pas conclure à absence globale de réglementation.
Ce que le benchmark mesure	Architecture, base juridique, acteurs, procédures, outils/données et résultat réglementaire.	Même grille appliquée au système marocain.	Benchmark réglementaire et fonctionnel.
Ce que le benchmark ne mesure pas	Il ne démontre pas à lui seul la performance réelle d'un système.	Même limite pour le Maroc.	Aucun classement de performance ne peut être déduit de la seule architecture.
Indicateurs	Délais réels, résultats d'inspection,	Les mêmes indicateurs empiriques	Une étude de performance nécessiterait

Dimension comparée	Union européenne — situation / référentiel	Maroc — situation documentée	Résultat comparatif / portée
nécessaires pour mesurer la performance	conformité, volumes/qualité des déclarations, traitement des signaux, pénuries, rappels, disponibilité, etc.	comparables seraient nécessaires au Maroc.	un protocole empirique distinct.
Conclusion générale	Le référentiel UE se caractérise surtout par une forte profondeur de cycle de vie, des procédures harmonisées, des bases spécialisées et des mécanismes transfrontaliers.	Les réformes marocaines récentes structurent davantage les fonctions essentielles de régulation, avec plusieurs convergences fortes et plusieurs équivalents spécialisés encore ND.	Convergence importante des fonctions de base ; différences surtout d'architecture, d'interopérabilité et de spécialisation, sans jugement de performance.

Cette matrice finale confirme que la réforme marocaine 2024-2026 rapproche plusieurs fonctions essentielles du référentiel européen, notamment en pharmacovigilance, inspection, surveillance du marché, rappels, lutte contre la falsification, autorisations avec données incomplètes et contrôle officiel des lots. Les différences les plus marquées se situent moins dans l'existence des fonctions fondamentales que dans leur degré de spécialisation, l'intégration des données, la coordination entre autorités et l'existence d'infrastructures réglementaires dédiées. Le système européen ajoute des couches spécialisées — CTIS, EudraVigilance, EudraGMDP, ESMP, SPOR/PMS, ePI, DARWIN EU, HTA/JCA, régimes orphelins/pédiatriques/ATMP et futur sandbox — qui ne doivent pas être transformées mécaniquement en critères de performance. La conclusion correcte est donc celle d'une convergence fonctionnelle importante sur le socle réglementaire, associée à des différences d'architecture, d'interopérabilité et de granularité.

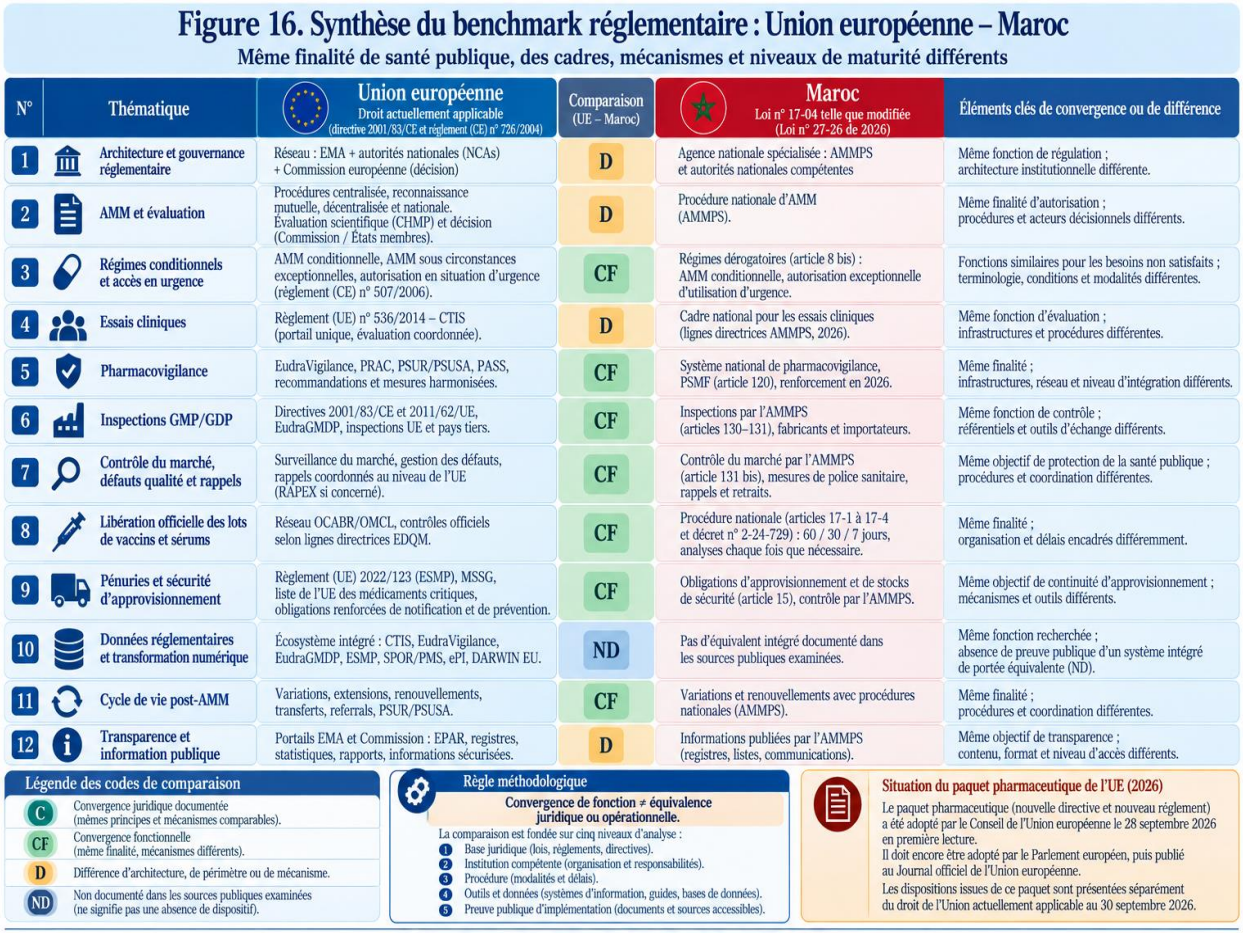


Figure 42 Synthèse du benchmark réglementaire : Union européenne

Cette figure constitue la lecture de synthèse de l'ensemble de l'Axe 3. Elle regroupe les principales fonctions réglementaires et les code selon la grille méthodologique : C pour convergence juridique documentée, CF pour convergence fonctionnelle avec mécanismes différents, D pour différence d'architecture/périmètre/mécanisme et ND pour information non documentée. Elle doit être présentée comme une synthèse descriptive du benchmark, non comme un score de maturité ou un classement de performance.